

Buku Ajar **KEPERAWATAN GERONTIK**

Deni Metri • Dewi Srimauli Simorangkir • Friska Br Sembiring
Destria Efliani • Septi Ardianty

Editor: Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.



BUKU AJAR: KEPERAWATAN GERONTIK

Penulis:

Ns Deni Metri, S. Kep., M.Kes.
Ns. Dewi Srimauli Simorangkir, M.Kep.
Friska Br Sembiring, S. Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Destria Efliani, S.Kep., MM., M.Kep.
Septi Ardianty, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Buku Ajar: Keperawatan Gerontik

Penulis:

Ns Deni Metri, S. Kep., M.Kes.
Ns. Dewi Srimauli Simorangkir, M.Kep.
Friska Br Sembiring, S. Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Destria Efliani, S.Kep., MM., M.Kep.
Septi Ardianty, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7927-13-2

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Gerontik ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, serta tenaga kesehatan yang memerlukan pemahaman komprehensif mengenai asuhan keperawatan pada lanjut usia.

Peningkatan usia harapan hidup membawa konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah lanjut usia dengan kebutuhan kesehatan yang semakin kompleks. Proses penuaan tidak hanya menimbulkan perubahan biologis, tetapi juga berkaitan dengan perubahan psikologis, sosial, spiritual, serta kemampuan fungsional individu. Kondisi tersebut menuntut perawat untuk memiliki kompetensi dalam melakukan pengkajian secara menyeluruh, mengenali berbagai sindrom geriatri, menentukan masalah keperawatan, serta memberikan intervensi yang aman, tepat, berbasis bukti, dan berorientasi pada upaya mempertahankan kemandirian serta kualitas hidup lansia.

Buku ini membahas berbagai permasalahan penting dalam praktik keperawatan gerontik, antara lain frailty, sarcopenia dan risiko disabilitas; delirium; ulkus tekan dan perawatan kulit; malnutrisi, dehidrasi dan gangguan menelan (dysphagia); serta polifarmasi dan keselamatan obat pada lansia. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada pemahaman konsep, tetapi juga pada proses pengkajian gerontik komprehensif, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan dan pelaksanaan intervensi, evaluasi, edukasi kepada lansia dan keluarga, keselamatan pasien, hingga kolaborasi interprofesional.

Penyusunan buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang mengintegrasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan Sub-CPMK dengan berbagai aktivitas pembelajaran. Mahasiswa diarahkan untuk berkembang secara bertahap dari kemampuan memahami dan menganalisis konsep hingga mampu mendemonstrasikan serta menerapkan keterampilan dalam situasi praktik. Oleh karena itu, buku ini dilengkapi dengan studi kasus, aktivitas *Knows How* dan *Shows How*, skenario OSCE, SOP keterampilan, rubrik penilaian, DOPS, portofolio, *case report*, refleksi *patient safety*, tabel *red flags* dan eskalasi, serta checklist evaluasi diri mahasiswa.

Asuhan keperawatan yang disajikan dalam buku ini juga diarahkan pada penggunaan standar profesi keperawatan Indonesia melalui integrasi Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Dengan demikian,

mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan penalaran klinis, keterampilan prosedural, komunikasi terapeutik, sikap profesional, serta kemampuan mengambil keputusan yang mengutamakan keselamatan dan martabat lansia.

Kami menyadari bahwa perkembangan ilmu keperawatan gerontik berlangsung sangat dinamis seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, serta bukti ilmiah terbaru. Oleh karena itu, buku ini diharapkan tidak hanya digunakan sebagai bahan pembelajaran di kelas dan laboratorium keterampilan, tetapi juga sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berpikir kritis, dan menerapkan praktik keperawatan berbasis bukti dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, pemikiran, dan masukan selama proses penyusunan buku ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada editor, sejawat akademisi, praktisi keperawatan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sehingga buku ini dapat terselesaikan.

Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
---------------	-----

DAFTAR ISI	v
------------------	---

BAB 1 *FRAILTY, SARCOPENIA*, DAN RISIKO DISABILITAS..... 1

A. Pendahuluan	5
B. Konsep <i>Frailty</i> pada Lansia.....	5
C. Konsep Sarcopenia	10
D. Risiko Disabilitas pada Lansia	13
E. Pengkajian Gerontik Komprehensif	14
F. Diagnosis Keperawatan.....	17
G. Luaran Keperawatan.....	19
H. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	20
I. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	21
J. DOPS (<i>Does</i>).....	32
K. Ringkasan Materi.....	38
L. Tabel <i>Red Flags</i> & Eskalasi.....	39
M.Referensi	42

BAB 2 DELIRIUM: DETEKSI DINI, TATA LAKSANA KEPERAWATAN, DAN PENCEGAHAN..... 45

A. Konsep Teori Delirium	46
B. Instrumen Skrining Nursing Delirium Screening Scale	47
C. Aktivitas 1- <i>Knows How</i>	48
D. Aktivitas 2- <i>Shows How</i>	48
E. DOPS (<i>Does</i>).....	56
F. Ringkasan Materi.....	61
G. Tabel <i>Red Flags</i> & Eskalasi.....	63
H. Referensi	65

BAB 3 ULKUS TEKAN DAN PERAWATAN KULIT LANSIA: PENCEGAHAN HINGGA PERAWATAN LUKA..... 67

A. Ulkus Tekan	68
B. Perawatan Kulit	83
C. Perawatan Luka	86
D. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	89
E. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	90

F. DOPS (<i>Does</i>).....	107
G. Ringkasan Materi.....	117
H. Tabel <i>Red Flags</i> & Eskalasi.....	118
I. Referensi.....	120

BAB 4 MALNUTRISI, DEHIDRASI, DAN MASALAH MENELAN

(DYSPHAGIA) PADA LANSIA.....	125
A. Malnutrisi.....	128
B. Masalah Menelan Dispagia pada Lasia	130
C. Dehidrasi pada lansia.....	132
D. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	136
E. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	137
F. DOPS (<i>Does</i>).....	147
G. Ringkasan Materi.....	154
H. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	154
I. Referensi.....	156

BAB 5 POLIFARMASI & KESELAMATAN OBAT PADA LANSIA

(KOLABORASI INTERPROFESIONAL).....	159
A. Polifarmasi pada lansia.....	160
B. Keselamatan obat pada lansia.....	163
C. Kriteria Obat pada Lansia	164
D. Klasifikasi Polifarmasi	166
E. Faktor Resiko Polifarmasi pada Lansia.....	166
F. Alat Skrining Polifarmasia.....	166
G. Peran Tenaga Kesehatan	167
H. <i>Evidence Base</i> Polifarmasi pada Lansia	167
I. Latihan Soal	169
J. Rangkuman Materi	170
K. Glosarium	171
L. Referensi	171

PROFIL PENULIS.....	173
----------------------------	------------

BAB 1

FRAILITY, SARCOPENIA, DAN RISIKO DISABILITAS

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, kepatuhan aspek legal, dan advokasi hak lansia dalam praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-5
CPL-2	Menguasai konsep penuaan dan perubahan biopsikososial-spiritual untuk memahami kebutuhan kesehatan lansia.	CPMK-1
CPL-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur.	CPMK-4; CPMK-3
CPL-5	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan lansia, keluarga, serta tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Menerapkan mutu–keselamatan pasien, dokumentasi, dan continuity of care dalam asuhan keperawatan lansia.	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar keperawatan gerontik dan proses penuaan untuk menjelaskan kebutuhan biopsikososial-spiritual lansia.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etika, hak lansia, dan aspek legal dalam pengambilan keputusan serta advokasi pada praktik keperawatan.
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, frailty, dan risiko utama.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur serta evaluasi.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan pada lansia serta keluarga secara empatik, kultural, dan kolaboratif.
CPMK-6	Mengelola dokumentasi, <i>continuity of care</i> , serta strategi mutu–keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Ruang Lingkup Keperawatan Gerontik dan Peran Perawat	1.1 Menguraikan ruang lingkup keperawatan gerontik, terminologi kunci, dan kebutuhan layanan lansia.	1.2 Mengidentifikasi peran, fungsi, dan kompetensi perawat dalam tim geriatri serta alur layanan promotif–paliatif.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-6
Bab 2. Teori Penuaan & Perubahan Biopsikososial-Spiritual pada Lansia	2.1 Membedakan teori/konsep penuaan dan implikasinya terhadap respon kesehatan lansia.	2.2 Menganalisis perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia sebagai dasar intervensi holistik.	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-5
Bab 3. Etika, Hak Lansia, dan Isu Legal dalam Praktik Keperawatan	3.1 Menerapkan prinsip etika dalam penyelesaian kasus-kasus keperawatan gerontik.	3.2 Menjelaskan hak lansia, <i>informed consent</i> , kerahasiaan, dan isu legal (penelantaran, kekerasan, kapasitas keputusan).	CPMK-2	CPMK-5; CPMK-6
Bab 4. Pengkajian Gerontik Komprehensif (CGA): ADL/IADL, frailty, risiko	4.1 Melakukan CGA terstruktur menggunakan instrumen ADL/IADL, skrining <i>frailty</i> , kognitif, <i>mood</i> , nutrisi, dan risiko jatuh.	4.2 Mensintesis temuan CGA menjadi masalah prioritas, risiko, dan kebutuhan rujukan/kolaborasi.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-6
Bab 5. Diagnosa Keperawatan Gerontik & Perencanaan Asuhan Berbasis Evidence	5.1 Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik berbasis data dengan prioritas yang jelas.	5.2 Menyusun rencana asuhan berbasis evidence (tujuan terukur, intervensi, evaluasi) dan indikator hasil.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-6
Bab 6. Komunikasi Terapeutik dengan Lansia & Keluarga (kultural dan empatik)	6.1 Menerapkan teknik komunikasi terapeutik pada lansia secara empatik dan adaptif terhadap keterbatasan sensori/kognitif.	6.2 Merancang edukasi kesehatan dan counseling keluarga dengan pendekatan kultural, <i>health literacy</i> , dan <i>shared decision-making</i> .	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-2

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Dokumentasi, Continuity of Care, dan Pengantar Mutu–Keselamatan Pasien Lansia	7.1 Menyusun dokumentasi asuhan gerontik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta mendukung transisi perawatan.	7.2 Menganalisis risiko keselamatan pasien lansia dan strategi pencegahan insiden berbasis mutu.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 8. Frailty, Sarcopenia, dan Risiko Disabilitas	8.1 Menilai frailty dan sarcopenia serta keterkaitannya dengan disabilitas dan outcome.	8.2 Merancang intervensi keperawatan/kolaboratif untuk pencegahan dan penanganan frailty–sarcopenia.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4
Bab 9. Jatuh pada Lansia: Skrining Risiko, Pencegahan, dan Rehabilitasi	9.1 Melakukan skrining risiko jatuh dan identifikasi faktor intrinsik–ekstrinsik.	9.2 Menyusun paket pencegahan jatuh dan rencana rehabilitasi dasar pasca-jatuh termasuk edukasi lingkungan aman.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6
Bab 10. Delirium: Deteksi Dini, Tata Laksana Keperawatan, dan Pencegahan	10.1 Melakukan deteksi dini delirium dan identifikasi faktor pemicu menggunakan alat skrining sederhana.	10.2 Menyusun intervensi keperawatan nonfarmakologis, monitoring, dan pencegahan delirium secara kolaboratif.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
Bab 11. Ulkus Tekan & Perawatan Kulit Lansia: Pencegahan hingga Perawatan Luka	11.1 Mengidentifikasi risiko ulkus tekan dan langkah pencegahan berbasis <i>repositioning</i> serta perawatan kulit.	11.2 Merencanakan perawatan luka dasar (asesmen luka, balutan, nyeri) dan rujukan sesuai tingkat keparahan.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6
Bab 12. Inkontinensia Urin/Feses dan Asuhan Keperawatan Terintegrasi	12.1 Mengkaji tipe/derajat inkontinensia dan dampaknya pada kualitas hidup serta risiko komplikasi.	12.2 Merancang asuhan terintegrasi dan edukasi (latihan, manajemen cairan, higiene, alat bantu) dengan evaluasi terukur.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
Bab 13. Malnutrisi, Dehidrasi, dan Masalah Menelan (Dysphagia) pada Lansia	13.1 Melakukan skrining malnutrisi, dehidrasi, dan dysphagia serta menetapkan risiko aspirasi.	13.2 Menyusun intervensi nutrisi–hidrasi aman (modifikasi tekstur, posisi, pemantauan) dan evaluasi <i>outcome</i> .	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
Bab 14. Polifarmasi & Keselamatan Obat pada Lansia	14.1 Mengidentifikasi polifarmasi, obat berisiko tinggi, dan potensi interaksi/efek	14.2 Merancang strategi keselamatan obat: rekonsiliasi obat, edukasi kepatuhan, dan	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
(kolaborasi interprofesional)	samping melalui <i>medication review</i> sederhana.	komunikasi interprofesional untuk <i>deprescribing</i> bila perlu.		

A. Pendahuluan

Setelah usia 50 tahun, sekitar 1–2% massa otot hilang setiap tahun. Dengan demikian, kehilangan massa otot secara terus-menerus seiring penuaan (Sieber, 2012). Penuaan merupakan proses alami yang ditandai dengan penurunan fungsi fisiologis, termasuk berkurangnya massa, kekuatan, dan kualitas otot yang dikenal sebagai sarcopenia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Rosenberg pada tahun 1988 yang mana sarcopenia berasal dari bahasa Yunani *sarx* artinya “daging” dan *penia* “kehilangan” untuk menggambarkan kehilangan otot rangka yang berkaitan dengan usia (Pizzorno & Murray, 2021). Kondisi ini bersifat multifaktorial, melibatkan perubahan metabolisme protein, hormon, inflamasi kronis, serta dipengaruhi oleh faktor gaya hidup seperti in-aktivitas fisik dan asupan nutrisi yang tidak adekuat.

Sarcopenia memiliki hubungan yang erat dengan *frailty* (kerentanan), yaitu kondisi penurunan cadangan fisiologis yang menyebabkan lansia lebih rentan terhadap stresor. Kedua kondisi ini saling memperburuk dan berkontribusi terhadap penurunan fungsi fisik, peningkatan risiko jatuh, serta ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Secara epidemiologis, prevalensi sarcopenia meningkat seiring bertambahnya usia, bahkan dapat mencapai lebih dari 40% pada usia lanjut, sehingga menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan *frailty* (Nicholson & Barkham, 2023).

Kombinasi sarcopenia dan *frailty* merupakan determinan penting terjadinya risiko disabilitas pada lansia, yang ditandai dengan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan penurunan kualitas hidup. Kondisi ini juga berhubungan dengan peningkatan angka hospitalisasi, mortalitas, serta beban ekonomi dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga kondisi ini sangat penting sebagai dasar dalam pengkajian dan intervensi keperawatan gerontik untuk mencegah dan meminimalkan dampak disabilitas pada lansia.

B. Konsep *Frailty* pada Lansia

1. Definisi

Frailty secara klinis dipahami sebagai kondisi kerentanan yang meningkatkan risiko seseorang terhadap berbagai kejadian merugikan, seperti jatuh berulang, cedera, frekuensi rawat inap yang tinggi, serta perkembangan disabilitas dan morbiditas. Pada populasi lansia, istilah *frailty* kerap dipersepsikan secara negatif, sehingga mereka jarang mengidentifikasi dirinya sebagai individu yang “rapuh” (Nicholson & Barkham, 2023).

Frailty merupakan suatu sindrom klinis yang ditandai dengan adanya minimal tiga dari beberapa kriteria berikut, yaitu penurunan berat badan yang tidak disengaja sekitar 4,5 kg dalam satu tahun terakhir, kelelahan yang dirasakan sendiri, penurunan kekuatan otot yang diukur melalui kekuatan genggam tangan, kecepatan berjalan yang melambat, serta rendahnya tingkat aktivitas fisik (Kennedy-Malone & Duffy, 2023).

Frailty didefinisikan juga sebagai akumulasi defisit kesehatan, yaitu sebagai kondisi yang terjadi akibat penumpukan berbagai masalah kesehatan terkait penuaan, seperti penyakit kronis (misalnya diabetes dan penyakit kardiovaskular), penurunan fungsi kognitif, gangguan mobilitas, penurunan status nutrisi, serta disabilitas (Kim & Rockwood, 2024).

Frailty dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi kerentanan pada lansia yang ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan cadangan fisiologis, sehingga meningkatkan risiko berbagai kejadian merugikan. Kondisi ini dapat dipahami sebagai sindrom klinis dengan kriteria tertentu, seperti penurunan berat badan, kelelahan, kelemahan, perlambatan, dan rendahnya aktivitas fisik, maupun sebagai hasil akumulasi berbagai masalah kesehatan terkait penuaan. Secara keseluruhan, *frailty* mencerminkan penurunan kemampuan tubuh dalam mempertahankan keseimbangan dan beradaptasi terhadap stresor. Akibatnya, individu dengan *frailty* memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai luaran buruk, seperti disabilitas, jatuh, komplikasi, hingga kematian.

2. Etiologi dan Faktor Risiko

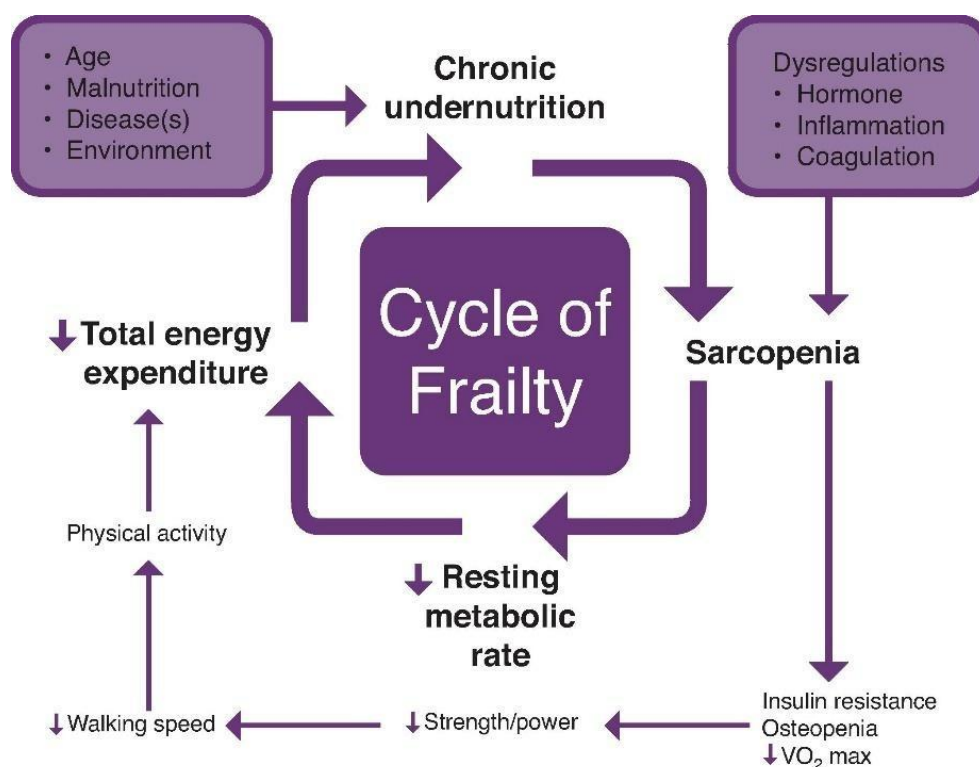
Frailty merupakan kondisi multifaktorial yang tidak memiliki satu penyebab tunggal. Secara umum, etiologi *frailty* berkaitan dengan proses penuaan yang disertai akumulasi kerusakan pada tingkat molekuler, seluler, dan sistem organ, sehingga menyebabkan penurunan cadangan fisiologis dan kemampuan adaptasi terhadap stresor (Ross et al., 2023). *Frailty* sering dipandang sebagai hasil akhir dari berbagai proses patologis yang saling berinteraksi sepanjang kehidupan. Beberapa mekanisme utama yang berperan dalam terjadinya *frailty* meliputi penurunan massa dan kekuatan otot (sarkopenia), disfungsi sistem neuroendokrin, peningkatan inflamasi kronis (*inflammaging*), gangguan metabolisme, serta penurunan fungsi organ (Cruz-Jentoft et al., 2019).

Adapun faktor risiko *frailty* meliputi berbagai aspek (Nicholson & Barkham, 2023), antara lain faktor usia lanjut, penyakit kronis, multi-morbiditas, status malnutrisi, penurunan berat badan, kurang aktivitas fisik, penurunan mobilitas, dan riwayat jatuh.

3. Patofisiologi

Patologi dan patofisiologi *frailty* merupakan suatu proses yang saling berkaitan dan terjadi secara bertahap. *Frailty* berawal dari akumulasi kerusakan pada tingkat molekuler dan seluler yang menyebabkan penurunan cadangan fisiologis pada berbagai sistem tubuh. Tidak terdapat satu penyebab tunggal, namun perubahan utama terjadi pada jaringan otot, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot serta berkurangnya serabut otot tipe II yang berperan dalam menghasilkan kekuatan dan daya kontraksi.

Perubahan struktural tersebut kemudian berkembang menjadi gangguan fungsional yang membentuk suatu siklus penurunan (gambar 1). Berbagai faktor seperti penuaan, malnutrisi, penyakit kronis, dan faktor lingkungan memicu terjadinya kekurangan nutrisi kronis yang berkontribusi terhadap disregulasi sistem tubuh, termasuk gangguan hormonal, peningkatan proses inflamasi, dan perubahan sistem metabolik.



Gambar 1.1
Patofisiologi Siklus Frailty (Nicholson & Barkham, 2023)

Kondisi ini selanjutnya menyebabkan sarkopenia yang ditandai dengan penurunan kekuatan dan performa otot. Dampaknya terlihat pada penurunan kemampuan fisik, seperti berkurangnya kekuatan dan daya, melambatnya kecepatan berjalan, serta menurunnya aktivitas fisik. Penurunan aktivitas ini akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran energi total dan diikuti dengan

penurunan laju metabolisme basal, yang pada akhirnya semakin memperburuk status nutrisi dan mempercepat kehilangan massa otot.

Siklus tersebut berlangsung secara progresif dan saling memperburuk, sehingga cadangan fisiologis tubuh semakin menurun dan kemampuan adaptasi terhadap stresor menjadi terbatas. Akibatnya, individu dengan *frailty* menjadi lebih rentan mengalami berbagai luaran negatif, seperti jatuh, disabilitas, hingga peningkatan risiko kematian.

4. Klasifikasi

Frailty dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan yang digunakan dalam praktik klinis.

a. Klasifikasi dengan pendekatan Fenotif *Frailty* Fisik

Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam mengklasifikasikan *frailty* adalah fenotipe *frailty* fisik, yang berfokus menilai kondisi fisik individu berdasarkan lima kriteria klinis, yaitu penurunan berat badan yang tidak disengaja, kelelahan, kelemahan (kekuatan genggam tangan), perlambatan kecepatan berjalan, dan rendahnya aktivitas fisik. Berdasarkan jumlah kriteria yang terpenuhi, klasifikasi *frailty* dibagi sebagai berikut (Dent et al., 2019):

- 1) *Robust* (tidak *frail*): tidak memenuhi satu pun kriteria
- 2) *Pre-frail*: memenuhi 1–2 kriteria
- 3) *Frail*: memenuhi ≥ 3 kriteria

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa *frailty* berkembang secara bertahap, dari kondisi sehat hingga menjadi lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan.

b. Klasifikasi berdasarkan Akumulasi Defisit Kesehatan (*Frailty Index*)

Klasifikasi dengan pendekatan akumulasi defisit (*frailty index*) digunakan untuk menilai *frailty* pada lansia dengan kondisi yang kompleks dan multidimensional, terutama ketika terdapat berbagai penyakit kronis saling berinteraksi. Pendekatan ini menilai kondisi individu berdasarkan jumlah defisit kesehatan yang dimiliki. Defisit yang dimaksud dapat mencakup berbagai aspek, seperti penyakit kronis, fungsi fisik dan kognitif, status nutrisi, serta tingkat kemandirian. Berdasarkan nilai *frailty index*, derajat *frailty* umumnya diklasifikasikan sebagai berikut (Tocchi, 2016):

- 1) *Frailty* ringan (*mild frailty*)
- 2) *Frailty* sedang (*moderate frailty*)
- 3) *Frailty* berat (*severe frailty*)

5. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis *frailty* pada lansia umumnya ditandai dengan penurunan cadangan fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap stresor, sehingga berdampak pada berbagai aspek fisik, fungsional, dan kesehatan secara umum. Manifestasi klinisnya meliputi:

- a. Penurunan kekuatan otot (*weakness*) ditandai dengan melemahnya kekuatan genggam tangan dan berkurangnya kemampuan melakukan aktivitas fisik.
- b. Kelelahan (*exhaustion*) yaitu lansia sering merasa lelah, tidak bertenaga, dan mudah kehabisan energi meskipun melakukan aktivitas ringan.
- c. Penurunan kecepatan berjalan (*slow walking speed*) dan sering disertai gangguan keseimbangan.
- d. Penurunan aktivitas fisik sehari-hari maupun aktivitas fisik karena keterbatasan energi dan kemampuan.
- e. Penurunan berat badan yang tidak disengaja (*unintentional weight loss*) biasanya berkaitan dengan penurunan nafsu makan atau masalah metabolik.
- f. Kerentanan terhadap stresor, artinya lansia menjadi lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat infeksi ringan, perubahan lingkungan, atau kondisi medis lainnya.
- g. Peningkatan risiko jatuh dan disabilitas, cedera, rawat inap, serta keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari.
- h. Penurunan kualitas hidup ditandai dengan meningkatnya ketergantungan, isolasi sosial, serta penurunan kesejahteraan secara keseluruhan.

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan *frailty* bersifat multikomponen dan bertujuan untuk memperlambat *progress*, mempertahankan fungsi fisik, serta mencegah terjadinya disabilitas. Pendekatan yang terbukti efektif mencakup intervensi fisik, nutrisi, psikososial, dan farmakologis yang disesuaikan dengan kondisi individu lansia.

- a. Latihan fisik multi-komponen merupakan intervensi lini pertama pada *frailty*. Program ini mengombinasikan latihan resistensi untuk meningkatkan kekuatan otot, latihan keseimbangan dan koordinasi untuk mengurangi risiko jatuh. Salah satu contoh latihan multi-komponen yang sudah dilakukan dan terbukti meningkatkan kekuatan otot lansia adalah latihan fisik kombinasi terstruktur Otago, *Locomotion Training*, dan *Resistance Training* (OLORE) (Sahar et al., 2025). Latihan dirancang secara bertahap dan idealnya dilakukan 2–3 kali per minggu di bawah pengawasan tenaga kesehatan atau terapis.
- b. Optimalisasi nutrisi. Kecukupan asupan protein dan kalori sangat penting dalam penatalaksanaan *frailty*. Suplementasi protein atau asam amino esensial

direkomendasikan pada lansia yang mengalami penurunan berat badan atau malnutrisi. Vitamin D juga dipertimbangkan pada lansia dengan kadar vitamin D rendah karena berkaitan dengan kelemahan otot dan risiko jatuh. Kolaborasi dengan ahli gizi diperlukan untuk merancang pola makan yang sesuai kebutuhan individu.

- c. Manajemen kondisi kronis dan polifarmasi. Penyakit kronis yang tidak terkontrol, seperti diabetes, hipertensi, dan depresi, dapat mempercepat progres *frailty*. Penatalaksanaan komprehensif mencakup *review* obat-obatan secara berkala untuk mengidentifikasi poli-farmasi yang berpotensi merugikan, terutama obat-obatan yang meningkatkan risiko jatuh seperti sedatif, anti-hipertensi dosis tinggi, dan diuretik.

C. Konsep Sarcopenia

1. Definisi

Sarcopenia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan massa otot rangka yang disertai dengan penurunan kekuatan dan/atau fungsi otot, yang terjadi secara progresif seiring proses penuaan dan berdampak pada penurunan kemampuan fisik serta peningkatan risiko disabilitas (Rolland et al., 2017).

Sarkopenia adalah penyakit muskuloskeletal yang umumnya didefinisikan sebagai penurunan massa otot dan kekuatan otot secara progresif, terutama pada populasi lanjut usia. Diagnosis sarkopenia mencakup penurunan pada kekuatan otot, penurunan jumlah atau kualitas otot, serta penurunan kinerja fisik (Cruz-Jentoft et al., 2019).

Sarkopenia adalah kondisi degeneratif terkait penuaan yang tidak hanya menurunkan massa dan kekuatan otot, tetapi juga berdampak luas pada kesehatan, termasuk peningkatan risiko disabilitas, kematian, dan penurunan fungsi kognitif (Shiratsuchi et al., 2026).

Sarkopenia disimpulkan sebagai penyakit muskuloskeletal yang terjadi secara progresif seiring proses penuaan, ditandai dengan penurunan massa otot, kekuatan otot, serta fungsi atau kinerja fisik. Kondisi ini terutama dialami oleh lansia dan berdampak pada menurunnya kemampuan fisik serta meningkatnya risiko disabilitas, sehingga menjadi masalah kesehatan penting yang perlu diperhatikan.

2. Etiologi dan Faktor Risiko

Etiologi sarkopenia umumnya dikaitkan dengan proses alami penuaan, yang belum sepenuhnya dipahami dan bersifat multi-faktorial. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangannya meliputi penurunan ukuran dan

jumlah serat otot tipe II, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, resistensi insulin, penurunan kadar androgen dan faktor pertumbuhan dalam serum, asupan protein yang tidak memadai, serta respons sintesis protein otot (*Muscle Protein Synthesis*/MPS) yang menurun terhadap konsumsi protein atau latihan resistensi.

Faktor risiko dari sarkopenia sebagian dapat disebabkan oleh, beberapa penyakit kronis yang berdampak negatif pada sistem muskuloskeletal dan aktivitas fisik. Penyakit-penyakit tersebut meliputi penyakit paru obstruktif kronis (COPD), gagal jantung kronis (CHF), penyakit ginjal kronis (CKD), diabetes melitus (DM), human immuno-deficiency virus (HIV), dan kanker. Secara teoretis, peran proses penyakit ini terhadap sarkopenia dapat terjadi terutama melalui efek langsung pada fungsi otot, atau secara tidak langsung melalui penurunan aktivitas fisik atau pembatasan asupan kalori (Ardeljan & Hurezeanu, 2023).

3. Patofisiologi

Otot rangka terdiri dari dua jenis serat. Serat otot tipe II (cepat) memiliki potensi glikolitik lebih tinggi, kapasitas oksidatif lebih rendah, dan respons yang lebih cepat dibandingkan serat otot tipe I (lambat). Serat otot tipe I dikenal sebagai serat yang tahan terhadap kelelahan karena memiliki kepadatan mitokondria, kapiler, dan kandungan mioglobin yang lebih tinggi. Sebagian besar otot terdiri dari kedua jenis serat ini, kecuali otot postural yang hanya terdiri dari serat otot tipe I.

Patofisiologi sarkopenia bersifat kompleks dan multi-faktorial, yang melibatkan berbagai perubahan pada sistem tubuh seiring proses penuaan. Salah satu mekanisme utama adalah penuaan neuromuskular, di mana terjadi penurunan jumlah neuron motorik, perubahan pada saraf perifer, serta gangguan pada sambungan neuromuskular yang berkontribusi terhadap berkurangnya jumlah dan fungsi serat otot. Selain itu, terjadi atrofi yang terutama mengenai serat otot tipe II (*fast-twitch*), yaitu serat yang berperan penting dalam kekuatan dan kecepatan kontraksi otot.

Perubahan hormonal juga berperan besar, ditandai dengan penurunan hormon anabolik seperti *growth hormone* (GH), *insulin-like growth factor-1* (IGF-1), testosteron, dan estrogen, serta peningkatan hormon katabolik seperti kortisol. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi protein otot sehingga mempercepat kehilangan massa otot.

Kondisi resistensi insulin turut memperburuk kondisi karena otot rangka merupakan jaringan utama yang sensitif terhadap insulin. Penurunan sensitivitas ini tidak hanya menghambat metabolisme otot, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan metabolik. Selain itu, peningkatan faktor inflamasi seperti sitokin pro-

inflamasi (misalnya TNF- α dan IL-6) pada lansia menyebabkan inflamasi kronis tingkat rendah yang berdampak negatif pada kekuatan dan massa otot.

Interaksi antara otot dan jaringan lemak juga berperan melalui sekresi myokines dan adipokines, yang memengaruhi metabolisme tubuh secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu, terjadi peningkatan massa lemak, terutama lemak viseral, yang disertai penurunan massa otot, sehingga menimbulkan kondisi yang dikenal sebagai obesitas sarkopenik. Kombinasi ini memperburuk resistensi insulin dan inflamasi, sehingga membentuk siklus yang saling memperparah antara kehilangan otot dan peningkatan lemak tubuh. (Araújo et al., 2025; Aslam et al., 2023; Ardeljan & Hurezeanu, 2023; Kim & Choi, 2013).

4. Manifestasi Klinis

Manifestasi sarkopenia umumnya berkembang secara bertahap dan terutama terlihat pada penurunan fungsi fisik pada lansia. Kondisi ini ditandai dengan:

a. Penurunan kekuatan dan massa otot

Ditandai dengan berkurangnya kekuatan otot yang sering menjadi gejala awal, seperti mudah lelah, kesulitan mengangkat barang, serta melemahnya kekuatan genggam tangan. Selain itu, terjadi penurunan massa otot yang terlihat dari mengecilnya ukuran otot tubuh.

b. Penurunan performa fisik

Meliputi kecepatan berjalan yang melambat, kesulitan bangun dari posisi duduk, naik tangga, serta gangguan keseimbangan.

c. Peningkatan risiko jatuh dan disabilitas

Penurunan kekuatan dan keseimbangan meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Pada tahap lanjut, kondisi ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari (disabilitas) dan menurunkan kemandirian.

d. Penurunan kualitas hidup

Ditandai dengan berkurangnya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari serta meningkatnya ketergantungan pada orang lain.

e. Kelelahan kronis, penurunan aktivitas fisik, peningkatan risiko penyakit metabolik, serta pada beberapa kasus dapat berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif pada lansia.

5. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan sarcopenia berfokus pada upaya mempertahankan dan meningkatkan massa otot, kekuatan, serta fungsi fisik melalui pendekatan non-farmakologis yang didukung oleh intervensi nutrisi dan, dalam kondisi tertentu, farmakoterapi. Tujuan utamanya adalah memperlambat laju kehilangan otot,

meningkatkan kemandirian fungsional, dan mencegah komplikasi seperti jatuh dan disabilitas.

- a. Latihan resistensi (*resistance training*) merupakan intervensi yang paling efektif dalam penatalaksanaan sarcopenia karena secara langsung merangsang sintesis protein otot dan hipertrofi serat otot, terutama serat tipe II. Program latihan mencakup penggunaan beban ringan, pita elastis, atau berat badan sendiri sebagai tahanan. Latihan dilakukan secara terstruktur 2–3 kali per minggu, dimulai dari intensitas rendah dan ditingkatkan secara progresif sesuai kemampuan lansia. Peran perawat meliputi edukasi cara latihan yang aman, pemantauan respons fisik, serta motivasi agar lansia mematuhi program secara konsisten.
- b. Asupan protein yang adekuat merupakan komponen esensial dalam penatalaksanaan sarcopenia karena protein menyediakan substrat untuk sintesis protein otot (*muscle protein synthesis*/MPS). Rekomendasi asupan protein untuk lansia dengan sarcopenia adalah 1,2–1,5 gram per kilogram berat badan per hari, dengan distribusi merata di setiap waktu makan. Sumber protein berkualitas tinggi yang dianjurkan meliputi telur, ikan, daging tanpa lemak, produk susu, dan kacang-kacangan.
- c. Suplementasi vitamin D yang adekuat. Defisiensi vitamin D sering ditemukan pada lansia dengan sarcopenia dan berhubungan dengan kelemahan otot, penurunan kekuatan, serta peningkatan risiko jatuh. Pemenuhan kebutuhan vitamin D juga dapat didukung melalui paparan sinar matahari pagi yang cukup dan konsumsi makanan sumber vitamin D seperti ikan berlemak dan produk susu.

D. Risiko Disabilitas pada Lansia

1. Definisi

Disabilitas pada lansia merupakan kondisi keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (*Activities of Daily Living*/ADL) maupun aktivitas instrumental (*Instrumental Activities of Daily Living*/IADL) akibat gangguan fisik, kognitif, atau psikososial (Araújo et al., 2025; Nicholson & Barkham, 2023; Thomas, 2012). Disabilitas tidak hanya mencerminkan adanya penyakit, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara penurunan fungsi tubuh dengan faktor lingkungan dan sosial seperti lansia memerlukan bantuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi, mandi, dan ambulasi. Disabilitas sering dipandang sebagai hasil akhir dari proses penurunan fungsi yang progresif, termasuk *frailty* dan sarcopenia.

Disabilitas fungsional pada lansia berkaitan erat dengan penurunan mobilitas, kekuatan otot, serta kemampuan mempertahankan kemandirian.

Kondisi ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas hidup lansia dan sering digunakan sebagai parameter dalam pelayanan kesehatan geriatri.

2. Hubungan *Frailty* dan Sarcopenia dengan Disabilitas

Frailty merupakan sindrom pra-disabilitas yang ditandai dengan penurunan cadangan fisiologis sehingga individu menjadi lebih rentan terhadap stresor dan memiliki risiko tinggi mengalami disabilitas (Morley, 2016). Salah satu komponen utama yang berkontribusi terhadap *frailty* adalah sarcopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot yang berperan langsung dalam penurunan fungsi fisik.

Hasil literatur (Dong et al., 2024) menunjukkan bahwa sarcopenia berhubungan signifikan dengan disabilitas fungsional pada lansia, terutama dalam hal mobilitas dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, hubungan antara sarcopenia dan *frailty* bersifat saling memperkuat; lansia dengan sarcopenia memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami *frailty*, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya disabilitas.

Kondisi ini sering terjadi secara bersamaan (*overlap*), bahkan dapat disertai dengan malnutrisi, yang secara signifikan meningkatkan ketergantungan fungsional pada lansia. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *frailty* dan sarcopenia tidak hanya menjadi faktor risiko, tetapi juga merupakan bagian dari jalur patofisiologis yang mengarah pada terjadinya disabilitas.

3. Dampak Disabilitas

Disabilitas pada lansia memiliki dampak yang luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, disabilitas menyebabkan penurunan mobilitas, peningkatan risiko jatuh, serta ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga berkaitan dengan peningkatan angka hospitalisasi dan mortalitas pada lansia.

Selain itu, disabilitas berdampak pada aspek psikologis, seperti meningkatnya risiko depresi, perasaan tidak berdaya, dan penurunan kualitas hidup. Lansia dengan *frailty* dan sarcopenia juga dilaporkan mengalami penurunan fungsi fisik dan kekuatan yang berkontribusi terhadap *distress* emosional dan penurunan kesejahteraan (Touhy & Jett, 2016; Miller, 2023; Irgat & Kızıltan, 2025).

E. Pengkajian Gerontik Komprehensif

Pengkajian Gerontik Komprehensif atau *Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)* merupakan suatu proses multi-dimensional dan interdisiplin yang bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan lansia secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, fungsional, kognitif, psikologis, sosial, dan lingkungan (Kennedy-Malone & Duffy, 2023; Miller, 2023). CGA menjadi pendekatan utama dalam keperawatan gerontik

karena mampu mengidentifikasi masalah kesehatan secara dini, termasuk frailty, sarcopenia, dan risiko disabilitas, sehingga dapat dirancang intervensi yang tepat dan terintegrasi.

CGA tidak hanya berfokus pada diagnosis medis, tetapi juga menilai kemampuan fungsional dan kualitas hidup lansia. Dalam konteks *frailty* dan sarcopenia, CGA berperan penting untuk mendeteksi penurunan kekuatan otot, mobilitas, serta kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Hasil pengkajian ini menjadi dasar dalam penyusunan diagnosis keperawatan, penentuan luaran, serta perencanaan intervensi yang bersifat individual dan berkelanjutan.

1. Pengkajian Fisik

Pengkajian fisik pada lansia dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan *head to toe* untuk mengidentifikasi perubahan fisiologis akibat penuaan maupun adanya gangguan patologis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini kondisi yang berkontribusi terhadap *frailty*, sarcopenia, dan risiko disabilitas. Aspek yang dikaji meliputi:

- a. Kepala dan leher: status kesadaran, fungsi penglihatan dan pendengaran, kondisi mulut dan gigi (yang dapat memengaruhi status nutrisi).
- b. Sistem kardiovaskular: tekanan darah, nadi, tanda perfusi, adanya edema.
- c. Sistem respirasi: pola napas, frekuensi napas, adanya sesak atau bunyi napas tambahan.
- d. Sistem muskuloskeletal: kekuatan otot, rentang gerak sendi, adanya nyeri atau deformitas, serta kemampuan mobilisasi.
- e. Sistem integumen: kondisi kulit, risiko luka tekan (dekubitus), elastisitas, dan hidrasi.
- f. Sistem gastrointestinal: nafsu makan, status nutrisi, pola eliminasi.
- g. Sistem genitourinaria: fungsi berkemih, inkontinensia.
- h. Sistem neurologis: koordinasi, keseimbangan, refleks, serta risiko jatuh.

Pengkajian ini sangat penting untuk mengidentifikasi penurunan kekuatan otot, gangguan mobilitas, serta kondisi kronis yang dapat memperburuk *frailty* dan sarcopenia.

2. Pengkajian *Frailty*

Pengkajian *frailty* bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan lansia terhadap stresor dan risiko kejadian buruk seperti jatuh dan disabilitas. Beberapa instrumen yang sering digunakan antara lain:

- a. *Fried Frailty Phenotype*, yang menilai lima kriteria yaitu penurunan berat badan tidak disengaja, kelelahan, kelemahan (kekuatan genggam), aktivitas fisik rendah, dan kecepatan berjalan lambat. Lansia dikategorikan sebagai frail apabila memenuhi ≥ 3 kriteria.

- b. *Clinical Frailty Scale* (CFS), yang mengklasifikasikan tingkat frailty berdasarkan penilaian klinis terhadap fungsi dan kemandirian lansia, mulai dari sangat bugar hingga sangat *frail*.

3. Pengkajian Sarcopenia

Pengkajian sarcopenia dilakukan untuk menilai penurunan massa otot, kekuatan, dan performa fisik. Pendekatan yang umum digunakan mengacu pada rekomendasi *European Working Group on Sarcopenia in Older People* (EWGSOP), yang menekankan tiga komponen utama, yaitu:

- a. Kekuatan otot, yang dapat diukur menggunakan *handgrip strength*
- b. Massa otot, yang dapat dinilai melalui pemeriksaan seperti bioelectrical impedance analysis (BIA) atau dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)
- c. Performa fisik, misalnya melalui pengukuran kecepatan berjalan (*gait speed*)

4. Pengkajian Tingkat Kemandirian

Pengkajian disabilitas bertujuan untuk menilai tingkat kemandirian lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Instrumen yang umum digunakan meliputi:

- a. *Katz Index of Activities of Daily Living* (ADL), yang menilai kemampuan dasar seperti mandi, berpakaian, makan, toileting, berpindah, dan kontinensia
- b. *Lawton Instrumental Activities of Daily Living* (LIADL), yang menilai kemampuan aktivitas yang lebih kompleks seperti menggunakan telepon, mengelola keuangan, berbelanja, dan menggunakan transportasi.

5. Pengkajian Psikologis

Pengkajian psikologis bertujuan untuk menilai kondisi mental dan fungsi kognitif. Gangguan psikologis seperti depresi dan penurunan fungsi kognitif, serta keterbatasan dukungan sosial, diketahui berhubungan dengan peningkatan risiko *frailty*, sarcopenia, dan disabilitas. Aspek psikologis yang dikaji meliputi fungsi kognitif (orientasi, memori, perhatian), status emosional (depresi, kecemasan), mekanisme koping terhadap stres. Instrumen yang dapat digunakan antara lain:

- a. *Mini Mental State Examination* (MMSE), untuk menilai fungsi kognitif (orientasi, registrasi, perhatian, recall, bahasa)
- b. *Montreal Cognitive Assessment* versi Indonesia (MoCA-Ina), untuk skrining gangguan kognitif ringan
- c. *Geriatric Depression Scale* (GDS), menilai depresi pada lansia.

6. Pengkajian Sosial

Pengkajian sosial bertujuan untuk menilai dukungan sosial lansia yang berperan penting dalam mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup. Aspek sosial pada lansia mencakup dukungan keluarga dan *caregiver*, interaksi

sosial dan partisipasi dalam masyarakat, kondisi ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal. Instrumen yang dapat digunakan di Indonesia antara lain:

- a. APGAR Keluarga, untuk menilai fungsi dan dukungan keluarga
- b. *Duke Social Support Index* (DSSI) atau modifikasinya, untuk menilai dukungan sosial

Pengkajian psikososial penting untuk mengidentifikasi lansia yang berisiko mengalami isolasi sosial, depresi, serta penurunan fungsi, sehingga dapat dirancang intervensi yang tepat dan holistik.

7. Pengkajian Spiritual

Pengkajian spiritual bertujuan untuk mengidentifikasi keyakinan, nilai, dan praktik spiritual lansia yang memengaruhi cara individu menghadapi kondisi kesehatan, kehilangan, serta proses penuaan. Aspek spiritual merupakan bagian penting dalam pendekatan keperawatan holistik karena dapat menjadi sumber coping dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Aspek yang dikaji seperti keyakinan dan praktik keagamaan, makna hidup dan harapan, sumber kekuatan dalam menghadapi penyakit, dan kebutuhan dukungan spiritual. Instrumen yang dapat digunakan antara lain:

- a. FICA Spiritual Assessment Tool (Faith/ Keyakinan, Importance/ Pentingnya, Community/ Komunitas, Address in care/Implementasi dalam perawatan)
- b. HOPE Spiritual Assessment Tool (Sources of hope, Organized religion, Personal spirituality, Effects on care)
- c. Spiritual Well-Being Scale (SWBS)

Selain menggunakan instrumen, pengkajian spiritual juga dapat dilakukan melalui wawancara terapeutik yang sensitif terhadap budaya dan keyakinan pasien. Perawat perlu menghormati nilai spiritual lansia serta memfasilitasi kebutuhan ibadah sesuai preferensi individu.

F. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian gerontik komprehensif, beberapa diagnosis keperawatan yang dapat ditegakkan pada lansia dengan *frailty*, sarcopenia, dan risiko disabilitas mengacu pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) antara lain sebagai berikut:

1. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)

Diagnosis ini ditegakkan pada lansia yang mengalami penurunan kekuatan otot dan fungsi fisik akibat sarcopenia maupun *frailty*. Data yang mendukung meliputi penurunan kekuatan genggam tangan, kecepatan berjalan yang melambat, kesulitan bangun dari posisi duduk, serta keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini berhubungan dengan penurunan

massa otot, gangguan neuromuskular, serta berkurangnya cadangan energi fisiologis.

2. Risiko Jatuh (D.0143)

Risiko jatuh merupakan diagnosis yang sangat relevan pada lansia dengan *frailty* dan sarcopenia, mengingat adanya penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, serta perlambatan kecepatan berjalan. Faktor risiko yang perlu diidentifikasi meliputi riwayat jatuh sebelumnya, penggunaan alat bantu jalan, penggunaan beberapa obat secara bersamaan (poli-farmasi), gangguan penglihatan, serta kondisi lingkungan yang tidak aman.

3. Defisit Nutrisi (D.0019)

Malnutrisi, terutama asupan protein yang tidak adekuat, merupakan faktor utama yang memperburuk sarcopenia dan *frailty*. Diagnosis defisit nutrisi ditegakkan berdasarkan data penurunan berat badan yang tidak disengaja (lebih dari 4,5 kg dalam setahun), penurunan nafsu makan, serta hasil pengkajian status gizi yang menunjukkan ketidak adekuatan asupan makronutrien dan mikronutrien.

4. Intoleransi Aktivitas (D.0056)

Intoleransi aktivitas ditandai dengan kelelahan berlebihan, dispnea, atau ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang. Pada lansia dengan *frailty* dan sarcopenia, kondisi ini berkaitan erat dengan penurunan kapasitas kardiorespirasi, berkurangnya massa otot, serta rendahnya cadangan energi tubuh, sehingga membatasi kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

5. Gangguan Rasa Nyaman (D.0074)

Nyeri muskuloskeletal, kekakuan sendi, dan ketidaknyamanan fisik merupakan keluhan yang sering menyertai sarcopenia dan *frailty* pada lansia. Gangguan rasa nyaman dapat berdampak pada kualitas tidur, suasana hati, serta motivasi lansia untuk melakukan aktivitas fisik dan latihan, sehingga memperberat kondisi penurunan fungsi otot secara keseluruhan.

6. Gangguan Citra Tubuh (D.0083)

Penurunan massa otot yang terlihat secara fisik, seperti mengecilnya ukuran tubuh dan kelemahan yang nyata, dapat memengaruhi persepsi lansia terhadap citra tubuhnya sendiri. Hal ini dapat berujung pada perasaan tidak berdaya, malu, atau menarik diri dari lingkungan sosial, yang pada akhirnya memperburuk kondisi psikologis dan menurunkan motivasi untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi.

7. Ansietas (D.0080)

Perasaan khawatir terhadap kondisi kesehatan yang semakin menurun, ketakutan akan jatuh, serta ketidakpastian tentang kemampuan mempertahankan kemandirian merupakan sumber ansietas yang umum pada lansia dengan *frailty* dan sarcopenia. Ansietas yang tidak tertangani dapat menyebabkan lansia semakin membatasi aktivitas fisiknya, sehingga memperparah siklus penurunan fungsi.

8. Ketidakberdayaan (D.0092)

Ketidakberdayaan merupakan diagnosis yang relevan pada lansia yang mengalami *frailty* dan sarcopenia, ditandai dengan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan tidak akan mengubah kondisi atau hasilnya. Lansia sering mengungkapkan perasaan bahwa mereka tidak mampu mengendalikan kondisi tubuhnya, menganggap usaha apapun tidak akan membawa perubahan, atau menyatakan ketergantungan yang berlebihan kepada orang lain. Data yang mendukung diagnosis ini meliputi ungkapan verbal seperti "tubuh saya sudah tidak bisa bergerak seperti dulu" atau "percuma saja berlatih, tidak akan membaik", penurunan partisipasi dalam program rehabilitasi, ekspresi putus asa, serta perilaku pasif dalam mengambil keputusan terkait perawatannya sendiri. Kondisi ini berhubungan dengan pengalaman kehilangan kemampuan fisik yang progresif, ketergantungan yang meningkat, serta kurangnya dukungan sosial yang memadai.

G. Luaran Keperawatan

Luaran keperawatan mengacu pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018) dan disesuaikan dengan diagnosis yang ditegakkan. Penetapan luaran bertujuan memberikan arah yang terukur dalam mengevaluasi keberhasilan intervensi keperawatan pada lansia dengan *frailty*, sarcopenia, dan risiko disabilitas.

1. Mobilitas Fisik (L.05042)

Luaran utama pada diagnosis gangguan mobilitas fisik adalah peningkatan kemampuan gerak tubuh. Kriteria hasil yang diharapkan meliputi peningkatan kekuatan otot yang dinilai melalui kekuatan genggam tangan (*handgrip strength*), peningkatan kecepatan berjalan, kemampuan berpindah posisi secara mandiri atau dengan bantuan minimal, serta rentang gerak sendi yang memadai. Kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti bangun dari kursi, berjalan, dan naik tangga menjadi indikator penting keberhasilan luaran ini.

2. Tingkat Jatuh (L.14138)

Luaran pada diagnosis risiko jatuh adalah penurunan frekuensi kejadian jatuh. Kriteria hasil yang diharapkan meliputi tidak terjadinya kejadian jatuh

selama masa perawatan, peningkatan kemampuan mempertahankan keseimbangan, peningkatan kemampuan melakukan perpindahan secara aman, serta kemampuan mengidentifikasi faktor risiko jatuh di lingkungan sekitar. Lansia dan keluarga diharapkan mampu menyebutkan strategi pencegahan jatuh yang telah diajarkan.

3. Status Nutrisi (L.03030)

Luaran pada diagnosis defisit nutrisi adalah peningkatan status gizi lansia. Kriteria hasil yang diharapkan meliputi stabilisasi atau peningkatan berat badan yang sesuai target, peningkatan asupan makan dan protein, serta perbaikan hasil pemeriksaan laboratorium terkait status gizi (seperti kadar albumin serum). Lansia dan keluarga diharapkan memahami kebutuhan nutrisi yang sesuai usia dan kondisi kesehatan.

4. Toleransi Aktivitas (L.05047)

Luaran pada diagnosis intoleransi aktivitas adalah peningkatan kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Kriteria hasil yang diharapkan meliputi penurunan keluhan kelelahan, frekuensi nadi dan pernapasan yang stabil saat beraktivitas, serta peningkatan durasi dan intensitas aktivitas fisik yang dapat ditoleransi. Lansia diharapkan mampu melakukan latihan fisik ringan secara teratur sesuai kemampuannya.

5. Tingkat Ansietas (L.09093)

Luaran pada diagnosis ansietas adalah penurunan tingkat kecemasan lansia. Kriteria hasil yang diharapkan meliputi berkurangnya keluhan khawatir dan tegang, peningkatan kemampuan mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan, serta kemampuan menggunakan strategi koping yang adaptif. Lansia diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam program perawatan dan rehabilitasi tanpa hambatan psikologis yang signifikan.

H. Aktivitas 1 — *Knows How*

1. Seorang perempuan berusia 75 tahun dibawa oleh anaknya ke poliklinik geriatri dengan keluhan mudah lelah dan sering merasa tidak bertenaga sejak sekitar enam bulan yang lalu. Anak pasien mengatakan ibunya sering terjatuh sebanyak dua kali dalam tiga bulan terakhir dan tampak kesulitan bangkit dari kursi. Pasien juga mengalami penurunan berat badan sekitar 5 kg dalam enam bulan terakhir tanpa diet khusus, dengan nafsu makan yang menurun. Pasien memiliki riwayat hipertensi yang terkontrol dengan obat.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- a. Pasien tampak lemah dan berjalan lambat dengan langkah pendek dan tidak stabil

- b. Pasien mengeluhkan mudah lelah jika terlalu lama berjalan
- c. Kekuatan genggam tangan kanan 14 kg (di bawah nilai normal untuk perempuan usia 75 tahun)
- d. Kecepatan berjalan 0,7 m/detik (di bawah nilai ambang batas normal)
- e. Berat badan 48 kg, tinggi badan 155 cm, IMT 19,97 kg/m²
- f. Pasien mengatakan aktivitas fisiknya sangat terbatas karena takut jatuh, hampir tidak pernah keluar rumah dalam sebulan terakhir

Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

- a. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa lansia tersebut mengalami frailty berdasarkan kriteria *Fried Frailty Phenotype*.
- b. Tentukan kemungkinan diagnosis sarcopenia berdasarkan data pengkajian yang tersedia.
- c. Identifikasi faktor risiko disabilitas yang ditemukan pada kasus ini dan jelaskan kaitannya satu sama lain.
- d. Rumuskan dua diagnosis keperawatan prioritas berdasarkan data kasus di atas menggunakan format SDKI.
- e. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang dapat dilakukan untuk mencegah perburukan kondisi lansia ini.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

I. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab OSCE Pengkajian *Frailty* dan Sarcopenia pada Lansia

Fokus urutan tindakan + komunikasi terapeutik + keselamatan pasien lansia

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Pengkajian <i>Frailty</i> dan Sarcopenia pada Lansia
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian gerontik terfokus, menegakkan diagnosis keperawatan prioritas, menyusun rencana keperawatan awal, serta memberikan edukasi pencegahan jatuh pada lansia dengan <i>frailty</i> dan sarcopenia.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian

No.	Komponen	Isi
		3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Aman dan nyaman 2. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan berusia 75 tahun dirawat di poliklinik geriatri dengan keluhan mudah lelah dan sering jatuh. Anak pasien melaporkan bahwa pasien mengalami penurunan berat badan 5 kg dalam enam bulan tanpa diet khusus, hampir tidak beraktivitas di luar rumah karena takut jatuh, dan tampak kesulitan bangkit dari kursi. Hasil pengkajian awal: tekanan darah 140/85 mmHg, nadi 82 x/menit, frekuensi napas 20 x/menit, kekuatan genggaman tangan kanan 14 kg, kecepatan berjalan 0,7 m/detik, IMT 19,97 kg/m². Skor Fried <i>Frailty Phenotype</i>: 4 kriteria terpenuhi. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada klien standar (KS) yang berperan sebagai anak pasien. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan prioritas pada lembar jawab berdasarkan skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan awal pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi strategi pencegahan jatuh di rumah kepada anak pasien (KS).
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan berusia 75 tahun dirawat di poliklinik geriatri dengan keluhan mudah lelah dan sering jatuh. Anak pasien melaporkan bahwa pasien mengalami penurunan berat badan 5 kg dalam enam bulan tanpa diet khusus, hampir tidak beraktivitas di luar rumah karena takut jatuh, dan tampak kesulitan bangkit dari kursi. Hasil pengkajian awal: tekanan darah 140/85 mmHg, nadi 82 x/menit, frekuensi napas 20 x/menit, kekuatan genggaman tangan kanan 14 kg, kecepatan berjalan 0,7 m/detik, IMT 19,97 kg/m². Skor Fried <i>Frailty Phenotype</i>: 4 kriteria terpenuhi. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada klien standar (KS) yang berperan sebagai anak pasien. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan prioritas pada lembar jawab berdasarkan skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan awal pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi strategi pencegahan jatuh di rumah kepada anak pasien (KS).

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI PENGUJI: 1. Penguji menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian fokus tambahan secara tepat melalui komunikasi dengan anak pasien sebagai klien standar, yang mencakup riwayat jatuh seperti frekuensi, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan, kemampuan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan mobilisasi, penurunan aktivitas fisik, pola makan dan nafsu makan, riwayat penyakit kronis serta penggunaan obat-obatan, kondisi lingkungan rumah yang berpotensi meningkatkan risiko jatuh, serta kondisi psikologis seperti rasa takut jatuh. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengidentifikasi adanya penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, dan keterbatasan mobilitas berdasarkan data yang tersedia. 2. Penguji menilai ketepatan peserta dalam menetapkan diagnosis keperawatan prioritas berdasarkan data hasil pengkajian dan skenario, di mana diagnosis yang diharapkan antara lain risiko jatuh yang berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, dan riwayat jatuh, serta sindrom <i>frailty</i> pada lansia yang ditandai dengan penurunan berat badan, kelelahan, kelemahan, aktivitas fisik rendah, dan kecepatan berjalan yang lambat, dengan catatan peserta mampu memilih prioritas diagnosis yang paling sesuai disertai data pendukung yang relevan. 3. Penguji menilai kemampuan peserta dalam menyusun perencanaan keperawatan awal yang tepat, meliputi intervensi seperti memonitor risiko jatuh melalui observasi keseimbangan dan kemampuan berjalan, menganjurkan penggunaan alat bantu bila diperlukan, melatih latihan kekuatan otot dan keseimbangan secara bertahap, menganjurkan peningkatan aktivitas fisik sesuai toleransi, memonitor dan meningkatkan status nutrisi dengan diet seimbang, memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pencegahan jatuh dan pentingnya pengawasan, serta melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti fisioterapis dan ahli gizi. 4. Penguji menilai ketepatan penampilan peserta dalam melakukan edukasi dan demonstrasi pencegahan jatuh di rumah kepada anak pasien, yang mencakup tindakan cuci tangan sebelum dan sesudah edukasi, kemampuan menjelaskan tujuan dengan bahasa yang mudah dipahami, menjelaskan modifikasi lingkungan rumah seperti pencahayaan yang cukup, menghindari lantai licin, penggunaan alas kaki yang aman, dan pemasangan pegangan di kamar mandi, mendemonstrasikan cara bangkit dari duduk ke berdiri dengan aman, menganjurkan penggunaan alat bantu bila diperlukan, menjelaskan pentingnya aktivitas fisik ringan untuk meningkatkan kekuatan dan keseimbangan, serta menjelaskan tanda bahaya seperti jatuh berulang, pusing, atau kelemahan yang harus segera dilaporkan. 5. Penguji menilai perilaku profesional peserta selama proses ujian berlangsung yang mencakup kemampuan komunikasi terapeutik, sikap

No.	Komponen	Isi
		empati, kesopanan, serta kejelasan dalam memberikan informasi kepada keluarga pasien. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang telah ditentukan selama proses ujian berlangsung.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus adalah perempuan usia 75 tahun, dan klien standar (KS) berperan sebagai anak kandung yang mendampingi pasien selama berobat di poliklinik geriatri. 2. Riwayat penyakit sekarang disampaikan bahwa pasien sering mengeluh mudah lelah, sudah beberapa kali hampir jatuh dan pernah jatuh ringan di rumah, mengalami penurunan berat badan sekitar 5 kg dalam enam bulan terakhir tanpa diet, aktivitas sehari-hari sangat berkurang karena takut jatuh, serta tampak kesulitan saat bangkit dari kursi atau berjalan. 3. Riwayat perawatan saat ini adalah kunjungan ke poliklinik geriatri dan bukan merupakan rawat inap, namun keluhan ini sudah dirasakan sejak beberapa bulan terakhir dan semakin memberat. 4. Riwayat penyakit keluarga disampaikan bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang mengalami kondisi serupa, namun pasien memiliki riwayat penyakit kronis ringan seperti hipertensi. 5. Riwayat kebiasaan sosial disampaikan bahwa pasien saat ini lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, jarang keluar karena takut jatuh, tampak kurang percaya diri untuk berjalan sendiri, dan anak sebagai KS tampak khawatir terhadap kondisi pasien. 6. Harapan terhadap kondisi pasien disampaikan bahwa keluarga berharap pasien dapat kembali lebih kuat, tidak mudah jatuh, dapat beraktivitas lebih mandiri, dan kualitas hidupnya membaik. 7. Bila peserta menanyakan riwayat jatuh, jawaban KS adalah pasien sudah beberapa kali hampir jatuh dan pernah jatuh satu kali di rumah saat berjalan ke kamar mandi, namun tidak mengalami cedera berat. 8. Bila peserta menanyakan asupan makan, jawaban KS adalah nafsu makan pasien menurun, porsi makan menjadi lebih sedikit dari biasanya, dan terkadang harus diingatkan untuk makan. 9. Bila peserta menanyakan aktivitas sehari-hari, jawaban KS adalah pasien mulai membutuhkan bantuan untuk beberapa aktivitas seperti bangkit dari kursi, berjalan jauh, dan kadang merasa tidak kuat berdiri lama. 10. KS berperan sebagai anak pasien yang duduk di samping pasien dengan ekspresi khawatir, berbicara dengan nada cemas namun kooperatif, serta memberikan informasi dengan jelas sesuai pertanyaan peserta agar tidak membingungkan selama ujian berlangsung.
10	Setting station	Ruang Poliklinik Geriatri 1. Kursi pasien 2. KS berperan sebagai anak pasien 3. Penguji

No.	Komponen	Isi
		4. Laboran Tata letak ruang: 1. Kursi pasien dan kursi pendamping (KS) 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Pintu masuk 5. Area edukasi/demonstrasi (ruang cukup untuk simulasi bangkit dari duduk dan berjalan) 6. Wastafel/<i>handrub</i> 7. Tempat sampah 8. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. <i>Handrub/hand sanitizer</i> 2. Tisu 3. Kursi tambahan atau alat bantu simulasi (misalnya kursi dengan sandaran untuk demonstrasi bangkit-berdiri) 4. Alat bantu jalan (tongkat/<i>walker</i> sebagai media edukasi, bila tersedia) 5. Lembar edukasi pencegahan jatuh (<i>leaflet</i> bila tersedia) 6. Lembar jawaban peserta Peran laboran: Merapikan kembali alat-alat setelah digunakan oleh peserta, memastikan lingkungan tetap rapi dan aman untuk simulasi, serta menyiapkan kembali seluruh kebutuhan <i>station</i> agar siap digunakan oleh peserta berikutnya sebelum memasuki ruang ujian.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI PENCEGAHAN JATUH PADA LANSIA DENGAN *FRAILTY* DAN SARCOPENIA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. <i>Handrub</i> b. Lembar edukasi pencegahan jatuh c. Alat peraga (seperti pegangan, alas kaki non-slip) d. Lembar penilaian risiko jatuh				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama anak dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan keluarga untuk bertanya				
C	Tahap Kerja (No. 9 s.d. 20: sistematis)				
9	Melakukan kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)				
10	Mengkaji riwayat jatuh, frekuensi jatuh, lokasi kejadian, dan kondisi saat jatuh				
11	Mengkaji kekuatan otot, keseimbangan, dan kemampuan mobilisasi lansia				
12	Mengidentifikasi faktor risiko jatuh dari lingkungan rumah (pencahayaan, lantai licin, ketinggian tempat duduk, pegangan dinding)				
13	Menjelaskan tujuan edukasi pencegahan jatuh kepada keluarga				
14	Menjelaskan dan mendemonstrasikan modifikasi lingkungan yang aman: memasang pegangan di kamar mandi dan tangga, memastikan pencahayaan cukup, menghindari karpet yang tidak rata				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
15	Menganjurkan penggunaan alas kaki bersol tidak licin dan tidak menggunakan alas kaki sandal jepit saat beraktivitas				
16	Menjelaskan pentingnya latihan keseimbangan ringan yang dapat dilakukan di rumah secara bertahap				
17	Menjelaskan tanda bahaya yang memerlukan evaluasi segera: jatuh dengan benturan kepala, nyeri hebat setelah jatuh, penurunan kesadaran, atau ketidakmampuan berdiri setelah jatuh				
18	Meminta keluarga mengulang kembali penjelasan yang telah diberikan (<i>teach-back</i>)				
19	Merapikan pasien dan peralatan yang digunakan				
20	Melakukan kebersihan tangan				
D	Tahap Terminasi				
21	Menyimpulkan kegiatan edukasi yang telah dilakukan				
22	Mengevaluasi respons keluarga secara subjektif dan objektif				
23	Memberikan <i>reinforcement</i> positif atas respons keluarga				
24	Membuat kontrak waktu untuk tindak lanjut				
25	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
26	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian <i>frailty</i> dan risiko jatuh, kegiatan edukasi pencegahan jatuh, respons keluarga dan lansia, serta rencana tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
27	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DENGAN *FRAILTY* DAN RISIKO JATUH

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali riwayat jatuh, aktivitas sehari-hari, status nutrisi, riwayat penyakit dan obat, kondisi lingkungan, serta kondisi psikologis dan mobilitas pasien					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat (risiko jatuh/sindrom <i>frailty</i>) dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan edukasi, melakukan edukasi pencegahan jatuh, mendemonstrasikan cara bangkit dan berjalan aman, serta menjelaskan tanda bahaya					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, empati, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, dan responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DENGAN *FRAILTY* DAN
RISIKO JATUH

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien lansia dengan <i>frailty</i> dan risiko jatuh, meliputi riwayat jatuh, kemampuan aktivitas sehari-hari, status nutrisi, riwayat penyakit dan penggunaan obat, kondisi lingkungan rumah, serta kondisi psikologis dan mobilitas. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan tepat.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada lansia dengan <i>frailty</i> dan risiko jatuh serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah direncanakan, khususnya edukasi dan demonstrasi pencegahan jatuh di rumah. Tindakan mencakup penjelasan yang jelas, langkah-langkah yang sistematis, demonstrasi cara mobilisasi yang aman (seperti bangkit dari duduk dan berjalan), serta edukasi modifikasi lingkungan dan tanda bahaya sesuai kondisi pasien dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan perilaku profesional sesuai prinsip etik dan legal, seperti memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan keluarga, menunjukkan empati, menjaga privasi dan kenyamanan pasien, serta melakukan tindakan secara aman, teliti, sistematis, dan responsif.					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor						

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus lansia <i>frailty</i> dan risiko jatuh.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data seperti keluhan umum, tidak sistematis, dan belum mampu mengidentifikasi faktor risiko jatuh atau tanda <i>frailty</i> dengan tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti riwayat jatuh, aktivitas, nutrisi, dan mobilitas, namun masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi riwayat jatuh, aktivitas sehari-hari, status nutrisi, kondisi lingkungan, psikologis, dan mobilitas, serta mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan kasus, serta tidak menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data, serta rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan pasien lansia dengan <i>frailty</i> dan risiko jatuh.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi pencegahan jatuh, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan,	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar	Melakukan edukasi dan demonstrasi pencegahan jatuh secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	dan berisiko bagi pasien.	penjelasan kurang jelas, dan teknik demonstrasi belum tepat.	namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan, atau teknik demonstrasi.	modifikasi lingkungan, teknik bangkit dan berjalan yang aman, penggunaan alat bantu, serta edukasi tanda bahaya dengan jelas.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, serta tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, empati, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi dan kenyamanan, namun masih terdapat kekurangan kecil dalam sikap atau sistematisa tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan, bersikap empatik, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	<i>BORDERLINE</i>	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

J. DOPS (*Does*)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- *Checklist* + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Lansia dengan *Frailty* dan Risiko Jatuh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kasus Lansia dengan <i>Frailty</i> dan Risiko Jatuh
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam <i>encounter</i> singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat melakukan pengkajian, penentuan diagnosis, dan edukasi pencegahan jatuh pada pasien lansia di poliklinik geriatri.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan tentang <i>frailty</i> dan risiko jatuh, tetapi juga dari kemampuan melakukan pengkajian, menjelaskan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kasus Lansia dengan <i>Frailty</i> dan Risiko Jatuh
	profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	kondisi pasien, serta memberikan edukasi kepada keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mahasiswa.	Seorang perempuan usia 75 tahun dengan keluhan mudah lelah, penurunan berat badan, aktivitas menurun, dan riwayat hampir jatuh, dengan skor <i>frailty</i> tinggi.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan <i>encounter</i> klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian fokus, menilai risiko jatuh, mengidentifikasi <i>frailty</i> , menyampaikan diagnosis, serta memberikan edukasi dan demonstrasi pencegahan jatuh kepada keluarga.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis/pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinis, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali riwayat jatuh, aktivitas, nutrisi, mengenali tanda <i>frailty</i> , menjelaskan pencegahan jatuh dengan bahasa sederhana, serta menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas seperti risiko jatuh, serta memberikan edukasi yang tepat, aman, dan sesuai kondisi pasien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah mampu mengidentifikasi risiko jatuh dan melakukan edukasi, namun perlu meningkatkan kelengkapan pengkajian lingkungan rumah dan teknik demonstrasi mobilisasi yang lebih aman.
Keputusan penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam <i>encounter</i> singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat melakukan pengkajian, penentuan diagnosis, dan edukasi pencegahan jatuh pada pasien lansia di poliklinik geriatri.
Makna dalam OBE	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinis, komunikasi, edukasi, dan	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan tentang <i>frailty</i> dan risiko jatuh, tetapi juga dari kemampuan melakukan pengkajian, menjelaskan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kasus Lansia dengan <i>Frailty</i> dan Risiko Jatuh
	profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	kondisi pasien, serta memberikan edukasi kepada keluarga.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi *patient safety*
- *Feedback* CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1.1

Portofolio pada Asuhan Keperawatan Lansia dengan *Frailty* dan Risiko Jatuh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kasus Lansia dengan <i>Frailty</i> dan Risiko Jatuh
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan lansia dengan <i>frailty</i> dan risiko jatuh, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, mengidentifikasi risiko jatuh, memberikan edukasi pencegahan, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa mampu merawat lansia, tetapi juga meningkatkan kemampuan setelah mendapatkan masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE menilai keterampilan edukasi dan demonstrasi pencegahan jatuh, sedangkan DOPS menilai performa langsung mahasiswa saat memberikan asuhan pada pasien lansia di layanan kesehatan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa,	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus lansia usia 75 tahun dengan <i>frailty</i> , riwayat jatuh, penurunan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kasus Lansia dengan <i>Frailty</i> dan Risiko Jatuh
	data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	aktivitas, diagnosis risiko jatuh, intervensi latihan keseimbangan, edukasi lingkungan aman, dan evaluasi hasil.
Refleksi patient safety	Refleksi <i>patient safety</i> menilai kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pencegahan jatuh, seperti memastikan lingkungan aman, penggunaan alat bantu, serta pengawasan keluarga dalam aktivitas pasien.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan edukasi, namun perlu meningkatkan kelengkapan pengkajian lingkungan dan teknik demonstrasi mobilisasi aman.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan dengan penekanan pada konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kasus lansia yang berbeda untuk melihat konsistensi dalam melakukan pengkajian, penentuan diagnosis, dan edukasi pencegahan jatuh.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan lansia dengan frailty dan risiko jatuh, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, mengidentifikasi risiko jatuh, memberikan edukasi pencegahan, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Makna dalam OBE	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa mampu merawat lansia, tetapi juga meningkatkan kemampuan setelah mendapatkan masukan dari dosen atau CI.

Tabel 1.2
Case Report pada Asuhan Keperawatan Lansia dengan *Frailty* dan Risiko Jatuh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia dengan <i>Frailty</i> dan Risiko Jatuh
Hakikat <i>case report</i>	<i>Case report</i> merupakan laporan singkat dan sistematis tentang kasus lansia dengan <i>frailty</i> dan risiko jatuh yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, <i>case report</i> berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian, analisis, dan dokumentasi kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan tentang lansia usia 75 tahun dengan <i>frailty</i> , kelemahan otot, keseimbangan menurun, dan riwayat jatuh berulang.
Tujuan	<i>Case report</i> bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa mengidentifikasi masalah seperti <i>frailty</i> dan risiko jatuh, lalu menyusun intervensi untuk meningkatkan kekuatan dan mencegah jatuh.
Isi laporan	Isi laporan mencakup identitas pasien, riwayat kesehatan, data subjektif dan objektif, pengkajian fungsional, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi.	Mahasiswa mencatat hasil pengkajian seperti <i>gait</i> tidak stabil, kekuatan otot menurun, skor risiko jatuh tinggi, serta intervensi seperti latihan keseimbangan dan edukasi keluarga.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan analisis masalah, logika penalaran klinis, relevansi intervensi, dan kemampuan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa mampu menghubungkan <i>frailty</i> dengan risiko jatuh dan memilih intervensi seperti latihan fisik dan modifikasi lingkungan.
Nilai edukatif	<i>Case report</i> membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , kemampuan dokumentasi, dan refleksi praktik keperawatan gerontik.	Mahasiswa belajar pentingnya pencegahan jatuh dan keterlibatan keluarga dalam perawatan lansia.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, <i>case report</i> menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam praktik secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan pemahaman komprehensif tentang <i>frailty</i> dan mampu memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh.

Tabel 1.3
Refleksi *Patient Safety* pada Asuhan Keperawatan Lansia dengan *Frailty* dan Risiko Jatuh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia dengan <i>Frailty</i> dan Risiko Jatuh
Hakikat refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, menganalisis penyebab, serta merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus lansia dengan <i>frailty</i> , mahasiswa merefleksikan bahwa penurunan kekuatan otot dan keseimbangan meningkatkan risiko jatuh yang dapat menyebabkan cedera serius seperti fraktur.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kurangnya pengawasan, penggunaan alat bantu yang tidak tepat, atau lingkungan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko jatuh pada lansia.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada lansia adalah <i>frailty</i> , gangguan keseimbangan, kelemahan otot, serta lingkungan yang tidak aman (lantai licin, pencahayaan kurang).
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain jatuh saat mobilisasi, penggunaan alat bantu yang tidak sesuai, hipotensi ortostatik, serta kurangnya pendampingan saat aktivitas.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memastikan lingkungan aman, memberikan edukasi penggunaan alat bantu, mendampingi pasien saat mobilisasi, serta melakukan asesmen risiko jatuh secara berkala.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian risiko jatuh, komunikasi dengan keluarga, dan pemantauan kondisi lansia secara berkala merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan keperawatan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko jatuh, mengambil langkah pencegahan yang tepat, serta meningkatkan kualitas asuhan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia dengan <i>Frailty</i> dan Risiko Jatuh
		keperawatan gerontik secara berkelanjutan.

K. Ringkasan Materi

Bab ini menekankan bahwa *frailty*, sarcopenia, dan risiko disabilitas merupakan masalah klinis yang sangat penting dalam keperawatan gerontik dan dapat berkembang secara progresif menjadi kondisi yang membahayakan kualitas hidup lansia apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan lansia dengan kondisi ini adalah mempertahankan fungsi fisik, mencegah perburukan *frailty* dan sarcopenia, mengurangi risiko jatuh, memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat, serta memberikan dukungan psikososial yang menyeluruh kepada lansia dan keluarganya.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada lansia dengan *frailty* dan sarcopenia tidak hanya berhenti pada keluhan kelemahan fisik semata, tetapi harus dilanjutkan dengan penilaian komprehensif menggunakan pendekatan *Comprehensive Geriatric Assessment* (CGA), meliputi aspek fisik (*head to toe*), fungsional (ADL dan IADL), kognitif, psikologis, sosial, dan spiritual. Tanda-tanda seperti penurunan kekuatan genggam tangan, kecepatan berjalan yang melambat, penurunan berat badan yang tidak disengaja, kelelahan, serta rendahnya aktivitas fisik merupakan indikator penting dari *frailty* yang harus diidentifikasi sejak awal menggunakan instrumen seperti *Fried Frailty Phenotype* dan *Clinical Frailty Scale*.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat kondisi umum dan status fungsional, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap kekuatan otot, keseimbangan, mobilitas, status nutrisi, dan kondisi psikologis. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya gangguan mobilitas fisik, risiko jatuh, defisit nutrisi, intoleransi aktivitas, ansietas, atau ketidakberdayaan. Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan latihan fisik multi-komponen, optimalisasi nutrisi dengan asupan protein 1,2–1,5 g/kg/hari, pencegahan jatuh melalui modifikasi lingkungan, edukasi keluarga, serta kolaborasi dengan fisioterapis dan ahli gizi.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain memantau tanda vital dan status fungsional, mengkaji kekuatan otot dan keseimbangan secara berkala, mendukung program latihan resistensi dan

keseimbangan secara bertahap, memantau asupan nutrisi dan berat badan, menjaga keamanan lingkungan, serta memberikan edukasi yang mudah dipahami keluarga mengenai pencegahan jatuh. Edukasi kepada keluarga menjadi bagian yang sangat penting, terutama mengenai modifikasi lingkungan rumah, penggunaan alat bantu yang tepat, tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, dan pentingnya aktivitas fisik rutin.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan kondisi lansia, misalnya peningkatan kekuatan genggam tangan, peningkatan kecepatan berjalan, tidak terjadinya kejadian jatuh, stabilisasi atau peningkatan berat badan, serta lansia dan keluarga mampu menjelaskan kembali strategi pencegahan jatuh. Namun, apabila ditemukan tanda bahaya seperti lansia jatuh dengan benturan kepala, penurunan kesadaran, nyeri hebat, kelemahan mendadak yang memburuk, atau tanda fraktur, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, preceptor, atau dokter sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan lansia dengan *frailty*, *sarcopenia*, dan risiko disabilitas harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan serta kemandirian pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi keluarga, berkolaborasi dengan tim multi disiplin, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran *skill lab* maupun praktik klinik pada Keperawatan Gerontik.

L. Tabel *Red Flags* & Eskalasi

<i>Red flags</i>	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Lansia jatuh dengan benturan kepala atau tidak sadarkan diri	Tanda kegawatan yang dapat menyebabkan cedera otak, perdarahan intra kranial, atau kondisi serius lainnya	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preceptor/dokter, hentikan mobilisasi, lakukan pemantauan ketat, siapkan penanganan lanjutan
Penurunan kesadaran atau kebingungan mendadak	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan dengan dehidrasi, gangguan elektrolit, infeksi berat, atau stroke	Eskalasi segera, jangan tinggalkan pasien, lakukan observasi lanjutan
Kelemahan otot mendadak yang memburuk dengan cepat	Dapat menunjukkan kondisi neurologis akut atau perburukan sistemik yang memerlukan evaluasi segera	Segera laporkan dan evaluasi kondisi pasien secara menyeluruh

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Nyeri hebat setelah jatuh atau perubahan posisi	Mengarah pada kemungkinan fraktur, terutama fraktur panggul yang sangat berbahaya pada lansia	Laporkan segera, immobilisasi area yang dicurigai, siapkan evaluasi medis lebih lanjut
Sesak napas atau nyeri dada saat beraktivitas atau istirahat	Dapat menunjukkan komplikasi kardiorespirasi yang mengancam jiwa	Laporkan segera, monitor tanda vital, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut
Penurunan berat badan drastis (>4,5 kg dalam sebulan)	Menunjukkan perburukan status nutrisi dan progresivitas sarcopenia yang mengancam kemandirian	Laporkan, monitor <i>intake-output</i> dan status gizi secara ketat, konsultasi ahli gizi
Tidak mampu berdiri atau berjalan sama sekali (kemunduran fungsi mendadak)	Tanda perburukan <i>frailty</i> dan disabilitas yang memerlukan evaluasi komprehensif	Laporkan segera, tingkatkan kewaspadaan terhadap perburukan, libatkan tim multi disiplin
Tanda infeksi: demam tinggi, kemerahan, bengkak pada sendi atau luka	Infeksi pada lansia dengan <i>frailty</i> dapat memperburuk kondisi secara cepat dan meningkatkan risiko sepsis	Eskalasi segera, dokumentasikan tanda infeksi, siapkan evaluasi medis
Tanda dehidrasi berat: mukosa sangat kering, turgor menurun, urin sangat sedikit	Dehidrasi pada lansia dengan sarcopenia dapat memperburuk fungsi ginjal dan status elektrolit	Laporkan segera, tingkatkan pemantauan cairan dan tanda vital
Kejang atau gerakan involunter mendadak	Tanda kegawatan yang dapat berkaitan dengan gangguan elektrolit, infeksi SSP, atau kondisi berat lainnya	Eskalasi emergensi segera, jaga keselamatan pasien
Tanda syok: nadi cepat lemah, CRT memanjang, ekstremitas dingin, tekanan darah turun	Kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera	Panggil bantuan segera, laporkan emergensi sesuai alur layanan
Gangguan psikologis berat: agitasi, disorientasi, atau menarik diri total	Dapat menandakan depresi berat, delirium, atau penurunan fungsi kognitif yang signifikan	Segera laporkan untuk evaluasi psikiatri dan medis

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab *Frailty*, Sarcopenia, dan Risiko Disabilitas

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / *Skill Lab* : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian <i>frailty</i> , sarcopenia, dan risiko disabilitas pada lansia secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) pada lansia dengan <i>frailty</i> dan sarcopenia	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menggunakan instrumen <i>Fried Frailty Phenotype</i> untuk mengidentifikasi <i>frailty</i>	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji kekuatan otot, kecepatan berjalan, dan keseimbangan pada lansia	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengkaji status nutrisi, penurunan berat badan, dan nafsu makan lansia	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada lansia dengan <i>frailty</i> dan sarcopenia	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada lansia dengan risiko jatuh	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan edukasi pencegahan jatuh kepada lansia dan keluarganya	☐	☐	
9	Saya sudah bisa mendemonstrasikan cara bangkit dari duduk ke berdiri yang aman	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menganjurkan modifikasi lingkungan rumah yang aman untuk lansia	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya latihan fisik dan asupan protein pada lansia dengan sarcopenia	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada lansia dengan <i>frailty</i> kepada keluarga	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
14	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan lansia dan keluarganya	☐	☐	
15	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan lansia dengan <i>frailty</i> dan risiko jatuh	☐	☐	
16	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat lansia dengan <i>frailty</i>			

Refleksi singkat mahasiswa:

M. Referensi

- Araújo, L. P., Clara, A., Godoy, F., Frota, F. F., Lamas, C. B., Quesada, K., Rucco, C., Detregiachi, P., Araújo, A. C., Miglino, M. A., Guiguer, E. L., Santos, R., Haber, D. A., Souza, E. De, Mazuqueli, B., Cavallari, V., & Catharin, S. (2025). Sarcopenia in the Aging Process: Pathophysiological Mechanisms, Clinical Implications, and Emerging Therapeutic Approaches. *International Journal of Molecular Sciences*, 2(26), 1–31.
- Ardeljan, A. D., & Hurezeanu, R. (2023). Sarcopenia. In *Sarcopenia* (pp. 1–14). StatPearls.
- Aslam, M. A., Ma, E. B., & Huh, J. Y. (2023). Pathophysiology of sarcopenia: Genetic factors and their interplay with environmental factors. *Metabolism*, 149, 155711. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.metabol.2023.155711>
- Cruz-Jentoft, A. J., Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyère, O., Cederholm, T., Cooper, C., Landi, F., Rolland, Y., Sayer, A. A., Schneider, S. M., Sieber, C. C., Topinkova, E., Vandewoude, M., Visser, M., & Zamboni, M. (2019). Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, 48(1), 16–31. <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>
- Dent, E., Morley, J. E., Cruz-Jentoft, A. J., Woodhouse, L., Rodríguez-Mañas, L., Fried, L. P., Woo, J., Aprahamian, I., Sanford, A., Lundy, J., Landi, F., Beilby, J., Martin, F. C., Bauer, J. M., Ferrucci, L., Merchant, R. A., Dong, B., Arai, H., Hoogendijk, E. O., ... Vellas, B. (2019). Physical Frailty: ICFSR International Clinical Practice Guidelines for Identification and Management. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, 23(9), 771–787. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12603-019-1273-z>
- Dong, Y., Xi, Y., Wang, Y., & Chai, Z. (2024). Association between sarcopenia and frailty in middle-aged and elder population: Findings from the China health and retirement longitudinal study. *Journal of Global Health*, 14(4163), 1–10. <https://doi.org/10.7189/jogh.14.04163>
- Irgat, S. i., & Kızıltan, G. (2025). Associations Between Frailty, Sarcopenia, and Nutritional Status in Older Adults Living in Nursing Homes. *Nutrients*, 17(3574), 1–12.
- Kennedy-Malone, L., & Duffy, E. G. (2023). *Advanced Practice Nursing in The Care of Older Adults (Second Edition)* (Second Edi). F. A. Davis Company.
- Kim, D. H., & Rockwood, K. (2024). Frailty in Older Adults. *The New England Journal of Medicine*, 391(6), 538–548. <https://doi.org/10.1056/NEJMra2301292>
- Kim, T. N., & Choi, K. M. (2013). Sarcopenia: Definition, Epidemiology, and Pathophysiology. *Journal of Bone Metabolism*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.11005/jbm.2013.20.1.1>
- Miller, C. A. (2023). *Nursing for Wellness in Older Adults*. Wolters Kluwer.

- Morley, J. E. (2016). Frailty and Sarcopenia in Elderly. *Wiener Klinische Wochenschrift*, 128(7), 439–445. <https://doi.org/10.1007/s00508-016-1087-5>
- Nicholson, C., & Barkham, A. (2023). Nursing the Older Person Living With Frailty. In *Redfern's Nursing Older People* (p. Chapter 6, 53-68). Elsevier.
- Pizzorno, J. E., & Murray, M. T. (2021). *Textbook of Natural Medicine (Fifth Edition)* (Fifth Edit). Elsevier, Inc.
- Rolland, Y., Cesari, M., & Vellas, B. (2017). Sarcopenia. In *Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology* (p. Chapter 72, 578-584). Elsevier, Inc.
- Ross, F. M., Harris, R., Fitzpatrick, J. M., & Abley, C. (2023). *Redfern's Nursing Older People (5th Edition)* (Fifth Edit). Elsevier, Inc.
- Sahar, J., Putri, Y. S. E., Simorangkir, D. S., Rekawati, E., & Silaswati, S. (2025). Upaya Penurunan Risiko Jatuh pada Lansia melalui Program OLORE. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 16(4), 895–900.
- Shiratsuchi, D., Makizako, H., Tabira, K., Miyake, Y., Kubozono, T., & Ohishi, M. (2026). Association Between Sarcopenia Defined by the Asian Working Group for Sarcopenia 2025 Criteria and Cognitive Function in Middle-Aged Community-Dwelling Adults. In *Geriatrics & gerontology international* (Vol. 26, Issue 3, p. e70426). <https://doi.org/10.1111/ggi.70426>
- Sieber, C. C. (2012). Sarcopenia and Frailty. In A. J. Cruz-Jentoft & J. E. Morley (Eds.), *Sarcopenia* (p. Chapter 11, 415). John Wiley & Sons, Inc.
- Thomas, D. R. (2012). Adverse Outcomes and Functional Consequences of Sarcopenia. In A. J. Cruz-Jentoft & J. E. Morley (Eds.), *Sarcopenia* (p. Chapter 8, 151-163). John Wiley & Sons, Inc.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tocchi, B. C. (2016). The Frailty Index for Elders (FIFE). *Best Practices in Nursing Care to Older Adults*, 173(34).
- Touhy, T. A., & Jett, K. F. (2016). *Ebersole and Hess' Toward Healthy Aging Human Needs and Nursing Response* (Ninth Edit). Elsevier Health Sciences.

BAB 2

DELIRIUM: DETEKSI DINI, TATA LAKSANA KEPERAWATAN, DAN PENCEGAHAN

CPL:

Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.

CPMK:

Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, *frailty*, dan risiko utama.

Sub CPMK

Melakukan deteksi dini delirium dan identifikasi faktor pemicu menggunakan alat skrining sederhana

Uraian Materi

A. Konsep Teori Delirium

1. Definisi

Delirium merupakan gangguan kesadaran akut yang sering di jumpai pada lansia dimana dapat berfluktuasi dalam satu hari dan sering tidak dikenali karena kemiripannya dengan demensia dan jika tidak ditangani segera dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif jangka panjang atau bahkan kematian (Junuda, 2025).

Delirium adalah gangguan kesadaran akut yang sering terjadi pada lansia terutama dalam konteks infeksi, dehidrasi atau penggunaan obat-obatan tertentu dimana merupakan manifestasi paling signifikan dari sindrom geriatri, namun sering kali disalah artikan sebagai demensia progresif (Kabak Dkk., 2025)

2. Deteksi Dini Delirium

Deteksi dini delirium adalah proses identifikasi perubahan akut pada fungsi kognitif, perhatian, dan kesadaran pada lansia sedini mungkin agar penanganan dapat segera dilakukan dan komplikasi dapat dicegah. Deteksi dini sangat penting karena delirium sering tidak dikenali, padahal dapat meningkatkan risiko jatuh, perpanjangan rawat inap, serta mortalitas pada lansia (Puerto et al., 2024)

3. Tanda dan Gejala Awal Delirium pada Lansia

Deteksi dini dapat dilakukan dengan memperhatikan perubahan mendadak dari kondisi mental sebelumnya seperti pada tabel berikut:

Gejala	Keterangan
Perubahan Kesadaran	Mengantuk berlebihan atau sangat gelisah Sulit mempertahankan perhatian
Gangguan Kognitif Akut	Kebingungan mendadak Disorientasi waktu, tempat dan orang
Gangguan Persepsi	Halusinasi (terutama visual) Ilusi atau salah menafsirkan lingkungan
Perubahan Perilaku	Gelisah atau justru sangat pasief Bicara tidak teratur
Gangguan siklus tidur	Insomnia Mengantuk di siang hari Gejala memburuk pada malam hari (<i>sundowning</i>)
Perubahan Emosi	Cemas, takut, mudah marah atau apatis
Gejala biasanya muncul secara akut dan berfluktuasi dalam 24 jam	
	Usia $\geq$ 65 tahun
	Demensia atau gangguan kognitif sebelumnya

Faktor Resiko yang Perlu Dideteksi	Infeksi (misalnya pneumonia atau infeksi saluran kemih)
	Dehidrasi atau malnutrisi
	Gangguan Metabolik
	Rawat inap atau operasi besar

Identifikasi faktor risiko ini penting karena dapat membantu mendeteksi delirium lebih cepat sebelum gejala menjadi berat.

B. Instrumen Skrining Nursing Delirium Screening Scale

Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) adalah alat skrining yang digunakan oleh perawat untuk mendeteksi secara cepat adanya delirium pada pasien, terutama pada pasien lansia yang dirawat di rumah sakit. Skala ini dikembangkan oleh L. Gaudreau dan tim pada tahun 2005 sebagai alat observasi klinis yang sederhana dan dapat digunakan dalam praktik keperawatan sehari-hari.

Nu-DESC menilai perubahan perilaku dan kognitif pasien yang khas pada delirium melalui observasi langsung oleh perawat selama interaksi dengan pasien.

No	Aspek Penilaian	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Disorientasi	Sadar, orientasi baik terhadap orang, tempat, dan waktu	Disorientasi tetapi mudah diarahkan kembali	Disorientasi ≥ 2 aspek atau tidak mudah diarahkan kembali
2	Perilaku Tidak Sesuai	Tenang dan kooperatif	Gelisah tetapi masih kooperatif	Agitasi, menarik alat medis, mencoba turun dari tempat tidur
3	Komunikasi Tidak Sesuai	Komunikasi jelas dan sesuai	Alur pikir tidak jelas atau bicara bertele-tele	Bicara tidak koheren / tidak dapat dimengerti
4	Ilusi / Halusinasi	Tidak ada	Paranoia atau ketakutan	Halusinasi atau distorsi objek visual
5	Retardasi Psikomotor	Tidak ada	Respons lambat / mengantuk	Mengantuk berlebihan, sangat lamban, letargis
Skor		Interpretasi		
0–1		Tidak menunjukkan delirium		
≥ 2		Skrining positif delirium → perlu evaluasi dan intervensi		

C. Aktivitas 1- *Knows How*

Seorang perempuan usia 75 tahun dibawa oleh keluarga ke puskesmas karena tampak bingung sejak tiga hari terakhir. Pasien sering berbicara sendiri dan tidak jelas, sulit fokus, dan tidak mengenali anaknya. Kondisi lebih buruk pada malam hari.

Hasil pengkajian menunjukkan

1. Bingung mendadak
2. Disorientasi
3. Gelisah
4. Halusinasi

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisa kondisi pada kasus. Pertanyaan diskusi:

1. Identifikasi tanda dan gejala delirium melalui pengkajian delirium
2. Menentukan interpretasi skor delirium berdasarkan Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC)
3. Menentukan masalah keperawatan prioritas pada pasien
4. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus

D. Aktivitas 2- *Shows How*

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor <i>station</i>	 (Dikosongkan)
2	Judul <i>station</i>	Asuhan Keperawatan Gerontik "Delirium Pada Lansia"
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan <i>station</i>	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi pencegahan delirium
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial

No.	Komponen	Isi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan usia 75 tahun dibawa oleh keluarga ke puskesmas karena tampak bingung sejak tiga hari terakhir. Pasien sering berbicara sendiri dan tidak jelas, sulit fokus, dan tidak mengenali anaknya. Kondisi lebih buruk pada malam hari dengan hasil pengkajian menunjukkan bingung mendadak, disorientasi, gelisah dan halusinasi TUGAS: 1. Lakukan pengkajian delirium 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan usia 75 tahun dibawa oleh keluarga ke puskesmas karena tampak bingung sejak tiga hari terakhir. Pasien sering berbicara sendiri dan tidak jelas, sulit fokus, dan tidak mengenali anaknya. Kondisi lebih buruk pada malam hari dengan hasil pengkajian menunjukkan bingung mendadak, disorientasi, gelisah dan halusinasi TUGAS: 1. Lakukan pengkajian pasien delirium (tentukan skor delirium) 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan Pengkajian Delirium 2. Menilai kemampuan peserta dalam menentukan diagnosa keperawatan (Diagnosa Keperawatan Konfusi Akut D.0064) 4. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: Pasien Perempuan, KS sebagai keluarga pasien 2. Riwayat penyakit sekarang: Pasien suka berbicara sendiri dan kadang lupa nama anak yang sering menemani nya dan tidak mampu fokus pada apa yang di bahas dan sudah 1 bulan terakhir tidak mampu tidur dengan nyenyak 3. Rawat Jalan di Puskesmas 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: Anak tampak cemas dengan kondisi orang tuanya 6. Harapan terhadap penyakit: Anak berharap orang tuanya dapat segera kembali mengingat dan penyakit tidak semakin parah

No.	Komponen	Isi
		7. Bila peserta menanyakan sejak kapan terjadi pada lansia jawaban KS 2: sejak tiga hari yang lalu bicara tidak jelas dan lupa dengan orang di sekitarnya termasuk anak nya 8. Bila peserta menanyakan bagaimana tidur lansia Jawaban KS 2: sering terbangun di malam hari dan berjalan sendiri tanpa arah 9. KS 2 duduk di samping lansia dengan wajah cemas. Lansia dapat di praktekkan langsung oleh KS 1. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	<i>Setting station</i>	Ruang Rawat Anak - Tempat tidur pasien - KS 1 : Pasien Lansia penderita delirium - KS 2 berperan sebagai keluarga pasien - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 7. Wastafel/<i>handrub</i>
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. <i>Handrub/hand sanitizer</i> 2. Catatan untuk pendokumentasian
12	Penulis	Friska Br Sembiring, S.Kep.,Ns.,M.Kep
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP PEMANTAUAN TINGKAT DELIRIUM

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Catatan perawat untuk pendokumentasian				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, nama lansia dan tanggal lahir/umur secara aktif dan nomor rekam medis)				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien an keluarga				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 15: sistematis)				
11	Monitor adanya perubahan status mental yang mendadak (akut)				
12	Monitor adanya perilaku abnormal yang berfluktuasi (hilang-timbul atau keparahan meningkat-menurun)				
13	Monitor kemampuan memusatkan perhatian (misalnya mudah teralih atau sulit mengikuti pembicaraan)				
14	Monitor adanya pemikiran tidak tertata atau tidak koheren (misalnya percakapan melantur atau tidak relevan, alur gagasan tidak jernih atau tidak logis, berganti topik secara tidak terduga)				
15	Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien				
D	Tahap Terminasi				
16	Menyimpulkan kegiatan				
17	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
18	Memberikan <i>reinforcement</i> positif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
19	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
20	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
21	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, skor tingkat delirium serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
22	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN GERONTIK DENGAN DELIRIUM

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengkaji dan memantau Tingkat Delirium					5	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					3	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN GERONTIK DENGAN
DELIRIUM

II. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengkaji Tingkat delirium pasien dengan pengkajian delirium seperti monitor perubahan status mental yang mendadak, adanya perilaku abnormal yang berfluktuasi, monitor kemampuan memusatkan perhatian, monitor adanya pemikiran tidak tertata atau tidak koheren misalnya percakapan melantur atau tidak relevan, aliran gagasan tidak jernih atau tidak logis, berganti ganti topik secara tidak terduga). Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					5	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.(Diagnosa Keperawatan Konfusi Akut)					3	
3. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan lansia, menjaga kenyamanan dan keamanan lansia, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

III. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus lansia dengan delirium	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda dehidrasi secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti frekuensi mengkaji status mental yang mendadak, perilaku abnormal yang berfluktuasi	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi perubahan status mental yang mendadak (akut), monitor adanya perilaku abnormal yang berfluktuasi (hilang-timbul atau keparahan meningkat-menurun), Monitor adanya pemikiran tidak tertata atau tidak koheren (misalnya percakapan melantur atau tidak relevan, aliran gagasan tidak jernih atau tidak logis, berganti-ganti topik secara tidak terduga)
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai masalah yang terjadi pada lansia (delirium)
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku	Menunjukkan sebagian kecil perilaku	Menunjukkan perilaku profesional yang	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

IV. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

V. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

E. DOPS (*Does*)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Gerontik dengan Delirium
- *Checklist* + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Gerontik dengan Delirium

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gerontik dengan Delirium
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam <i>encounter</i> singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan pengkajian dan pemantauan pada lansia dengan delirium
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang pengkajian dan pemantauan delirium tetapi juga mampu menegakkan diagnosa keperawatan pada lansia dengan delirium
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang perempuan usia 75 tahun dibawa oleh keluarga ke puskesmas karena tampak bingung sejak tiga hari terakhir. Pasien sering berbicara sendiri dan tidak jelas, sulit fokus, dan tidak mengenali anaknya. Kondisi lebih buruk pada malam hari dengan hasil pengkajian menunjukkan bingung mendadak, disorientasi, gelisah dan halusinasi
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan <i>encounter</i> klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda delirium sesuai dengan SOP dan sistematis serta menegakkan diagnosa keperawatan sesuai dengan kasus yang dialami oleh lansia
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali masalah yang dialami oleh lansia penderita delirium.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gerontik dengan Delirium
	penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya apa saja yang dialami pasien seperti tiba-tiba mengalami perubahan fungsi kognitif
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda-tanda delirium yang dialami oleh pasien
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus lansia dengan delirium, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menegakkan masalah keperawatan prioritas sehingga mampu merencanakan tindakan sesuai dengan prioritas masalah

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi *patient safety*
- *Feedback* CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Delirium

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gerontik dengan Delirium
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan anak dengan lansia yang mengalami delirium, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan sesuai dengan SOP, menetapkan masalah keperawatan, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat lansia dengan delirium, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada pasien dengan masalah delirium di komunitas atau di panti jompo
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus perempuan usia 75 tahun dengan delirium, yang tiba-tiba mengalami fluktuasi kognitif, tingkat kesadaran serta menegaskan diagnosis keperawatan prioritas.
Refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda delirium pada pasien lansia sehingga dapat segera mendapatkan pengobatan agar tidak membahayakan pasien dan orang di lingkungan sekitar
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari <i>Clinical Instructor</i> (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gerontik dengan Delirium
	yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	keluarga dan memantau pasien untuk melengkapi pengkajian yang jelas sehingga dapat menegakkan diagnose keperawatan
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus delirium, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan gerontik secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian delirium secara sistematis dan sesuai dengan SOP
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti otentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan anak dengan delirium, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep delirium, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. *Case Report* pada Asuhan Keperawatan Lansia dengan Delirium

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia dengan Delirium
Hakikat <i>case report</i>	<i>Case report</i> merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, <i>case report</i> berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang lansia perempuan berusia 75 tahun yang mendadak mengalami fluktuasi kognitif, tingkat kesadaran dan tidak mengingat orang di lingkungan sekitar
Tujuan	<i>Case report</i> bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas.
Isi laporan	Isi <i>case report</i> biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data	Pada kasus lansia dengan delirium mahasiswa mampu menjelaskan apa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia dengan Delirium
	subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	saja pengkajian pada lansia dengan delirium seperti mengalami fluktuasi fungsi kognitif, fluktuasi tingkat kesadaran, perilaku tidak memiliki tujuan dan tidak terarah
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data yang ditemukan saat pengkajian delirium dengan masalah utama.
Nilai edukatif	<i>Case report</i> membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus lansia dengan delirium mahasiswa belajar bahwa pengkajian delirium pada lansia sangat penting agar tidak membahayakan pasien serta lingkungan sekitar serta menegakkan diagnosa keperawatan dalam asuhan keperawatan gerontik.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep delirium pada lansia, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi *Patient Safety* pada Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan Delirium

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia dengan Delirium
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi <i>patient safety</i> merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus lansia dengan delirium, mahasiswa merefleksikan bahwa delirium yang tidak ditangani dengan cepat dapat berdampak bahaya kepada lansia dan orang di lingkungan sekitar nya
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau status delirium atau terlambat mengenali tanda delirium, dapat berdampak besar pada keselamatan lansia.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia dengan Delirium
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah penurunan kesadaran dan berbahaya kepada orang di lingkungan sekitar, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan status kesadaran, kognitif, aktivitas psikomotorik, kurang motivasi untuk memulai/menyelesaikan perilaku berorientasi tujuan dan terarah
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda delirium pada lansia sebelum terlambat
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada lansia dengan delirium harus dilakukan pengkajian secara sistematis dan sesuai dengan prosedur, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan gerontik secara berkelanjutan.

F. Ringkasan Materi

Bab ini menekankan bahwa delirium pada lansia merupakan masalah klinis yang dapat dijumpai dan dapat berkembang cepat menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan gerontik dengan delirium adalah mengenali tanda dan gejala dan harus di nilai secara sistematis. Delirium merupakan suatu kondisi gangguan fungsi otak yang terjadi secara akut dan ditandai dengan perubahan kesadaran, gangguan perhatian, serta penurunan fungsi kognitif. Pada kondisi Delirium, perubahan ini muncul secara tiba-tiba, biasanya dalam hitungan jam hingga hari, dan bersifat fluktuatif, artinya gejalanya dapat membaik dan memburuk dalam waktu yang singkat. Secara konsep, tanda utama delirium adalah ketidakmampuan pasien untuk memusatkan perhatian, mudah teralihkan, serta kesulitan mengikuti percakapan.

Selain itu, pasien juga dapat mengalami disorientasi terhadap waktu, tempat, maupun orang, gangguan memori jangka pendek, serta pola bicara yang tidak terstruktur atau tidak nyambung. Gangguan persepsi juga sering muncul, seperti halusinasi atau ilusi, yang membuat pasien melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dari segi perilaku, delirium dapat muncul dalam bentuk hiperaktif seperti gelisah, agresif, dan mudah marah, atau hipoaktif seperti apatis, lemah, dan lebih banyak diam. Selain itu, perubahan siklus tidur-bangun menjadi tanda penting, di mana pasien sering terjaga di malam hari dan mengantuk di siang hari.

Apabila delirium tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka secara konseptual akan terjadi perburukan fungsi otak yang semakin berat. Ketidakseimbangan neuro-transmitter di otak, seperti penurunan asetilkolin dan peningkatan dopamin, akan terus berlanjut sehingga memperparah gangguan kesadaran dan kognitif. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius, baik secara fisik maupun psikologis. Pasien berisiko mengalami dehidrasi dan malnutrisi karena tidak mampu makan dan minum dengan baik, serta berisiko jatuh akibat kebingungan dan gangguan orientasi. Selain itu, penyakit dasar yang menjadi penyebab delirium, seperti infeksi atau gangguan metabolik, dapat semakin memburuk karena tidak segera ditangani, bahkan dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa seperti sepsis. Lebih lanjut, keterlambatan penanganan delirium juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penurunan fungsi kognitif jangka panjang, bahkan menetap. Lama perawatan di rumah sakit menjadi lebih panjang, dan angka kematian pada pasien, terutama lansia, meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa delirium bukanlah kondisi ringan, melainkan suatu keadaan darurat medis yang membutuhkan penanganan segera.

Di sisi lain, peran keluarga sangat penting dalam mengenali tanda-tanda awal delirium. Namun, secara konsep, masalah sering muncul ketika keluarga tidak mampu membedakan delirium dengan kondisi lain seperti Demensia, yang umumnya terjadi secara perlahan. Karena delirium muncul mendadak, perubahan perilaku pasien sering kali disalahartikan sebagai “pikun biasa” atau akibat usia lanjut. Akibatnya, keluarga tidak segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan.

Ketidaktahuan keluarga terhadap tanda-tanda delirium menyebabkan keterlambatan dalam mencari pertolongan medis, sehingga kondisi pasien semakin memburuk. Selain itu, pasien juga berisiko mengalami cedera karena perilaku yang tidak terkontrol, seperti berjalan tanpa arah atau jatuh. Dalam situasi ini, beban keluarga juga meningkat karena harus menghadapi perubahan perilaku pasien yang mendadak dan sulit dipahami.

Mahasiswa diharapkan mampu mengenali kasus delirium pada lansia melalui pengkajian yang sistematis dan sesuai dengan SOP sehingga dapat dikenali apakah lansia menderita delirium atau tidak dan mengajarkan keluarga tentang mengenai tanda-tanda delirium.

Pada tahap menegakkan diagnosa keperawatan mahasiswa diharapkan mampu menganalisis data yang didapatkan dengan masalah keperawatan yang prioritas sehingga dapat dilanjutkan untuk intervensi keperawatan yang tepat untuk dilakukan

Dengan demikian, secara konseptual dapat disimpulkan bahwa delirium adalah kondisi akut yang harus dikenali sejak dini. Ketidakmampuan keluarga dalam mengenali tanda-tandanya serta keterlambatan penanganan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, memperburuk kondisi pasien, dan meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tanda-tanda delirium menjadi sangat penting, terutama bagi keluarga yang merawat pasien lansia.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan gerontik dengan delirium harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran *skill lab* maupun praktik klinik pada Keperawatan Keluarga

G. Tabel *Red Flags* & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Gerontik dengan Delirium

<i>Red flags</i>	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Fluktuasi Fungsi Kognitif	perubahan naik-turun kemampuan berpikir, kesadaran, dan perhatian pasien dalam waktu singkat (jam hingga hari) yang menunjukkan adanya gangguan akut pada fungsi otak.	Pantau lansia dan berikan benda seperti kalender, jam untuk melatih daya ingat kembali
Fluktuasi Tingkat kesadaran	adanya perubahan naik-turun dalam kesadaran pasien (dari sadar penuh hingga menurun) yang terjadi dalam waktu singkat (jam hingga hari), yang menunjukkan adanya disfungsi otak akut dan kondisi yang tidak stabil.	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan dan tetap anjurkan ada keluarga yang mengunjungi lansia jika terjadi penurunan kesadaran segera di bawa ke fasilitas kesehatan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Fluktuasi aktivitas psikomotorik	adanya perubahan naik-turun pada aktivitas gerakan dan perilaku pasien (dari sangat aktif hingga sangat pasif) dalam waktu singkat, yang menunjukkan gangguan fungsi otak akut dan ketidakstabilan kondisi neurologi	Temani selalu lansia agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang di sekitar
Kurang motivasi memulai/menyelesaikan perilaku berorientasi tujuan	adanya penurunan dorongan internal (motivasi) dan inisiatif pasien untuk melakukan aktivitas yang memiliki tujuan jelas, yang menunjukkan gangguan fungsi kognitif dan regulasi perilaku akibat disfungsi otak.	Monitor setiap tindakan yang dilakukan lansia dengan menjauhkan benda yang berbahaya dan meningkatkan pencahayaan
Kurang motivasi memulai/menyelesaikan perilaku berorientasi perilaku terarah	adanya penurunan inisiatif, dorongan, dan kemampuan pasien untuk memulai serta menuntaskan suatu aktivitas yang memiliki tujuan, yang mencerminkan gangguan fungsi kognitif dan regulasi perilaku akibat disfungsi otak	Monitor setiap tindakan yang dilakukan lansia dengan menjauhkan benda yang berbahaya dan meningkatkan pencahayaan
Gelisah/Agitasi	adanya peningkatan aktivitas psikomotorik yang tidak terkontrol disertai rasa tidak nyaman, tegang, atau cemas, yang mencerminkan gangguan fungsi otak dan ketidakstabilan kondisi pasien.	Segera eskalasi untuk evaluasi medis lebih lanjut seperti kolaborasi pemberian obat ansietas atau agitasi, jika perlu
Halusinasi	Gangguan persepsi sensorik di mana pasien merasakan sesuatu tanpa adanya rangsangan nyata, yang menunjukkan disfungsi otak, terutama pada proses interpretasi dan integrasi rangsangan.	Laporkan segera, tingkatkan kewaspadaan terhadap perburukan

Bab Asuhan Keperawatan Gerontik dengan Delirium

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / *Skill Lab* : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya mampu monitor adanya perubahan status mental yang mendadak (akut)	☐	☐	
2	Saya melakukan pengkajian adanya perilaku abnormal yang berfluktuasi (hilang-timbul atau keparahan meningkat-menurun)	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji kemampuan lansia memusatkan perhatian (misalnya mudah teralih atau sulit mengikuti pembicaraan)	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji lansia dengan adanya pemikiran yang tidak tertata atau tidak koheren (misalnya percakapan melantur atau tidak relevan, aliran gagasan tidak jernih atau tidak logis, berganti-ganti topik secara tidak terduga)	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Referensi

- Bellelli, G., et al. (2020). *Diagnostic accuracy of the 4AT for delirium detection: systematic review and meta-analysis*. Age and Ageing.
- El-Hussein, M. et al. (2021). *Comparison of delirium screening tools in older adults*. Journal of Emergency Nursing.
- González, M., et al. (2023). *Adaptation and validation of the 4AT delirium screening tool in emergency departments*. BMC Nursing.
- Kabak, dkk (2025). Keperawatan Paliatif Lanjut Usia. CV Eureka Media Aksara.
- Lin, C. J., Fick, D. M., Traynor, V., Chen, Y. C., Hsiang, H. F., & Chiu, H. Y. (2025). Comparative Diagnostic Accuracy of Nursing Delirium Screening Scale Versus Confusion Assessment Method for Postoperative Delirium: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 34(1), 287-298.
- Morales-Puerto, M., Ruiz-Díaz, M., García-Mayor, S., León-Campos, Á., Morales-Asencio, J. M., Canca-Sánchez, J. C., ... & Aranda-Gallardo, M. (2024). Spanish transcultural adaptation of the 4AT score for the evaluation of delirium in the emergency department: a prospective diagnostic test accuracy study. *BMC nursing*, 23(1), 101.
- O'Sullivan, D., et al. (2021). *Diagnostic accuracy and clinical applicability of the 4AT assessment test for delirium detection*. BMC Geriatrics.
- Suyasa, dkk. (2025) . Asuhan Keperawatan Gerontik Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP) . Optimal Untuk Negeri

- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

BAB 3

ULKUS TEKAN DAN PERAWATAN KULIT LANSIA: PENCEGAHAN HINGGA PERAWATAN LUKA

CPL

CPL-1 : Menunjukkan profesionalisme, etika, kepatuhan aspek legal, dan advokasi hak lansia dalam praktik keperawatan.

CPL-3 : Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.

CPL-4 : Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis *evidence* dengan tujuan terukur.

CPL-5 : Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan lansia, keluarga, serta tim kesehatan.

CPL-6 : Menerapkan mutu–keselamatan pasien, dokumentasi, dan *continuity of care* dalam asuhan keperawatan lansia.

CPMK

CPMK-3 : Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, frailty, dan risiko utama.

CPMK-6 : Mengelola dokumentasi, continuity of care, serta strategi mutu–keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.

CPMK-7 : Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan.

A. Ulkus Tekan

1. Pengertian Ulkus Tekan

Ulkus tekan adalah cedera lokal pada kulit dan/atau jaringan di bawahnya yang biasanya terjadi di atas tonjolan tulang sebagai akibat dari tekanan atau kombinasi antara tekanan dan gaya geser (NPIAP, 2019).

Ulkus tekan merupakan kerusakan jaringan yang terjadi akibat tekanan berkepanjangan yang mengganggu aliran darah ke jaringan sehingga menyebabkan iskemia dan nekrosis (Krasner et al., 2020).

Ulkus tekan adalah luka yang berkembang akibat tekanan terus-menerus pada jaringan lunak yang menyebabkan gangguan perfusi, kerusakan sel, dan akhirnya terbentuk luka terbuka (Jaul & Calderon-Margalit, 2019).

Ulkus tekan merupakan cedera pada kulit dan jaringan lunak yang disebabkan oleh tekanan berkepanjangan sehingga mengganggu perfusi jaringan dan menyebabkan nekrosis (SOP Keterampilan Keperawatan, 2024).

2. Klasifikasi/ Stadium Ulkus Tekan

Klasifikasi ulkus tekan dibagi menjadi 4 stadium berdasarkan kedalaman kerusakan jaringan:

a. Stadium I

Ditandai dengan kulit yang masih utuh namun terdapat kemerahan yang menetap (*non-blanchable erythema*), terutama pada area penonjolan tulang. Kulit dapat terasa lebih hangat atau dingin, serta lebih keras atau lunak dibanding jaringan sekitarnya (Sari, 2020)

b. Stadium II

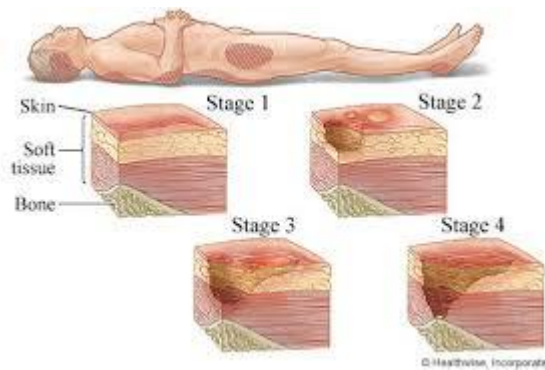
Terjadi kehilangan sebagian ketebalan kulit yang melibatkan epidermis dan/atau dermis. Luka bersifat superfisial dan dapat tampak sebagai lecet, lepuhan (*blisters*), atau luka dangkal (Sari, 2020)

c. Stadium III

Terjadi kehilangan seluruh ketebalan kulit dengan kerusakan jaringan subkutan. Lemak subkutan dapat terlihat, namun tulang, tendon, atau otot belum tampak. Luka biasanya tampak sebagai lubang yang dalam (Mentari, 2018)

d. Stadium IV

Merupakan kerusakan paling berat, yaitu kehilangan seluruh ketebalan jaringan kulit dengan kerusakan luas hingga mengenai otot, tulang, atau struktur pendukung seperti tendon dan sendi. Luka tampak dalam dan dapat disertai jaringan nekrosis (Mentari, 2018).



Gambar 3.1

Sumber: Ignite Healthwise, LLC., 2024

3. Etiologi

a. Penyebab utama

1) Tekanan (*pressure*)

Tekanan yang berlangsung lama pada area tubuh tertentu, terutama di atas tonjolan tulang, akan menekan pembuluh darah kapiler sehingga aliran darah ke jaringan terhambat. Kondisi ini menyebabkan jaringan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi (iskemia), yang jika berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan kematian sel dan terbentuknya ulkus tekan.

2) Gaya geser (*shear*)

Gaya geser terjadi ketika kulit tetap pada posisi tertentu sementara jaringan di bawahnya bergeser, misalnya saat pasien tergelincir di tempat tidur. Hal ini menyebabkan pembuluh darah tertarik dan terdistorsi sehingga aliran darah terganggu. Gaya geser sering menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih dalam meskipun permukaan kulit tampak utuh.

3) Gesekan (*friction*)

Gesekan terjadi ketika kulit bergesekan dengan permukaan kasar seperti sprei atau pakaian. Gesekan dapat merusak lapisan epidermis sehingga kulit menjadi lecet dan lebih rentan terhadap cedera serta infeksi. Meskipun dampaknya lebih superfisial dibanding tekanan dan shear, gesekan tetap berkontribusi dalam pembentukan luka tekan (Zaidi, 2024).

b. Mekanisme patofisiologi penyebab

Berdasarkan *guideline* terbaru, terdapat beberapa teori utama penyebab kerusakan jaringan:

1) Iskemia local (kurang aliran darah)

Iskemia terjadi akibat berkurangnya aliran darah ke jaringan karena tekanan yang berkepanjangan. Akibatnya, sel-sel kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga mengalami kerusakan dan akhirnya nekrosis.

2) Reperfusi (kerusakan saat aliran kembali)

Reperfusi terjadi ketika tekanan dilepaskan dan aliran darah kembali ke jaringan. Namun, proses ini dapat menyebabkan kerusakan tambahan akibat terbentuknya radikal bebas dan respon inflamasi yang memperparah cedera jaringan.

3) Gangguan drainase limfatik

Tekanan yang berkepanjangan juga dapat menghambat aliran limfatik, sehingga cairan dan zat sisa metabolisme menumpuk di jaringan. Hal ini menyebabkan edema dan memperburuk kerusakan jaringan.

4) Deformasi sel langsung

Tekanan mekanik yang kuat dapat menyebabkan deformasi langsung pada sel dan struktur jaringan, sehingga merusak membran sel dan fungsi seluler. Kerusakan ini dapat terjadi lebih cepat dibandingkan mekanisme iskemia (EPUAP, 2019)

c. Faktor Risiko internal

1) Imobilisasi

Pasien yang tidak dapat bergerak secara mandiri memiliki risiko tinggi mengalami tekanan terus-menerus pada area tertentu, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya ulkus tekan.

2) Malnutrisi

Kekurangan nutrisi, terutama protein, vitamin, dan mineral, akan menghambat regenerasi jaringan dan menurunkan daya tahan kulit terhadap tekanan.

3) Gangguan kesadaran

Pasien dengan penurunan kesadaran tidak mampu merasakan atau merespon tekanan, sehingga tidak melakukan perubahan posisi secara spontan.

4) Inkontinensia (kelembaban)

Paparan urin atau feses menyebabkan kulit menjadi lembab dan mudah rusak, sehingga meningkatkan risiko iritasi dan infeksi.

5) Penyakit kronis

Penyakit seperti diabetes, gangguan vaskular, dan penyakit neurologis dapat menurunkan perfusi jaringan serta memperlambat proses penyembuhan luka (Kaya, 2025)

d. Faktor Risiko eksternal

1) Lama rawat inap

Semakin lama pasien dirawat di tempat tidur, semakin besar risiko terpapar tekanan berkepanjangan yang dapat menyebabkan ulkus tekan.

2) Penggunaan alat medis (kateter, oksigen, dll)

Alat seperti kateter, oksigen, atau alat penunjang lainnya dapat memberikan tekanan tambahan pada kulit jika tidak diposisikan dengan baik.

3) Posisi tubuh yang tidak berubah

Posisi tubuh yang tidak diubah dalam waktu lama menyebabkan tekanan terus-menerus pada area tertentu, sehingga meningkatkan risiko kerusakan jaringan (Beriso, 2024).

4. Patofisiologi

Luka tekan terjadi akibat tekanan antara penonjolan tulang dan permukaan luar yang melebihi tekanan kapiler normal yaitu pada rentang 16 sampai 32 mmHg yang dapat menyebabkan iskemia jaringan. Iskemia jaringan adalah tidak adanya darah secara lokal atau penurunan aliran darah akibat obstruksi mekanika (Pires & Muller, 1991 dalam Potter & Perry, 2005). Penurunan aliran darah menyebabkan daerah tubuh menjadi pucat. Pucat terlihat ketika adanya warna kemerahan pada pasien berkulit terang. Pucat tidak terjadi pada pasien yang berkulit pigmen gelap. Setelah periode iskemi, kulit yang terang mengalami satu atau dua perubahan hiperemi.

Hiperemia reaktif normal (kemerahan) merupakan efek vasodilatasi lokal yang terlihat, respon tubuh normal terhadap kekurangan aliran darah pada jaringan dibawahnya, area pucat setelah dilakukan tekanan dengan ujung jari dan hiperemia reaktif akan menghilang dalam waktu kurang dari satu jam. Kelainan hiperemia reaktif adalah vasodilatasi dan indurasi yang berlebihan sebagai respon dari tekanan. Kulit terlihat berwarna merah muda terang hingga merah. Indurasi adalah area edema lokal dibawah kulit. Kelainan hiperemia reaktif dapat hilang dalam waktu antara lebih dari 1 jam hingga 2 minggu setelah tekanan dihilangkan (Pirres & Muller, 1991 dalam Potter & Perry, 2005).

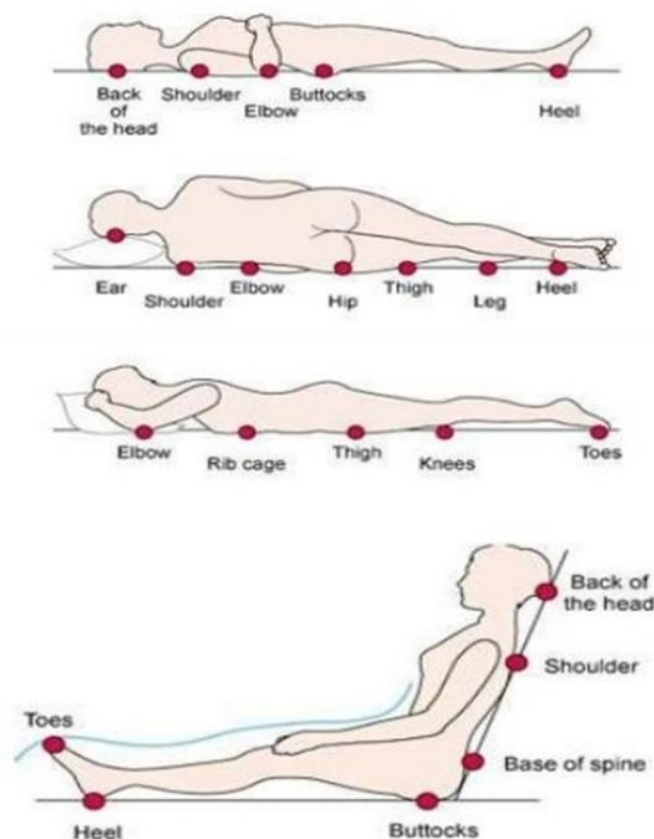
Ketika pasien berbaring atau duduk maka berat badan berpindah pada penonjolan tulang. Semakin lama tekanan diberikan, semakin besar resiko kerusakan kulit. Tekanan menyebabkan penurunan suplai darah pada jaringan sehingga terjadi iskemi. Apabila tekanan dilepaskan akan terdapat hiperemia reaktif, atau peningkatan aliran darah yang tiba-tiba ke daerah tersebut. Hiperemia reaktif merupakan suatu respons kompensasi dan hanya efektif jika tekan dikulit di hilangkan sebelum terjadi nekrosis atau kerusakan. (Potter & Perry, 2005).

Selain faktor mekanik yang disebutkan diatas terdapat juga faktor lain yang mendasari terjadinya ulkus tekanan seperti infeksi, malnutrisi, penyakit neurologis, cedera tulang belakang, penurunan masa tubuh dan peningkatan

kebutuhan metabolik. Keadaan diperberat oleh adanya *friction* (gesekan) dan *shear force* (gesek tekan) pada daerah tersebut.

Beberapa hal penting yang berperan dalam terjadinya luka tekan dihubungkan dengan tekanan dan waktu. Cedera jaringan lunak dapat terjadi dalam waktu 2 jam pada tekanan 500 mmHg, sementara pada tekanan 100 mmHg terjadinya cedera memerlukan waktu 10 jam. Selain itu jenis jaringan lunak juga menentukan ketahanan terhadap penekanan otot. Hasil akhir proses ini dapat kita lihat bahwa nekrosis pada kulit biasanya lebih kecil dibandingkan area nekrosis dekat tulang, yang tampak seperti corong terbalik. Hal ini menyebabkan fenomena "gunung es", dimana bagian yang mengalami kerusakan yang paling luas terletak di bagian dalam, yang lebih dekat dengan tulang.

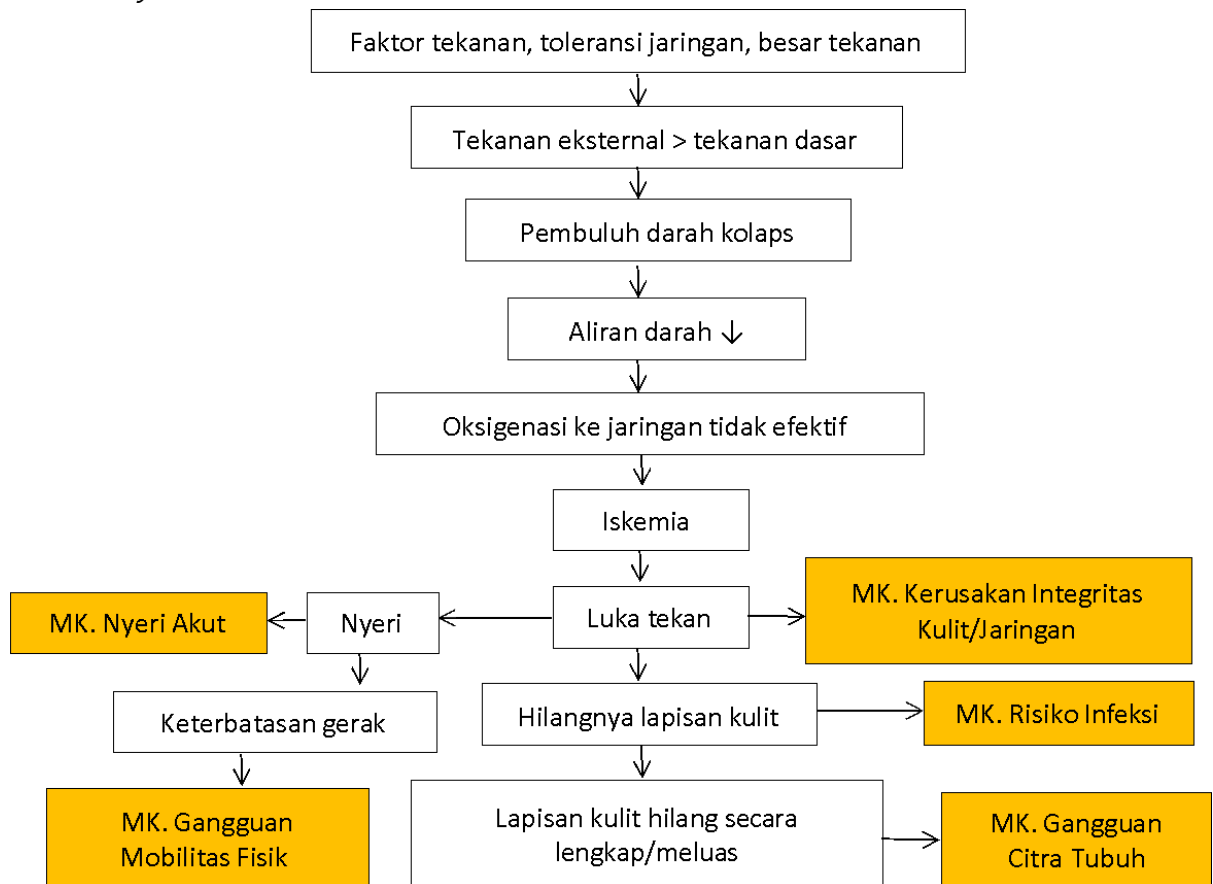
Ulkus tekanan terjadi pada tempat dengan tulang menonjol yang menekan kulit dan jaringan dibawahnya. Tempat tersebut adalah *scalp*, punggung, tulang ekor, sakrum, tumit dan tempat lain pada tubuh yang mendapat tekanan bila penderita berbaring dalam waktu yang lama, lokasi tersering (96%) adalah level umbilikus, yaitu sakrum (36-60%), iskiurn (6%), trokanter (6%) dan tumit (30%).



Gambar 3.2

Sumber: Agrawal et al., 2012

5. Pathway

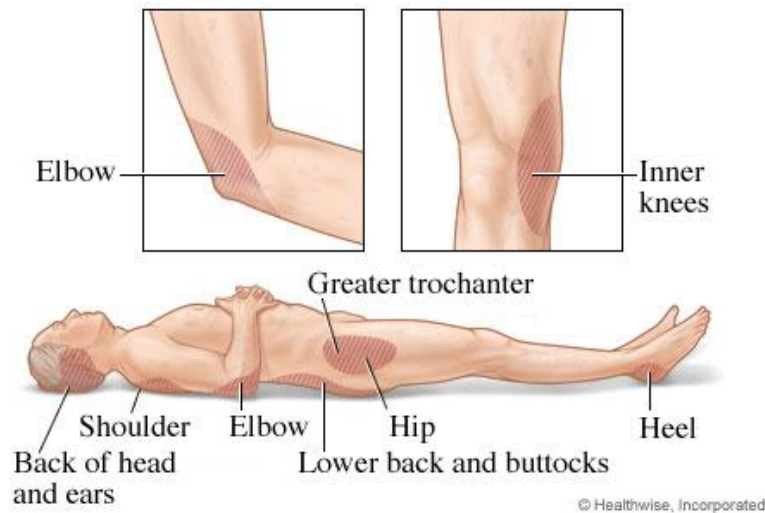


Sumber: Wijaya, A. S., & Putri, Y. M., 2013

6. Lokasi yang sering terjadi

a. Sakrum dan tumit

Berdasarkan penelitian terbaru, lokasi ulkus tekan paling sering ditemukan pada sakrum dan tumit. Hal ini karena kedua area tersebut merupakan tonjolan tulang yang sering mengalami tekanan saat pasien berbaring dalam waktu lama. Dalam sebuah studi, lokasi tersering adalah tumit (36%) dan sakrum (29%) pada pasien rawat inap (Ginting, dkk, 2024).



Gambar 3.3
Sakrum dan Tumit

Sumber: Ignite Healthwise, LLC., 2024

b. Bokong/ gluteal (ischium)

Penelitian lain menunjukkan bahwa daerah bokong merupakan lokasi yang paling sering mengalami ulkus tekan, terutama pada pasien dengan posisi duduk atau tirah baring lama. Studi di rumah sakit menunjukkan prevalensi tertinggi berada pada area bokong sebesar 45,1%.

c. Area tonjolan tulang lain (pinggul, siku, tumit)

Secara umum, ulkus tekan paling sering terjadi pada area tonjolan tulang, seperti:

- 1) Tulang ekor (ocal)
- 2) Pinggul (trokanter)
- 3) Siku
- 4) Tumit (Hidayannah, 2025)

7. Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala ulkus tekan berdasarkan stadium luka tekan menurut NPIAP (2016):

a. Stadium I

- 1) Warna kulit berbeda dibandingkan dengan kulit sekitarnya. Pada orang dengan kulit putih cenderung berwarna kemerahan sedangkan pada kulit gelap cenderung merah menetap, biru atau ungu
- 2) Terasa nyeri
- 3) Perubahan sensasi (gatal atau nyeri)
- 4) Lembek
- 5) Hangat

b. Stadium II

- 1) Hilangnya lapisan kulit epidermis atau dermis atau keduanya
- 2) Dasar luka tampak merah atau pink disertai slaf
- 3) Bullae terbuka
- 4) Abrasi
- 5) Melepuh

c. Stadium III

- 1) Hilangnya lapisan kulit secara lengkap atau kerusakan jaringan subkutan atau lebih dalam namun tidak sampai mencapai fascia
- 2) Adanya slaf, slough, undermining dan tunnelling
- 3) Kedalaman luka tergantung Lokasi luka tekan dan kondisi anatomi

d. Stadium IV

- 1) Hilangnya jaringan secara penuh sampai tulang, tendon dan otot
- 2) Adanya slaf, ekshar, undermining, dan tunnelling (NPIAP (National Pressure Injury Advisor Panel), 2016).

8. Komplikasi

a. Infeksi Lokal (Selulitis)

Infeksi dapat menyebar dari luka tekan ke jaringan kulit di sekitarnya dan menyebabkan selulitis, yang ditandai dengan kemerahan, nyeri, pembengkakan, dan peningkatan suhu local. Jika tidak ditangani, infeksi dapat meluas ke jaringan yang lebih dalam.

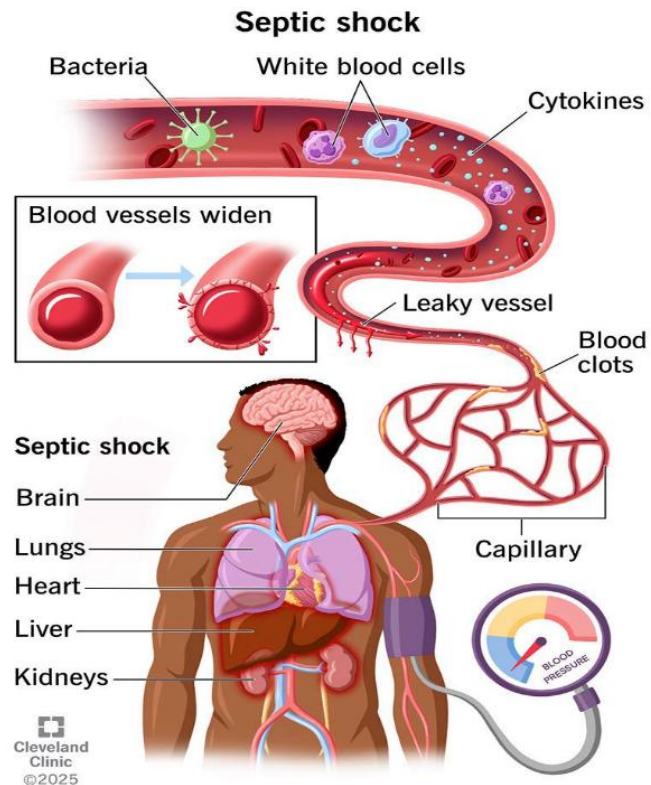


Gambar 3.4
Infeksi Lokal

Sumber: Nam, et al., 2025

b. Sepsis (keracunan darah)

Infeksi dari ulkus tekan dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan sepsis, yaitu kondisi serius yang dapat menyebabkan kegagalan organ dan syok eptic. Gejalanya meliputi demam, denyut jantung cepat, tekanan darah menurun, dan kondisi umum memburuk.

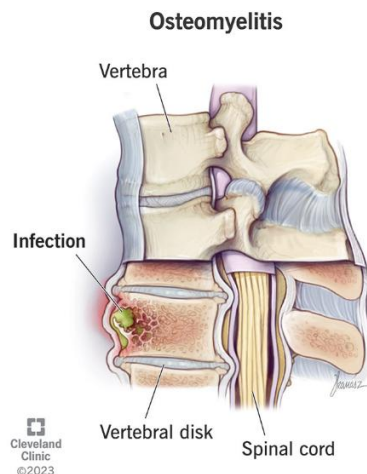


Gambar 3.5
Sepsis

Sumber: Cleveland Clinic., 2025

c. Osteomielitis dan Infeksi Sendi

Infeksi dapat menyebar ke tulang (osteomielitis) dan sendi (arthritis septik). Kondisi ini menyebabkan kerusakan jaringan tulang, nyeri hebat, dan gangguan fungsi ekstremitas.



Gambar 3.6

Osteomielitis dan Infeksi Sendi

Sumber: Lim, S., & Kho, K. A., 2024

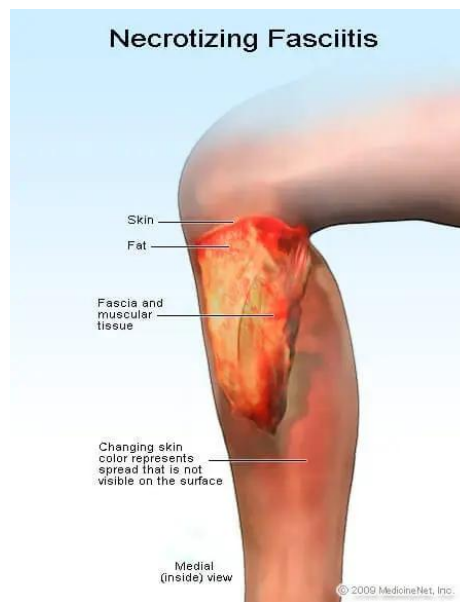
d. Fascitis Nekrotikans

Merupakan infeksi berat yang cepat menyebar dan menyebabkan kematian jaringan lunak (dikenal sebagai “bakteri pemakan daging”). Kondisi ini membutuhkan penanganan darurat berupa antibiotik dan pembedahan.



Gambar 3.7
Fascitis Nekrotikans

Sumber: Silva, H., Chellappan, K., & Karunaweera, N., 2021



Sumber: MedicineNet, Inc., 2009

e. Gangren gas

Infeksi oleh bakteri *Clostridium* dapat menyebabkan gangren gas, yaitu kondisi serius dengan pembentukan gas dalam jaringan, nyeri hebat, dan kerusakan jaringan cepat. Dapat berujung amputasi jika tidak ditangani segera (HSE = *Health Service Executive*), 2021).



Gambar 3.8
Gangren Gas

Sumber: Cleveland Clinic., 2025

9. Pencegahan Ulkus Tekan

a. Pengkajian Risiko Secara Dini

Penilaian risiko harus dilakukan sejak awal perawatan menggunakan alat seperti *Braden Scale* untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi. Pendekatan ini penting agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran (Kemenkes, 2023)

b. Reposisi / Perubahan Posisi

Pasien perlu diubah posisinya secara berkala setiap 2–4 jam untuk mengurangi tekanan pada area tertentu dan mencegah iskemia jaringan (RNA, 2024)

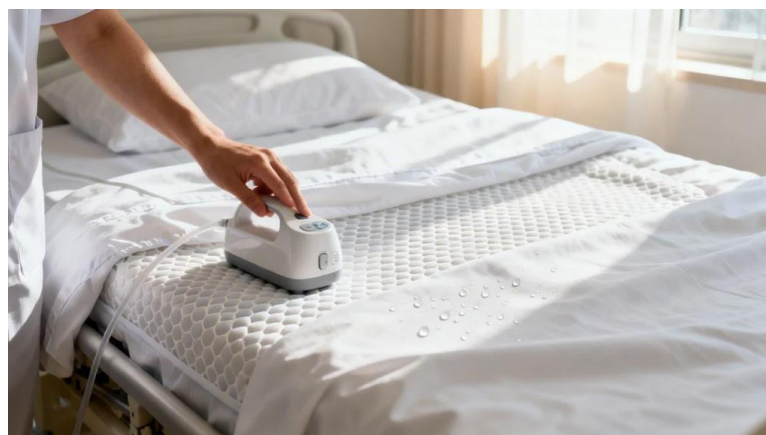


Gambar 3.9
Perubahan Posisi

Sumber: Northern HSC Trust & Public Health Agency, HSC Northern Ireland., 2021

c. Penggunaan *Support Surface* (Kasur Khusus)

Penggunaan kasur khusus, bantal, atau alat redistribusi tekanan dianjurkan untuk mengurangi tekanan pada tonjolan tulang dan meningkatkan kenyamanan pasien.



Gambar 3.10
Penggunaan Support Surface
Sumber: McNichol, L., et al., 2020

d. Perawatan dan Inspeksi Kulit

Kulit harus diperiksa secara rutin untuk mendeteksi tanda awal luka tekan. Selain itu, menjaga kulit tetap bersih dan kering, mengontrol kelembaban (inkontinensia, keringat) dan menggunakan pelembab. Perawatan ini membantu menjaga integritas kulit dan mencegah kerusakan.



Gambar 3.11
Perawatan dan Inspeksi Kulit

Sumber: <https://www.istockphoto.com/photos/elderly-woman-bathroom>

e. Mobilisasi Dini

Mobilisasi atau aktivitas fisik sedini mungkin sangat dianjurkan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan yang menetap pada satu area tubuh.



Gambar 3.12
Mobilisasi Dini

Sumber: <https://www.istockphoto.com/photos/nurse-helping-patient-out-of-b>

10. Penatalaksanaan Ulkus Tekan

a. Mengurangi tekanan (*pressure relief*)

Intervensi utama adalah menghilangkan tekanan pada area luka, dengan cara:

- 1) reposisi rutin
- 2) penggunaan kasur khusus (air mattress)
- 3) bantalan pada area tulang menonjol (Gould, 2024)

b. Perawatan luka (wound care management)

Pendekatan modern menggunakan konsep TIME (*Tissue, Infection, Moisture, Edge*) untuk mempercepat penyembuhan. Perawatan luka meliputi:

- 1) pembersihan luka
- 2) penggunaan balutan modern (modern dressing)
- 3) menjaga kelembaban luka optimal (Kemenkes, 2024)

c. Debridement (pengangkatan jaringan mati)

Debridement dilakukan untuk:

- 1) mengangkat jaringan nekrotik
- 2) mempercepat penyembuhan
- 3) mencegah infeksi

Metode dapat berupa:

- 1) mekanik
- 2) enzimatik
- 3) bedah (Alomedika, 2024)

d. Manajemen infeksi

Infeksi harus dikontrol untuk mencegah komplikasi seperti sepsis.

Jika terdapat infeksi:

- 1) diberikan antibiotik topikal atau sistemik
- 2) dilakukan kultur luka bila perlu (Gould, 2024)

e. Terapi nutrisi

Nutrisi sangat penting untuk regenerasi jaringan dan penyembuhan luka.

Pasien membutuhkan:

- 1) energi: $\pm 30\text{--}35$ kkal/kgBB/hari
- 2) protein tinggi
- 3) vitamin dan mineral (Alomedika, 2024)

f. Terapi tambahan

Terapi tambahan meliputi:

- 1) Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
- 2) fisioterapi / mobilisasi
- 3) edukasi pasien & keluarga (Gould, 2024)

g. Pendekatan multidisiplin

Penatalaksanaan ulkus tekan membutuhkan kolaborasi:

- 1) Perawat
- 2) Dokter
- 3) ahli gizi
- 4) fisioterapis (NPIAP, 2024).

B. Perawatan Kulit

1. Pengertian perawatan kulit

Perawatan kulit lansia adalah upaya menjaga kebersihan, kelembaban, dan integritas kulit pada usia lanjut untuk mencegah kerusakan kulit, infeksi, serta komplikasi seperti ulkus tekan (*Fundamental of Nursing*, 2020).

2. Perubahan kulit pada lansia

Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan fisiologis kulit, antara lain:

a. Kulit menjadi lebih tipis

Seiring bertambahnya usia, lapisan epidermis dan dermis mengalami penipisan. Hal ini terjadi karena:

- 1) Penurunan produksi sel kulit baru (regenerasi melambat)
- 2) Berkurangnya jaringan kolagen dan elastin

Dampak:

- 1) Kulit lebih rentan terhadap luka dan memar
- 2) Pembuluh darah lebih mudah terlihat
- 3) Perlindungan terhadap lingkungan menurun

b. Elastisitas menurun

Elastisitas kulit dipengaruhi oleh serat kolagen dan elastin. Pada lansia:

- 1) Produksi kolagen menurun
- 2) Serat elastin menjadi kaku dan rusak

Dampak:

- 1) Muncul keriput dan garis halus
- 2) Kulit menjadi kendur (tidak kencang)
- 3) Kemampuan kulit Kembali ke bentuk semula berkurang

c. Produksi minyak berkurang → kulit kering

Kelenjar sebasea (penghasil minyak) mengalami penurunan fungsi:

- 1) Produksi sebum berkurang
- 2) Kelembapan alami kulit menurun

Dampak:

- 1) Kulit menjadi kering (xerosis)
 - 2) Mudah gatal dan bersisik
 - 3) Risiko iritasi meningkat
- d. Penyembuhan luka lebih lambat
- Proses penyembuhan luka melambat karena:
- 1) Aliran darah ke kulit berkurang
 - 2) Respon imun menurun
 - 3) Produksi kolagen untuk perbaikan jaringan lebih sedikit

Dampak:

- 1) Luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh
- 2) Risiko infeksi meningkat
- 3) Mudah terjadi luka tekan (pressure ulcer) (gerontologi nursing, eliopoulus, C, 2022).

3. Masalah kulit yang sering terjadi pada lansia

Beberapa masalah kulit yang umum terjadi pada lansia:

- a. Kulit kering (xerosis)
- b. Pruritus (gatal)
- c. Luka tekan (ulkus dekubitus)
- d. Infeksi kulit
- e. Lecet atau luka akibat gesekan

4. Tujuan perawatan kulit lansia

- a. Menjaga kebersihan kulit
Kebersihan kulit penting karena pada lansia terjadi penurunan fungsi kulit sehingga mudah terjadi penumpukan kotoran, keringat, dan mikroorganisme.
- b. Mencegah kerusakan kulit
Kulit lansia lebih tipis dan rapuh sehingga mudah mengalami lecet atau robekan.
- c. Mencegah infeksi
Kulit merupakan garis pertahanan pertama tubuh. Pada lansia, fungsi ini menurun.
- d. Meningkatkan kenyamanan lansia
Kulit yang bersih dan lembap memberikan rasa nyaman secara fisik dan psikologis.
- e. Mencegah ulkus tekan
Ulkus tekan sering terjadi pada lansia yang kurang mobilitas (tirah baring).

5. Prinsip perawatan kulit lansia
 - a. Menjaga kebersihan kulit dengan cara:
 - 1) Mandi secara teratur
 - 2) Gunakan sabun lembut
 - 3) Keringkan dengan hati-hati
 - b. Menjaga kelembaban kulit dengan cara:
 - 1) Gunakan pelembab (lotion/ krim)
 - 2) Hindari kulit terlalu kering
 - 3) Perhatikan area lipatan
 - c. Pencegahan luka tekan dengan cara:
 - 1) Ubah posisi secara berkala
 - 2) Gunakan alas/ Kasur khusus
 - 3) Hindari tekanan lama pada satu titik
 - d. Nutrisi yang adekuat dengan cara:
 - 1) Konsumsi protein cukup
 - 2) Vitamin dan mineral
 - 3) Cukupi cairan
 - e. Menghindari cedera kulit dengan cara:
 - 1) Hindari gesekan dan tekanan
 - 2) Gunakan teknik mobilisasi yang benar
 - 3) Gunakan pakaian yang nyaman

6. Peran perawat dalam perawatan kulit lansia

- a. Melakukan pengkajian kondisi kulit

Peran perawat dalam perawatan kulit lansia sangat penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya komplikasi. Menurut prinsip keperawatan gerontologi yang dikemukakan oleh Charlotte Eliopoulos, perawat memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengkajian kondisi kulit secara menyeluruh. Pengkajian ini meliputi observasi terhadap warna, kelembapan, tekstur, elastisitas kulit, serta adanya tanda-tanda kerusakan seperti luka, kemerahan, atau infeksi. Selain itu, perawat juga perlu mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi kulit, seperti imobilitas, status nutrisi, dan penyakit penyerta, sehingga dapat menentukan intervensi yang tepat.

- b. Memberikan perawatan kulit secara rutin

Selain melakukan pengkajian, perawat juga berperan dalam memberikan perawatan kulit secara rutin. Perawatan ini dilakukan dengan menjaga kebersihan kulit menggunakan teknik yang lembut, memberikan pelembab untuk mencegah kekeringan, serta memastikan pakaian dan tempat tidur tetap bersih dan kering. Pada lansia dengan keterbatasan mobilitas, perawat

juga perlu melakukan reposisi secara berkala untuk mencegah tekanan berlebih pada area tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk mempertahankan integritas kulit serta mencegah terjadinya kerusakan atau iritasi.

c. Edukasi pasien dan keluarga

Peran lain yang tidak kalah penting adalah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Perawat bertindak sebagai edukator dengan memberikan informasi mengenai pentingnya perawatan kulit, cara menjaga kebersihan dan kelembapan kulit, serta mengenali tanda-tanda awal kerusakan atau infeksi. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam melakukan perawatan di rumah serta mencegah kesalahan dalam tindakan perawatan.

d. Mencegah komplikasi

Selain itu, perawat juga berperan dalam mencegah komplikasi yang dapat terjadi pada kulit lansia. Upaya ini dilakukan dengan memantau kondisi kulit secara berkala, melakukan tindakan pencegahan seperti perubahan posisi, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Dengan peran tersebut, perawat dapat membantu mencegah terjadinya ulkus tekan, infeksi, maupun luka kronis, sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga.

C. Perawatan Luka

1. Pengertian Perawatan Luka

Perawatan luka adalah tindakan keperawatan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan luka, mencegah infeksi, serta mempertahankan kondisi optimal agar proses penyembuhan luka dapat berlangsung dengan baik (Potter & Perry, 2020).

Perawatan luka merupakan serangkaian tindakan sistematis yang meliputi pembersihan, debridement, pemberian balutan, dan manajemen luka untuk mempercepat penyembuhan serta mencegah komplikasi (Baranoski & Ayello, 2021).

2. Tujuan perawatan luka

Tujuan perawatan luka adalah untuk menciptakan lingkungan luka yang optimal melalui pembersihan luka, pengangkatan jaringan nekrotik, pengendalian infeksi, serta penggunaan balutan yang tepat guna mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi (Baranoski & Ayello, 2021).

Tujuan perawatan luka adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan dengan menjaga kelembaban luka, meningkatkan perfusi jaringan, mengurangi

risiko infeksi, serta meminimalkan kerusakan jaringan lebih lanjut (Gould et al., 2023).

3. Proses penyembuhan luka

Proses penyembuhan luka merupakan suatu mekanisme biologis yang kompleks dan terorganisir yang bertujuan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan mengembalikan fungsi kulit. Proses ini melibatkan berbagai interaksi seluler, biokimia, dan molekuler yang terjadi secara bertahap. Secara umum, penyembuhan luka terdiri dari beberapa fase utama yaitu fase inflamasi, proliferasi, dan maturasi/remodeling. Setiap fase memiliki peran penting dalam memastikan penyembuhan luka berlangsung secara optimal (Potter & Perry, 2020; Gould et al., 2023).

Fase inflamasi merupakan tahap awal yang terjadi segera setelah terjadinya luka, biasanya berlangsung selama beberapa hari. Pada fase ini terjadi vasokonstriksi diikuti vasodilatasi, serta migrasi sel-sel inflamasi seperti neutrofil dan makrofag ke area luka. Tujuan fase ini adalah untuk menghentikan perdarahan (hemostasis), membersihkan jaringan mati, serta mencegah infeksi. Proses ini ditandai dengan adanya tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, panas, bengkak, dan nyeri (Potter & Perry, 2020).

Selanjutnya adalah fase proliferasi yang ditandai dengan pembentukan jaringan baru. Pada fase ini terjadi proses angiogenesis (pembentukan pembuluh darah baru), pembentukan jaringan granulasi, serta epitelisasi yang menutup permukaan luka. Setelah itu masuk ke fase maturasi atau remodeling, yaitu tahap akhir dimana jaringan mengalami pematangan dan reorganisasi kolagen sehingga kekuatan jaringan meningkat. Proses ini dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama tergantung kondisi luka dan faktor individu. Keberhasilan penyembuhan luka sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nutrisi, perfusi jaringan, infeksi, dan kondisi kesehatan pasien (Gould et al., 2023).

4. Prinsip perawatan luka

Prinsip perawatan luka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang optimal agar proses penyembuhan berlangsung efektif. Salah satu prinsip utama adalah menjaga kebersihan luka dengan teknik aseptik guna mencegah kontaminasi mikroorganisme. Pembersihan luka dilakukan menggunakan larutan yang tidak merusak jaringan, seperti larutan salin, serta dilakukan secara hati-hati untuk mempertahankan jaringan sehat. Selain itu, menjaga kelembaban luka juga penting karena lingkungan lembab dapat mempercepat proses epitelisasi dan pembentukan jaringan baru (European Pressure Ulcer Advisory Panel et al., 2019).

Prinsip berikutnya adalah pengelolaan jaringan luka melalui pengangkatan jaringan nekrotik (debridement) serta penggunaan balutan yang sesuai.

Debridement membantu menghilangkan jaringan mati yang dapat menghambat penyembuhan dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Pemilihan balutan luka harus disesuaikan dengan kondisi luka, seperti jumlah eksudat dan kedalaman luka, agar dapat melindungi luka, menjaga kelembaban, serta mempercepat penyembuhan. Pendekatan modern juga menekankan pentingnya manajemen luka berbasis kondisi jaringan dan lingkungan luka (Wounds International, 2023).

Selain itu, prinsip perawatan luka juga mencakup pengendalian infeksi dan optimalisasi kondisi pasien secara menyeluruh. Pemantauan tanda-tanda infeksi harus dilakukan secara rutin, dan jika diperlukan, diberikan terapi antimikroba sesuai indikasi. Faktor sistemik seperti nutrisi, perfusi jaringan, hidrasi, serta penyakit penyerta seperti diabetes juga sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Pendekatan holistik ini penting untuk memastikan proses penyembuhan berjalan optimal dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut (Registered Nurses' Association of Ontario, 2024).

5. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka

a. Faktor Lokal (kondisi luka)

Faktor lokal merupakan faktor yang langsung berasal dari kondisi luka itu sendiri. Beberapa hal yang memengaruhi antara lain oksigenasi jaringan, infeksi, kelembapan, dan tekanan pada luka. Luka yang mengalami kekurangan oksigen (hipoksia), adanya bakteri atau biofilm, serta tekanan terus-menerus dapat menghambat proses regenerasi jaringan. Selain itu, kondisi luka yang terlalu kering atau terlalu lembap juga dapat mengganggu proses penyembuhan (Wallace et al., 2023).

b. Faktor Sistemik (kondisi tubuh pasien)

Faktor sistemik berkaitan dengan kondisi umum tubuh yang memengaruhi kemampuan penyembuhan luka. Faktor-faktor tersebut meliputi usia, penyakit kronis (seperti diabetes), status nutrisi, dan kondisi imun tubuh. Pada lansia atau pasien dengan penyakit kronis, proses penyembuhan cenderung lebih lambat karena penurunan fungsi sel dan sirkulasi darah. Nutrisi yang buruk juga dapat menghambat pembentukan kolagen dan jaringan baru (Kim, et al., 2025).

c. Faktor Gaya Hidup dan Psikologis

Selain faktor fisik, gaya hidup dan kondisi psikologis juga berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Kebiasaan seperti merokok dan konsumsi alkohol dapat mengganggu aliran darah dan fungsi sel, sehingga memperlambat penyembuhan. Selain itu, faktor psikologis seperti stres,

kecemasan, dan depresi juga dapat memperburuk kondisi luka karena memengaruhi respon imun tubuh dan proses inflamasi (Doyle, et al., 2025).

6. Peran perawat dalam perawatan luka

a. Pengkajian Luka

Perawat melakukan pengkajian kondisi luka meliputi ukuran, kedalaman, jenis jaringan, eksudat, dan tanda infeksi. Pengkajian juga mencakup kondisi umum pasien seperti nutrisi dan penyakit penyerta (Potter et al., 2021).

b. Perencanaan Asuhan Keperawatan

Perawat menyusun rencana perawatan luka berdasarkan hasil pengkajian, termasuk pemilihan balutan, frekuensi perawatan, dan strategi pencegahan infeksi (Brunner & Suddarth's, 2018).

c. Tindakan Perawatan Luka

Perawat melakukan tindakan langsung seperti membersihkan luka, mengganti balutan secara aseptik, menjaga kelembapan luka, dan melakukan *debridement* sesuai kompetensi (Baranoksi & Ayelow, 2016).

d. Edukasi Pasien dan Keluarga

Perawat memberikan edukasi tentang cara merawat luka di rumah, tanda infeksi, serta pentingnya nutrisi untuk penyembuhan luka (CDC, 2020).

e. Kolaborasi dengan Tim Kesehatan

Perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter dan ahli gizi dalam menangani luka, terutama luka kronis (Brunner & Suddarth's, 2018).

f. Evaluasi dan Dokumentasi

Perawat mengevaluasi perkembangan luka dan mendokumentasikan hasil perawatan secara sistematis untuk memastikan kesinambungan asuhan (National Institutes of Health, 2021).

D. Aktivitas 1 — *Knows How*

1. Seorang pria berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka pada kaki kiri yang tidak kunjung sembuh sejak 10 hari yang lalu. Luka tersebut terjadi akibat terkena benda tajam saat bekerja. Pasien mengatakan luka awalnya kecil, namun semakin membesar, terasa nyeri, dan mengeluarkan cairan berwarna kekuningan. Pasien juga mengeluhkan demam ringan sejak tiga hari terakhir. Pasien memiliki riwayat Diabetes Mellitus selama 5 tahun dan mengaku jarang mengontrol kadar gula darah.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- a. Luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran ± 5 cm
- b. Tepi luka tampak kemerahan dan edema
- c. Terdapat eksudat purulen (nanah)

- d. Nyeri tekan pada area luka
- e. Suhu tubuh 38,3°C
- f. Kadar gula darah sewaktu: 250 mg/dL
- g. Pasien tampak lemas

Pertanyaan Diskusi:

- a. Identifikasi tanda dan gejala infeksi pada luka berdasarkan kasus di atas.
- b. Jelaskan kemungkinan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien.
- c. Identifikasi faktor risiko yang menyebabkan luka sulit sembuh pada pasien tersebut.
- d. Jelaskan prinsip perawatan luka pada pasien dengan kondisi tersebut.
- e. Jelaskan tindakan keperawatan yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus ini.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

- a. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
- b. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
- c. Presentasikan hasil diskusi secara sistematis dan media yang menarik.

E. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/*skill lab*

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- 1. Tidak loncat ke ujian
- 2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
<i>Knows / Knows How</i>	<i>Self-check</i> + analisis <i>mini-case</i>
<i>Shows How</i>	OSCE Asuhan Keperawatan Gerontik

Catatan untuk penulis:

Karena CP Bab = mendemonstrasikan

OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + *Critical Items*

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. *Hand hygiene* & pencegahan infeksi
2. Identifikasi Pasien & privasi
3. Penilaian Klasifikasi ulkus tekan
4. Eskalasi bila *red flags* muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor <i>station</i>	 (Dikosongkan)
2	Judul <i>station</i>	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Integritas Jaringan (Luka Terinfeksi)
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan <i>station</i>	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi pada pasien dengan luka terinfeksi
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku Profesional
6	Kategori	1. Infeksi 2. Nyeri dan kenyamanan 3. Integritas jaringan 4. Sistem Imun 5. Psikososial

7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pria berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka pada kaki kanan yang tidak kunjung sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Luka awalnya akibat tertusuk paku saat bekerja. Pasien mengeluhkan luka semakin membesar, terasa nyeri, dan mengeluarkan cairan berwarna kekuningan serta berbau. Pasien juga mengeluh demam sejak 3 hari terakhir dan merasa lemas. Pasien memiliki riwayat Diabetes Mellitus sejak 8 tahun yang lalu dan tidak rutin kontrol. Hasil pengkajian awal: Luka terbuka pada kaki kanan ± 6 cm, tepi luka kemerahan dan edema, eksudat purulen (+), bau (+), nyeri tekan (+), skala nyeri 5/10, suhu $38,5^{\circ}\text{C}$, gula darah sewaktu: 280 mg/dL dan pasien tampak lemah. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario diatas dan hasil validasi pengkajian fokus berdasarkan SDKI. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario diatas berdasarkan SLKI dan SIKI 4. Lakukan edukasi kepada pasien mengenai perawatan luka.
8	Instruksi untuk penguji	Seorang pria berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka pada kaki kanan yang tidak kunjung sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Luka awalnya akibat tertusuk paku saat bekerja. Pasien mengeluhkan luka semakin membesar, terasa nyeri, dan mengeluarkan cairan berwarna kekuningan serta berbau. Pasien juga mengeluh demam sejak 3 hari terakhir dan merasa lemas. Pasien memiliki riwayat Diabetes Mellitus sejak 8 tahun yang lalu dan tidak rutin kontrol. Hasil pengkajian awal: Luka terbuka pada kaki kanan ± 6 cm, tepi luka kemerahan dan edema, eksudat purulen (+), bau (+), nyeri tekan (+), skala nyeri 5/10, suhu $38,5^{\circ}\text{C}$, gula darah sewaktu: 280 mg/dL dan pasien tampak lemah. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario diatas dan hasil validasi pengkajian fokus berdasarkan SDKI. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario diatas berdasarkan SLKI dan SIKI 4. Lakukan edukasi kepada pasien mengenai perawatan luka. INSTRUKSI PENGUJI:

		1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus: lokasi, ukuran, kondisi luka, tanda infeksi (kemerahan, pus, bau, demam), nyeri, dan riwayat penyakit (DM). 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan: gangguan integritas jaringan berhubungan dengan agen injuri fisik. 3. Menilai diagnosis tambahan: nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi dan risiko infeksi/ infeksi. 4. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan: perawatan luka, manajemen nyeri dan pencegahan infeksi, kolaborasi pemberian obat, edukasi istirahat dan nutrisi. 5. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan luaran keperawatan: penyembuhan luka meningkat, nyeri menurun, status infeksi membaik. 6. Menilai ketepatan edukasi: menjelaskan perawatan luka di rumah, kontrol gula darah dan tanda bahaya (demam tinggi, luka memburuk). 7. Monitor perilaku profesional peserta. 8. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1. Identitas pasien: pria usia 50 tahun 2. Keluhan utama: luka kaki tidak sembuh 3. Riwayat sekarang: luka sejak 2 minggu, nyeri, bernanah, bau 4. Riwayat penyakit: Diabetes Mellitus 5. Nafsu makan: menurun 6. Nyeri: terasa saat disentuh 7. Ekspresi: tampak lemah dan sedikit cemas 8. Harapan: luka cepat sembuh
10	<i>Setting station</i>	Ruang pemeriksaan/ ruang rawat anak • Tempat tidur pasien • Manekin dewasa • Laboran • Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin dewasa 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Pintu masuk 5. Troli alat 6. Wastafel/<i>handrub</i> 7. Tempat sampah

11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan stereil dan non steril 2. Satu set bak steril yang berisi: pinset anatomi 2, pinset chirurgis 1, gunting jaringan 1, kom 2, klem. 3. Bak instrumen bersih berisi: pinset anatomi 2. 4. Kassa steril dan balutan yang sesuai stadium luka (hidrokoloid, hidrogel, foam, silver dressing, alginate) 5. Salep antimikroba, collagenase, dsb. 6. NaCl 0,9% cairan pembersih luka yang sesuai (PHMB, Dakin's solution) 7. Plester, pengikat, perban sesuai kebutuhan. 8. Kantong sampah kedap air 9. Perlak dan alasnya 10. Kapas alkohol 11. Masker 12. Pelindung mata 13. Bengkok 14. Gunting perban 15. <i>Cotton bud</i> 16. Penggaris 17. Apron/celemek 18. Lembar jawaban peserta. Peran laboran: Menyiapkan dan merapikan alat sebelum dan sesudah ujian.
12	Penulis	Ns. Destria Efliani, MM., M.Kep
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PERAWATAN LUKA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan steril dan non steril b. Satu set bak steril yang berisi: pinset anatomi 2, pinset chirurgis 1, gunting jaringan 1, kom 2, klem. c. Bak instrumen bersih berisi: pinset anatomi 2. d. Kassa steril dan balutan yang sesuai stadium luka (hidrokoloid, hidrogel, foam, silver dressing, alginate) e. Salep antimikroba, collagenase, dsb f. NaCl 0,9% cairan pembersih luka yang sesuai (PHMB, Dakin's solution) g. Plester, pengikat, perban sesuai kebutuhan. h. Kantong sampah kedap air i. Perlak dan alasnya j. Kapas alkohol k. Masker l. Pelindung mata m. Bengkok n. Gunting perban o. Cotton bud p. Penggaris q. Apron/celemek				
3	Mencuci tangan				

B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama dan umur) secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja				
11	Membaca do'a kesembuhan pasien (Allahumma rabban nasi, adzhibil ba'sa, isyfi, antas syafi, la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqama)				
12	Mencuci tangan dengan menggunakan <i>handscrub</i>				
13	Memakai sarung tangan non steril				
14	Mendekatkan peralatan yang diperlukan di tempat yang mudah dijangkau perawat				
15	Mengatur posisi pasien yang nyaman bagi pasien dan tutupi bagian tubuh yang tidak luka dengan selimut				

16	Mengidentifikasi adanya alergi dan instruksikan pasien untuk tidak menyentuh area luka atau perawatan steril				
17	Meletakkan kantong sampah atau bengkok pada area yang mudah dijangkau. Lipat bagian atas membentuk mangkok				
18	Mengenakan masker muka dan pelindung mata serta apron/ celemek				
19	Membuka bak instrumen bersih lalu angkat balutan kasa secara hati-hati dengan menggunakan pinset anatomi, jaga jangan sampai menarik atau melepaskan <i>drain</i> atau selang. Jika kondisi balutan seperti dibawah ini: Balutan basah–kering (<i>Wet-to-Dry Dressing</i>) "Jangan dibasahi saat melepas – angkat secara perlahan" Cara Kerja: - Balutan di pasang dalam keadaan lembap/ basah (biasanya kasa yang dibasahi NaCl 0,9%), lalu dibiarkan mengering dan menempel pada jaringan mari di dasar luka. - Ketika balutan diangkat dalam keadaan kering dan sudah menempel, jaringan mati ikut				

	terangkat bersama balutan tersebut. Balutan kering (<i>Dry Dressing</i>) "Basahi balutan dengan larutan NaCl 0,9% sebelum melepas balutan" Cara Kerja: • Balutan kering sering kali menempel/ melekat erat pada permukaan luka karena eksudat yang mengering dan mengikat kasa ke jaringan • Sebelum dilepas, balutan ditetesi atau disiram NaCl 0,9%, secukupnya hingga balutan menjadi lunak dan longgar dari dasar luka • Setelah cukup basah dan tidak menempel, barulah balutan diangkat dengan hati-hati.				
20	Mengobservasi karakteristik luka dan jumlah drainase pada balutan dan penampakan luka (kedalaman luka, panjang luka dan lebar luka) Debridemen (jika diperlukan) • Mengidentifikasi jenis jaringan mati yang memerlukan debridemen (slough/ eschar) • Melakukan debridemen mekanik/ autolitik/ enzimatik				

	sesuai indikasi dan kompetensi • Tidak melakukan debridemen pada eschar kering/ stabil di tumit tanpa tanda infeksi • Mengkaji ulang nyeri pasien selama dan setelah debridemen Pengelolaan Eksudat dan Pemilihan Balutan • Memilih jenis balutan berdasarkan stadium luka, jumlah eksudat, dan kondisi dasar luka • Stadium I: menggunakan film transparan atau hidrokoloid tipis sebagai pelindung • Stadium II: menggunakan hidrokoloid, foam, atau hidrogel sesuai kondisi eksudat • Stadium III-IV dengan eksudat banyak: menggunakan alginate, foam, atau balutan absorptif lainnya • Luka terinfeksi: menggunakan silver dressing, PHMB, atau balutan antimikroba sesuai indikasi • Luka dengan slough/ eschar: menggunakan hidrogel atau balutan aulitik • Mengaplikasikan produk topikal yang diresepkan (jika ada) sebelum pemasangan balutan				
--	--	--	--	--	--

21	Membuang balutan yang kotor ke dalam kantong sampah				
22	Melepaskan sarung tangan non steril lalu buang ke dalam kantong sampah kemudian mencuci tangan				
23	Membuka set balutan steril dan letakkan pada meja disamping tempat tidur				
24	Memasang balutan kering a. Buka botol larutan NaCl 0,9% dan tuangkan kedalam baskom steril b. Gunakan sarung tangan steril c. Bersihkan luka dengan larutan NaCl 0,9% • Gunakan <i>swab</i> yang terpisah untuk sekali usapan • Bersihkan dari area yang kurang terkontaminasi ke area yang paling terkontaminasi • Keringkan menggunakan kasa kering • Oleskan salep antiseptik jika diperlukan • Pasang balutan kering dan steril pada daerah insisi atau luka d. Pasang kasa lapisan pertama sebagai lapisan kontak e. Jika terdapat <i>drain</i>, potong sedikit kasa berukuran 4x4 untuk menutup sekeliling <i>drain</i> f. Pasang kasa lapisan kedua atau sesuai kebutuhan				

25	Memasang balutan basah-kering a. Tuang larutan NaCl 0,9% kedalam kom steril b. Kenakan sarung tangan steril c. Bersihkan luka dengan NaCl 0,9% dan kasa. Bersihkan dari area yang sedikit terkontaminasi ke area yang paling terkontaminasi sampai bersih d. Gunakan <i>primary dressing</i> dan <i>secondary dressing</i> /pasangkan kasa steril ke permukaan luka secukupnya.				
26	Tutupi balutan dengan bantalan kasa, pasang plester diatas atau di tepi kasa				
27	Lepaskan sarung tangan dan buang ke bengkok				
28	Bantu pasien untuk berada pada posisi yang nyaman				
29	Rapikan pasien dan bereskan alat				
30	Mencuci tangan				
D	Tahap Terminasi				
31	Menyimpulkan kegiatan				
32	Mengevaluasi respon pasien secara subjektif dan objektif				
33	Memberikan <i>reinforcement</i> positif				
34	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
35	Mengakhiri tindakan dengan baik				

E	Tahap Dokumentasi				
36	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian tindakan edukasi dan demonstrasi, respon pasien/keluarga, dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
37	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN PERAWATAN
LUKA

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali keluhan utama lokasi, ukuran, kondisi luka, tanda infeksi (kemerahan, pus, bau, demam), nyeri, dan riwayat penyakit (DM).					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis (gangguan integritas jaringan berhubungan dengan agen injuri fisik, nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi dan risiko infeksi/infeksi dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi perawatan luka	Menjelaskan perawatan luka di rumah, kontrol gula darah dan tanda bahaya (demam tinggi, luka memburuk).					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, dan responsif selama tindakan					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0= tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN PERAWATAN LUKA

II. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan luka, meliputi lokasi, ukuran, kondisi luka, tanda infeksi (kemerahan, pus, bau, demam), nyeri, dan riwayat penyakit (DM). Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada pasien luka serta menyusun rencana keperawatan yang relevan berdasarkan data hasil pengkajian. Diagnosis dan rencana keperawatan harus jelas, sistematis, dan sesuai kondisi pasien.					2	
3. Implementasi Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan keperawatan yang telah direncanakan, seperti perawatan luka di rumah, kontrol gula darah dan tanda bahaya (demam tinggi, luka memburuk). Tindakan dilakukan secara aman, tepat, dan sistematis.					5	
4. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan sikap profesional sesuai prinsip etik dan legal, seperti memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik, menjaga privasi, serta memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien selama tindakan.					2	

III. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus luka.	Melakukan pengkajian namun hanya sebagian kecil aspek yang dikaji; data yang terkumpul tidak lengkap dan banyak data penting yang terlewat (mis. karakteristik luka, status nutrisi, atau faktor risiko).	Melakukan pengkajian sebagian besar aspek dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa data yang kurang lengkap atau interpretasi data belum akurat (mis. penentuan stadium luka kurang tepat atau pengkajian nyeri tidak terstruktur).	Melakukan pengkajian secara sistematis, menyeluruh, dan akurat; mencakup seluruh aspek yang relevan: lokasi, stadium, dimensi, dasar luka, eksudat, kulit sekitar, nyeri, status nutrisi, dan faktor risiko, serta mendokumentasikannya dengan lengkap.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak mampu menyusun rencana perawatan.	Mampu menegakkan satu diagnosis keperawatan namun kurang tepat atau tidak didukung data yang cukup. Rencana perawatan yang disusun sangat terbatas, tidak spesifik, dan belum mencerminkan prioritas masalah pasien.	Mampu menegakkan diagnosis keperawatan yang sesuai data, namun belum lengkap (mis. hanya menyebutkan masalah utama tanpa masalah kolaboratif). Rencana perawatan cukup lengkap namun tujuan/kriteria hasil belum terukur dengan jelas atau intervensi	Mampu menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat, lengkap, dan berdasarkan data (menggunakan format PES/SDKI). Rencana perawatan disusun secara sistematis dengan tujuan yang SMART, kriteria hasil terukur, dan intervensi yang komprehensif sesuai kondisi pasien.

			kurang spesifik.	
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan tindakan keperawatan namun dengan banyak kesalahan prosedur yang signifikan; teknik aseptik tidak terjaga, langkah-langkah tidak berurutan, dan memerlukan banyak bimbingan dari penilai untuk menyelesaikan tindakan.	Melakukan tindakan keperawatan sesuai prosedur dengan beberapa kekurangan minor (mis. satu atau dua langkah terlewat, teknik aseptik umumnya terjaga, namun respons pasien belum diperhatikan secara optimal). Tindakan dapat diselesaikan dengan sedikit bimbingan.	Melakukan seluruh tindakan keperawatan secara mandiri, sistematis, sesuai SOP, dengan menjaga teknik aseptik, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien sepanjang prosedur, serta memberikan respons yang tepat terhadap kondisi pasien selama tindakan berlangsung.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun	Menunjukkan perilaku profesional yang sangat terbatas; sesekali memperhatikan aspek etik atau keselamatan	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik; umumnya memperhatikan aspek etik dan keselamatan	Secara konsisten menunjukkan perilaku profesional yang tinggi; menjunjung etika keperawatan, memprioritaskan keselamatan pasien, menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif, menjaga

	keselamatan pasien.	namun belum konsisten. Komunikasi dengan pasien minim dan kurang empatik. Penampilan dan higiene diri kurang terjaga.	pasien, berkomunikasi dengan sopan, namun belum sepenuhnya konsisten (mis. lupa mencuci tangan di salah satu tahap, atau penjelasan ke pasien kurang lengkap).	privasi dan martabat pasien, serta menampilkan higiene dan penampilan yang sesuai standar profesi.
--	---------------------	---	--	--

IV. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

V. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	<i>BORDERLINE</i>	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir =x 100 =
30

(Kota),

.....

Penguji :

F. DOPS (*Does*)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung Klasifikasi ulkus tekan
2. *Checklist* + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi remedial

Catatan untuk penulis:

1. Dari simulasi → praktik nyata
2. Bukti performa sesungguhnya

Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Keperawatan pada Pasien Luka

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus luka
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.	Pembimbing melakukan observasi langsung saat mahasiswa merawat luka kaki pria 50 tahun dengan luka infeksi akibat tusukan paku yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu. Seluruh proses perawatan luka mulai dari persiapan alat, pembersihan luka, hingga pemasangan balutan diamati secara langsung oleh pembimbing di ruang perawatan Puskesmas
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, dan sesuai prosedur, serta mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.	Menilai apakah mahasiswa mampu: (1) mengkaji luka secara sistematis (ukuran ± 6 cm, eksudat purulen, bau, edema, nyeri skala 5/10); (2) melakukan perawatan luka dengan teknik aseptik yang benar; (3) mempertimbangkan kondisi diabetes pasien (GDS 280 mg/dL, suhu 38,5°C) dalam pengambilan keputusan klinis; dan (4) menunjukkan komunikasi terapeutik yang tepat kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Kasus: Pria 50 tahun dengan luka kaki kanan akibat tusukan paku, tidak sembuh 2 minggu. Luka terbuka ± 6 cm, tepi kemerahan dan edema, eksudat purulen (+), bau (+), nyeri tekan (+) skala 5/10. Suhu 38,5°C, GDS 280 mg/dL. Riwayat Diabetes Mellitus 8 tahun, tidak rutin kontrol.

Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan secara langsung sesuai prosedur, mulai dari persiapan hingga evaluasi.	Mahasiswa diamati dalam: (1) menyiapkan alat perawatan luka steril dan APD yang sesuai; (2) melakukan pengkajian luka (inspeksi: ukuran, warna, bau, eksudat; palpasi: nyeri tekan, suhu sekitar luka); (3) membersihkan luka dengan NaCl 0,9% menggunakan teknik aseptik; (4) melakukan debridemen slough bila diperlukan; (5) memilih dan memasang balutan yang sesuai kondisi luka infeksi dengan eksudat banyak; (6) mengevaluasi respons nyeri pasien pasca tindakan; dan (7) mendokumentasikan hasil tindakan.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan teknis/prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme.	Aspek yang akan dinilai oleh pembimbing sebagai berikut: • Teknis/Prosedural: ketepatan teknik pembersihan luka, pemilihan balutan yang sesuai (mis. silver dressing/foam absorptif untuk luka infeksi dengan eksudat banyak), dan urutan langkah yang benar. • Komunikasi terapeutik: menjelaskan prosedur sebelum tindakan, meminta persetujuan pasien, dan memberikan edukasi pengelolaan DM serta perawatan luka di rumah. • Penalaran klinik: mengaitkan kondisi hiperglikemia (GDS 280 mg/dL) dan demam (38,5°C) dengan risiko infeksi lanjut dan gangguan penyembuhan luka. • Keselamatan pasien: menjaga teknik aseptik, mencuci tangan 6 langkah WHO, dan mengkaji skala nyeri (5/10) untuk manajemen nyeri yang tepat. • Profesionalisme: penampilan, ketepatan waktu, dan sikap etis selama tindakan.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan tindakan kepada pasien.	Pembimbing memfokuskan observasi pada: (1) apakah mahasiswa mengenali tanda infeksi luka (eritema, edema, eksudat purulen, bau, demam) dan mengomunikasikannya dengan tepat; (2) apakah teknik irigasi luka dengan NaCl 0,9% dilakukan dengan tekanan yang sesuai; (3) apakah mahasiswa mampu memilih balutan antimikroba yang sesuai untuk luka terinfeksi; (4) apakah

		mahasiswa menjelaskan hubungan kontrol gula darah dengan proses penyembuhan luka kepada pasien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan.	Umpan balik pembimbing setelah tindakan bahwa mahasiswa sudah melakukan irigasi luka dengan baik. Namun untuk kasus luka infeksi dengan eksudat banyak seperti ini, sebaiknya pertimbangkan penggunaan silver dressing dibandingkan kasa biasa agar lebih efektif mengendalikan bioburden. Selain itu, edukasi kepada pasien mengenai pentingnya kontrol gula darah perlu lebih ditekankan karena hiperglikemia (GDS 280 mg/dL) merupakan faktor utama penghambat penyembuhan luka pada pasien ini.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam melakukan prosedur klinik.	Berdasarkan observasi, pembimbing menentukan tingkat kompetensi mahasiswa: • Skor 3 (Kompeten): Mahasiswa mampu melakukan seluruh tahap perawatan luka kaki DM dengan infeksi secara mandiri, sistematis, dan aman — termasuk pengkajian luka lengkap, teknik aseptik, pemilihan balutan tepat, serta edukasi pengelolaan DM. • Skor 2 (Mendekati Standar): Prosedur dilakukan dengan benar namun edukasi tentang hubungan DM dan penyembuhan luka masih kurang atau pemilihan balutan perlu dipandu. • Skor 1 (Di Bawah Standar): Teknik aseptik belum konsisten atau langkah pembersihan luka tidak sistematis sehingga memerlukan banyak bimbingan. • Skor 0 (Tidak Kompeten): Tidak dapat melakukan perawatan luka atau tindakan yang dilakukan berisiko memperburuk kondisi infeksi.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian keterampilan klinik	Pada kasus luka ini mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran (CPL) yang ditetapkan, antara lain:

		• Mampu melakukan pengkajian luka secara komprehensif (CPL Kognitif & Psikomotor) • Mampu merencanakan dan mengimplementasikan perawatan luka berbasis bukti, termasuk pada pasien dengan komorbid DM (CPL Psikomotor) • Mampu menunjukkan komunikasi terapeutik dan perilaku profesional dalam konteks klinis nyata (CPL Afektif)
--	--	--

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi *patient safety*
4. *Feedback* CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3.1

Portofolio pada Asuhan Keperawatan pada Pasien Luka

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus luka
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Laporan pengkajian awal luka (ukuran ± 6 cm, eksudat purulen, nyeri 5/10, suhu $38,5^{\circ}\text{C}$, GDS 280 mg/dL), dokumentasi perawatan luka dari kunjungan pertama hingga perbaikan kondisi, serta perkembangan kemampuan mahasiswa dalam mengelola luka kompleks pada pasien dengan komorbid DM secara bertahap.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.	• Mahasiswa mengkaji dan merawat luka kaki infeksi pada pasien DM, mulai dari ketidakmampuan

		mengidentifikasi tanda infeksi hingga mampu melakukan pengkajian luka komprehensif secara mandiri. • Mahasiswa mampu memilih balutan yang tepat (mis. silver dressing untuk luka infeksi dengan eksudat banyak) dan mengintegrasikan pengelolaan DM dalam rencana keperawatan. • Mendokumentasikan tindak lanjut perbaikan setelah mendapat umpan balik dari pembimbing terkait teknik aseptik dan edukasi pengendalian gula darah pasien.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan praktik nyata.	• OSCE: Mahasiswa dinilai melakukan perawatan luka pada manekin di laboratorium keterampilan sebelum praktik klinik mencakup langkah persiapan alat steril, pembersihan luka, debridemen mekanik, dan pemasangan balutan sesuai standar. • DOPS: Pembimbing klinik mengobservasi langsung mahasiswa saat merawat luka kaki pria 50 tahun ini di Puskesmas dengan menilai ketepatan prosedur, teknik aseptik, kemampuan mengidentifikasi eksudat purulen, pemilihan balutan antimikroba, dan komunikasi terapeutik kepada pasien.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus, data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil.	Catatan kasus singkat mahasiswa untuk kasus ini: • Identitas: Pria, 50 tahun, DM 8 tahun tidak terkontrol • Keluhan utama: Luka kaki kanan tidak sembuh 2 minggu, semakin membesar, nyeri, eksudat purulen, bau, demam 3 hari

		• Data objektif: Luka ±6 cm, tepi eritema + edema, eksudat purulen (+), bau (+), NRS 5/10, suhu 38,5°C, GDS 280 mg/dL • Masalah keperawatan: (1) Kerusakan Integritas Kulit/Jaringan b.d. faktor mekanis dan infeksi; (2) Risiko Infeksi b.d. luka terbuka dan hiperglikemia; (3) Nyeri Akut b.d. kerusakan jaringan (NRS 5/10) • Intervensi: Perawatan luka dengan teknik aseptik, irigasi NaCl 0,9%, pemasangan silver dressing, kolaborasi antibiotik dan pengendalian gula darah, edukasi DM dan perawatan luka mandiri • Hasil: Perkembangan luka terdokumentasi per kunjungan (ukuran, eksudat, granulasi)
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali risiko yang diidentifikasi: penyebaran infeksi, osteomielitis, amputasi ekstremitas, hipoglikemia akibat perubahan pola makan serta melakukan langkah pencegahan dengan menjaga teknik aseptik ketat, memantau GDS berkala, berkolaborasi dengan dokter untuk antibiotik, dan melibatkan keluarga dalam edukasi perawatan luka di rumah.
Feedback CI/dosen	Umpan balik menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	Umpan balik pembimbing setelah observasi perawatan luka kasus ini bahwa mahasiswa sudah melakukan pengkajian luka secara sistematis dan mampu mengidentifikasi tanda-tanda infeksi dengan baik (eritema, edema, eksudat purulen, bau, demam). Teknik aseptik umumnya terjaga dengan baik,

		tetapi pemilihan balutan perlu lebih dipertimbangkan untuk luka infeksi dengan eksudat banyak seperti ini, silver dressing atau alginate dengan silver lebih tepat dibandingkan kasa biasa. Edukasi kepada pasien tentang hubungan kontrol gula darah (GDS 280 mg/dL) dengan penyembuhan luka juga perlu lebih ditekankan dan dipastikan pasien memahami dengan baik.
Karakteristik penilaian	Penilaian berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa.	Penilaian pada kasus ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses perawatan luka pasien, bukan hanya satu kali penilaian: • Kunjungan 1: Mahasiswa dinilai kemampuan pengkajian luka awal dan identifikasi masalah keperawatan prioritas • Kunjungan 2–3: Dinilai konsistensi teknik aseptik, ketepatan penggantian balutan, dan respons terhadap perkembangan luka • Kunjungan akhir: Dinilai kemampuan evaluasi penyembuhan luka (perubahan ukuran, eksudat, granulasi) dan efektivitas edukasi kepada pasien dan keluarga. Penilaian menekankan apakah mahasiswa secara konsisten menerapkan prinsip perawatan luka berbasis bukti pada setiap kunjungan, bukan hanya saat dinilai.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas performa.	Bukti konsistensi kompetensi mahasiswa yang dilampirkan dalam kasus luka ini: • Lembar observasi DOPS dari 3 kali kunjungan menunjukkan peningkatan skor dari 1 → 2 →

		3 (berkembang dari banyak bimbingan hingga mandiri) • Dokumentasi foto luka dari setiap kunjungan yang menunjukkan perkembangan penyembuhan (pengurangan eksudat, terbentuknya jaringan granulasi) • Catatan kasus yang konsisten menggunakan format SOAP dan terminologi SDKI/SLKI/SIKI • Bukti edukasi: formulir edukasi yang ditandatangani pasien dan keluarga tentang perawatan luka DM di rumah • Refleksi tertulis yang menunjukkan perkembangan penalaran klinik mahasiswa dari kunjungan ke kunjungan
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level <i>does</i> .	Dalam kasus luka ini mahasiswa telah benar-benar melakukan bukan sekadar mengetahui atau mendemonstrasikan di laboratorium tetapi asuhan keperawatan luka secara nyata: • CPL Kognitif: Terbukti melalui catatan kasus yang menganalisis hubungan DM, hiperglikemia (GDS 280 mg/dL), dan hambatan penyembuhan luka secara klinis • CPL Psikomotor: Terbukti melalui hasil DOPS yang menunjukkan kemampuan melakukan perawatan luka terinfeksi secara mandiri dan sesuai SOP di Puskesmas • CPL Afektif: Terbukti melalui refleksi patient safety, responsivitas terhadap umpan balik Pembimbing.

Tabel 3.2
Case Report pada Asuhan Keperawatan pada Pasien Luka

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus luka
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani selama praktik klinik.	Mahasiswa membuat laporan sistematis tentang pria 50 tahun dengan luka kaki kanan ± 6 cm akibat tusukan paku, tidak sembuh 2 minggu, disertai eksudat purulen, demam $38,5^{\circ}\text{C}$, dan riwayat DM tidak terkontrol (GDS 280 mg/dL).
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan data pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengintegrasikan data pengkajian luka (nyeri NRS 5/10, eksudat purulen, edema), diagnosis keperawatan (Kerusakan Integritas Kulit, Risiko Infeksi, Nyeri Akut), intervensi perawatan luka aseptik + edukasi DM, implementasi, dan evaluasi perkembangan luka.
Isi laporan	Meliputi identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.	Mahasiswa membuat pelaporan dengan rincian sebagai berikut: • Identitas: Pria, 50 th, DM 8 th tidak terkontrol • KU: Luka kaki kanan tidak sembuh 2 minggu, nyeri, berbau, demam • DS: nyeri (+), lemas, demam 3 hari • DO: Luka ± 6 cm, eksudat purulen, bau (+), NRS 5/10, suhu $38,5^{\circ}\text{C}$, GDS 280 mg/dL • Diagnosis: Kerusakan Integritas Kulit b.d. faktor mekanis & infeksi • Intervensi: Perawatan luka aseptik, silver dressing, kolaborasi antibiotik, edukasi DM • Evaluasi: Perkembangan luka per kunjungan (eksudat, granulasi, ukuran)
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.	Pembimbing melakukan fokus penilaian berdasarkan: • Ketepatan kaji: identifikasi tanda infeksi (purulen, eritema, edema, bau, demam) • Analisis: kaitkan DM + hiperglikemia sebagai faktor penghambat penyembuhan • Penalaran klinik: pilih silver dressing untuk luka infeksi eksudat banyak • Intervensi: tepat, berbasis bukti, termasuk edukasi kontrol gula darah • Evaluasi: dokumentasi perkembangan luka secara objektif per kunjungan
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.	Mahasiswa mengembangkan penalaran klinis: mengapa luka DM sulit sembuh (hiperglikemia $\rightarrow$ hambat fagositosis $\rightarrow$ infeksi persisten).

		Dokumentasi ilmiah dilatih melalui pencatatan SOAP yang terstruktur dan sistematis pada setiap kunjungan.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori dalam kasus nyata.	Mahasiswa mampu menerapkan teori patofisiologi luka DM, prinsip moist wound healing, dan asuhan keperawatan berbasis SDKI/SLKI/SIKI secara nyata di lapangan, bukan hanya dalam ujian tertulis.

Tabel 3.3

Refleksi *Patient Safety* pada Asuhan Keperawatan pada Pasien Luka

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus luka
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan yang menunjukkan kemampuan mengenali risiko dan merencanakan pencegahan.	Mahasiswa menyadari bahwa kelalaian teknik aseptik dapat memperparah infeksi yang sudah ada bahkan berisiko menyebabkan sepsis pada pasien yang sudah demam 38,5°C dan GDS 280 mg/dL.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan pasien.	Mahasiswa menjadi sadar bahwa pada pasien DM dengan luka infeksi, satu kesalahan kecil (mis. teknik irigasi tidak steril, balutan tidak sesuai) dapat mempercepat penyebaran infeksi dan meningkatkan risiko amputasi atau kematian.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Mahasiswa mengidentifikasi fokus: • Risiko: infeksi memburuk → sepsis → amputasi • Penyebab: DM tidak terkontrol (GDS 280), teknik aseptik tidak ketat, balutan tidak sesuai • Pencegahan: teknik steril ketat, silver dressing, kolaborasi antibiotik, edukasi GDS • Pembelajaran: hiperglikemia hambat imun → penyembuhan lambat → risiko komplikasi berat
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Mahasiswa memahami situasi yang berpotensi membahayakan pasien dengan memperhatikan hal: • Risiko infeksi lanjut / sepsis: suhu 38,5°C + eksudat purulen + GDS 280 mg/dL • Risiko osteomielitis: luka dalam akibat tusukan paku pada pasien DM • Risiko amputasi: sirkulasi perifer terganggu akibat komplikasi DM kronik • Risiko jatuh: pasien lemas + nyeri kaki NRS 5/10 saat berjalan

Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Mahasiswa melakukan langkah konkret dengan cara: • Menjaga teknik aseptik ketat: cuci tangan 6 langkah WHO sebelum dan sesudah tindakan • Pilih silver dressing sesuai indikasi luka infeksi dengan eksudat banyak • Kolaborasi dokter: antibiotik dan pengendalian gula darah • Edukasi pasien & keluarga: kontrol DM, tanda perburukan luka, perawatan luka mandiri di rumah
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan perubahan pemahaman dan praktik ke depan.	Mahasiswa memahami bahwa perawatan luka DM bukan sekadar mengganti balutan melainkan manajemen komprehensif yang melibatkan pengendalian faktor sistemik (GDS), pemilihan balutan berbasis bukti, dan edukasi yang efektif. Ke depan, mahasiswa akan selalu mengkaji GDS dan status nutrisi sebelum merencanakan intervensi luka.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Mahasiswa tidak hanya terampil melakukan tindakan, tetapi mampu berpikir kritis terhadap risiko keselamatan pasien dan mengambil langkah pencegahan yang tepat secara mandiri.

G. Ringkasan Materi

Bab ini menekankan bahwa ulkus tekan dan perawatan kulit lansia merupakan aspek penting dalam menjaga integritas jaringan serta kualitas hidup pasien. Ulkus tekan terjadi akibat tekanan berkepanjangan pada jaringan, terutama di area tonjolan tulang, yang menyebabkan gangguan aliran darah (iskemia), kerusakan jaringan, hingga nekrosis. Kondisi ini sering terjadi pada pasien lansia dengan keterbatasan mobilitas dan dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian ulkus tekan meliputi lokasi luka (sakrum, tumit, bokong), ukuran, kedalaman, stadium luka (I–IV), serta tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, eksudat, dan bau. Selain itu, perlu dikaji faktor risiko seperti imobilisasi, malnutrisi, kelembaban kulit, serta penyakit kronis seperti diabetes. Pengkajian harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menentukan kondisi luka dan risiko komplikasi secara akurat.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian kondisi umum dan luka secara spesifik. Perawat mengidentifikasi karakteristik luka dan faktor penyebab, kemudian menetapkan diagnosis keperawatan seperti gangguan integritas

jaringan, nyeri akut, dan risiko infeksi. Diagnosis ini menjadi dasar dalam menyusun rencana asuhan yang tepat dan terarah.

Pada tahap perencanaan, intervensi difokuskan pada pencegahan dan perawatan luka secara optimal, termasuk reposisi pasien secara berkala, menjaga kebersihan dan kelembaban kulit, serta pemenuhan nutrisi yang adekuat. Implementasi dilakukan melalui tindakan perawatan luka seperti pembersihan luka dengan teknik aseptik, penggunaan balutan yang sesuai, pengangkatan jaringan nekrotik (*debridement*), serta pengendalian infeksi. Edukasi kepada pasien dan keluarga juga sangat penting, terutama terkait perawatan luka di rumah, perubahan posisi, nutrisi, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai.

Evaluasi dilakukan dengan menilai perkembangan luka, seperti berkurangnya ukuran luka, munculnya jaringan granulasi, menurunnya nyeri, serta tidak adanya tanda infeksi lanjutan. Selain itu, kemampuan pasien dan keluarga dalam melakukan perawatan mandiri juga menjadi indikator keberhasilan asuhan keperawatan.

Dengan demikian, asuhan keperawatan pada ulkus tekan harus dilakukan secara sistematis, aman, dan berpusat pada pasien. Perawat memiliki peran penting dalam pencegahan, perawatan, edukasi, serta kolaborasi dengan tim kesehatan untuk meningkatkan proses penyembuhan dan mencegah komplikasi. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan asuhan keperawatan secara komprehensif serta menentukan tindakan yang tepat demi keselamatan pasien.

H. Tabel *Red Flags* & Eskalasi

Ulkus Tekan dan Perawatan Luka

<i>Red flags</i>	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Luka semakin dalam	akan jaringan berat	Laporkan ke dokter
Eksudat banyak dan berbau	Infeksi	Kolaborasi antibiotik
Demam tinggi	Infeksi sistemik	Eskalasi segera
Jaringan nekrosis	Luka kronis	<i>Debridement</i>
Nyeri hebat	Inflamasi berat	Evaluasi lanjutan
Luka tidak sembuh lama	kronis	Rujuk perawatan lanjut

Form *Checklist* "Saya sudah bisa..."

Bab Ulkus Tekan dan Perawatan Luka

Nama mahasiswa :

NIM :

Tanggal :

Tempat Praktik/ *Skill Lab* :

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep luka	☐	☐	
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi stadium luka	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi faktor risiko	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi manifestasi klinis luka	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi komplikasi luka	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi pencegahan luka	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan pengkajian luka	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menentukan diagnosis luka	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menyusun rencana perawatan luka	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan tindakan perawatan luka	☐	☐	
11	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan	☐	☐	
12	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada pasien/ keluarga	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Referensi

- Agrawal, K., & Chauhan, N. (2012). Pressure ulcers: Back to the basics. *Indian Journal of Plastic Surgery*, 45(2), 244–254. <https://doi.org/10.4103/0970-0358.101287>
- Alomedika. (2024). Terapi nutrisi pada ulkus dekubitus. <https://www.alomedika.com/terapi-nutrisi-pada-ulkus-dekubitus>
- Baranoski, S., & Ayello, E. A. (2016). *Wound care essentials: Practice principles* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Baranoski, S., & Ayello, E. A. (2021). *Wound care essentials: Practice principles*. Wolters Kluwer.
- Beriso, H. B., Zemene, W., & Tesfaye, E. (2024). Prevalence of pressure ulcers and associated factors among adult patients admitted at comprehensive specialized hospital, Northwest Ethiopia, 2023. *Scientific Reports*, 14, 17290. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-67026-5>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Wound management and infection prevention. <https://www.cdc.gov>
- Christiana, B., Saefulloh, M., & Sumarni. (2025). Determinasi kejadian luka tekan pada pasien ICU. *Lasalle Health Journal*.
- Cleveland Clinic. (2023). Vertebral osteomyelitis: What it is, symptoms & treatment. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22276-vertebral-osteomyelitis>
- Cleveland Clinic. (2025a). Gangrene: Symptoms, causes & treatment. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21070-gangrene>
- Cleveland Clinic. (2025b). Septic shock: Symptoms, causes & treatment. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23255-septic-shock>
- DeCastro, S. S. (2025). Update on pressure injuries: A review of recent evidence. *Advances in Skin & Wound Care*.
- Doyle, L., Hughes, R., O'Driscoll, M., Doyle, F., & Moore, Z. (2025). Relationships between anxiety, depression and wound healing outcomes in adults: A systematic review and meta-analysis. *Wound Repair and Regeneration*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12091741/>
- Eliopoulos, C. (2022). *Gerontological nursing*. Wolters Kluwer.
- European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, & Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2019). Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: Clinical practice guideline. EPUAP/NPIAP/PPPIA.
- Getty Images/iStockphoto. (n.d.). Senior woman skincare morning routine in bathroom [Fotografer]. iStock by Getty Images. <https://www.istockphoto.com/photos/elderly-woman-bathroom>

- Ginting, C. R., Dalimunthe, D. A., Siregar, I. S. S., & Ilyas, K. K. (2024). Prevalence of pressure injury in inpatients at H. Adam Malik Hospital Medan in 2020–2022. *SCRIPTA SCORE Scientific Medical Journal*, 6(1), 38–44. <https://doi.org/10.32734/scripta.v6i1.15602>
- Gould, L. J., Olney, C. M., Nichols, J. S., Robson, M. C., & Cooper, D. M. (2024). WHS guidelines for the treatment of pressure ulcers. *Wound Repair and Regeneration*, 32(6), e13210. <https://doi.org/10.1111/wrr.13210>
- Health Service Executive. (2021). Complications of pressure ulcers. <https://www.hse.ie/eng/health/az/b/bed-sores/complications-of-pressure-ulcers.html>
- Hidayannah, U. N., Susanti, I. H., & Sundari, R. I. (2025). Asuhan keperawatan gangguan integritas jaringan/kulit pada pasien dengan ulkus dekubitus. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 7(2), 31–40.
- Ignite Healthwise, LLC. (2024). Caregiving: Skin care for immobile adults. *Kaiser Permanente Health Encyclopedia*. <https://healthy.kaiserpermanente.org/health-wellness/health-encyclopedia/he.caregiving-skin-care-for-immobile-adults.abq1376>
- Jaul, E., & Calderon-Margalit, R. (2019). Systemic factors and mortality in elderly patients with pressure ulcers. *Advances in Skin & Wound Care*, 32(2), 73–77. <https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000550038.50461.29>
- Jiang, Y., Song, Y., Zeng, Q., & Jiang, B. (2024). Mesenchymal stem cells and their extracellular vesicles are a promising alternative to antibiotics for treating sepsis. *Bioengineering*, 11(11), 1147. <https://doi.org/10.3390/bioengineering11111147>
- Kaya, F. O., & Karaca, A. (2025). Risk factors associated with pressure ulcers in hospitalized patients. *Frontiers in Medicine*, 12, 1686611. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1686611>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Perawatan kesehatan lansia. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Penerapan pressure injury bundle pada pasien cedera tulang belakang. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024a). Buku SOP keterampilan keperawatan. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024b). E-modul perawatan luka tekan/dekubitus pada lanjut usia. Kemenkes RI.
- Kim, J., Park, S., & Lee, H. (2025). The association of systemic inflammation, wound bioburden, and healing outcomes in older adults. *PubMed Central*.

- Krasner, D. L., van Rijswijk, L., & Rodeheaver, G. T. (2020). Chronic wound care: The essentials. HMP Communications.
- Lim, S., & Kho, K. A. (2024). Vertebral osteomyelitis. Dalam StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532256/>
- Maryuani, A. (2013). Perawatan luka modern. In Media.
- McNichol, L., Mackey, D., Watts, C., & Zuecca, N. (2020). Choosing a support surface for pressure injury prevention and treatment. *Nursing*, 50(2), 41–44. <https://doi.org/10.1097/01.nurse.0000651620.87023.d5>
- MedicineNet, Inc. (2009). Necrotizing fasciitis picture image [Ilustrasi]. https://www.medicinenet.com/image-collection/necrotizing_fasciitis_picture/picture.htm
- Mentari, R. N. (2018). Pemberian massage effleurage dengan menggunakan virgin coconut oil (VCO) untuk pencegahan luka tekan [Skripsi]. Universitas [nama universitas].
- Nam, I. C., Kim, D. R., Lee, J. S., Kim, J., Shin, Y. H., Won, J. H., & Lee, Y. J. (2025). Computed tomography imaging characteristics in the diagnosis and assessment of cellulitis in patients with leg swelling. *Medicina*, 61(6), 982. <https://doi.org/10.3390/medicina61060982>
- National Institutes of Health. (2021). Wound healing and care research. NIH.
- National Pressure Injury Advisory Panel. (2016). Pressure injury stages. <https://npiap.com/page/PressureInjuryStages>
- National Pressure Injury Advisory Panel. (2019). Pressure injury definition and stages. NPIAP.
- National Pressure Injury Advisory Panel. (2024). International guideline for pressure injury prevention and treatment. NPIAP.
- Northern HSC Trust & Public Health Agency HSC Northern Ireland. (2021). Repositioning techniques: Comfort, pressure relief, support [Poster]. <https://www.publichealth.hscni.net/publications/repositioning-techniques-poster-pressure-ulcers>
- Open Resources for Nursing (Open RN). (2024). Figure 10.13: Illustration of shear and friction forces in the development of pressure injuries. Dalam *Nursing fundamentals 2e* (Bab 10.4). Wisconsin Technical College System. <https://wtcs.pressbooks.pub/nursingfundamentals/chapter/10-4-pressure-injuries/>
- Paju, W. (2023). Faktor-faktor penyebab terjadinya pressure ulcer. *Jurnal Keperawatan*.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). *Fundamentals of nursing*. Elsevier.

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Registered Nurses' Association of Ontario. (2024). *Assessment and management of pressure injuries for the interprofessional team*. RNAO.
- Sari, Y. (2020). Tinjauan pustaka ulkus dekubitus. *Jurnal Keperawatan*.
- Silva, H., Chellappan, K., & Karunaweera, N. (2021). Image processing for mHealth-based approach to detect the local tissue inflammation in cutaneous leishmaniasis: A proof of concept study. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2021, 4208254. <https://doi.org/10.1155/2021/4208254>
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer.
- Wallace, H. A., Basehore, B. M., & Zito, P. M. (2023). Wound healing phases. Dalam *StatPearls* [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536959/>
- Wijaya, A. S., & Putri, Y. M. (2013). *Keperawatan medikal bedah 2: Keperawatan dewasa teori dan contoh askep*. Nuha Medika.
- Wounds International. (2023). *A quick guide to pressure injury management*. Wounds International.
- Zaidi, S. R. H. (2024). Pressure ulcer. Dalam *StatPearls* [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553107/>

BAB 4

MALNUTRISI, DEHIDRASI, DAN MASALAH MENELAN (*DYSPHAGIA*) PADA LANSIA

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, kepatuhan aspek legal, dan advokasi hak lansia dalam praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-5
CPL-2	Menguasai konsep penuaan dan perubahan biopsikososial-spiritual untuk memahami kebutuhan kesehatan lansia.	CPMK-1
CPL-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur.	CPMK-4; CPMK-3
CPL-5	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan lansia, keluarga, serta tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Menerapkan mutu-keselamatan pasien, dokumentasi, dan continuity of care dalam asuhan keperawatan lansia.	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar keperawatan gerontik dan proses penuaan untuk menjelaskan kebutuhan biopsikososial-spiritual lansia.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etika, hak lansia, dan aspek legal dalam pengambilan keputusan serta advokasi pada praktik keperawatan.
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, frailty, dan risiko utama.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur serta evaluasi.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan pada lansia serta keluarga secara empatik, kultural, dan kolaboratif.
CPMK-6	Mengelola dokumentasi, continuity of care, serta strategi mutu-keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE pengkajian; penugasan laporan CGA	Kelengkapan item CGA ($\geq 90\%$ terisi); ketepatan skoring instrumen (selisih ≤ 1 kategori); sintesis prioritas masalah & risiko (≥ 3 prioritas dengan alasan)	15	Lembar CGA; laporan interpretasi; checklist OSCE
CPMK-5	OSCE/role play komunikasi; penugasan materi edukasi	Keterampilan komunikasi (empati, klaritas, validasi, adaptasi sensori/kognitif) minimal “baik” pada ≥ 4 komponen; materi edukasi sesuai health literacy dan budaya (≥ 2 strategi adaptasi)	10	Video/lembar observasi OSCE; leaflet/outline edukasi
CPMK-6	Audit dokumentasi simulasi; tugas handover & rekonsiliasi obat; kuis keselamatan	Dokumentasi (lengkap, akurat, tepat waktu) $\geq 85\%$ item terpenuhi; kualitas handover (SBAR/format setara) ≥ 4 elemen lengkap; identifikasi risiko keselamatan & rencana pencegahan (≥ 3 risiko + 3 tindakan)	15	Catatan SOAP/ADPIE; form handover; form rekonsiliasi obat; hasil audit

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan & ketepatan pelaksanaan CGA	Data banyak kosong; skoring sering salah	Data cukup; beberapa komponen CGA terlewat; skoring kurang konsisten	Data lengkap; skoring benar dengan kesalahan minor	Data sangat lengkap; skoring akurat; teknik pengkajian sistematis
3.2 Sintesis hasil CGA menjadi prioritas masalah & risiko	Tidak mampu memprioritaskan; alasan tidak berbasis data	Prioritas ada namun kurang didukung data	Prioritas jelas; alasan berbasis data; risiko	Prioritas sangat tajam; mengaitkan faktor risiko, protektif, dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			utama terpetakan	kebutuhan kolaborasi

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Keterampilan komunikasi terapeutik dengan lansia	Tidak empatik; komunikasi tidak jelas; tidak adaptif	Empati ada namun kurang konsisten; adaptasi terbatas	Empatik, jelas, adaptif; membangun hubungan dan validasi	Sangat empatik; responsif; mengelola hambatan sensori/kognitif secara efektif
5.2 Kualitas edukasi & kolaborasi dengan keluarga	Materi tidak sesuai kebutuhan/kemampuan; tanpa tindak lanjut	Materi cukup sesuai; strategi adaptasi minim	Materi sesuai; adaptif budaya & literasi; ada rencana tindak lanjut	Sangat sesuai; melibatkan keluarga; strategi adaptasi kuat; evaluasi pemahaman jelas

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas dokumentasi & handover/continuity	Tidak lengkap; tidak akurat; tidak tepat waktu	Cukup lengkap namun ada kekurangan elemen penting	Lengkap, akurat, tepat waktu; format konsisten	Sangat lengkap; sangat akurat; mendukung transisi dan keterlacakan klinis
6.2 Identifikasi risiko keselamatan & rencana pencegahan	Risiko tidak terpetakan; rencana tidak spesifik	Risiko sebagian teridentifikasi; rencana umum	Risiko utama teridentifikasi; rencana pencegahan spesifik dan realistis	Risiko komprehensif; rencana pencegahan terintegrasi, prioritas jelas, dan terukur

A. Malnutrisi

1. Definisi

Malnutrisi pada lansia adalah suatu kondisi ketidakseimbangan nutrisi (baik kekurangan maupun kelebihan asupan energi, protein, dan mikronutrien) yang menyebabkan perubahan terukur pada bentuk tubuh, komposisi tubuh, serta fungsi fisik dan mental. Pada lansia, malnutrisi paling sering merujuk pada Undernutrition (kurang gizi).

2. Etiologi

Penyebab malnutrisi pada lansia sering disebut dengan istilah "The Nine Ds":

- a. Dysphagia: Kesulitan menelan.
- b. Dysgeusia: Perubahan indra perasa.
- c. Dentition: Masalah gigi atau gigi palsu yang tidak pas.
- d. Diarrhea: Gangguan penyerapan nutrisi.
- e. Depression: Kehilangan nafsu makan karena masalah psikis.
- f. Disease: Penyakit kronis (kanker, diabetes, gagal jantung).
- g. Dementia: Lupa makan atau cara makan.
- h. Dysfunction: Keterbatasan fisik untuk memasak atau makan mandiri.
- i. Drugs: Efek samping obat yang menyebabkan mual atau anoreksia.

3. Faktor Risiko

- a. Sosial: Hidup sendiri, isolasi sosial, atau kemiskinan.
- b. Fisik: Penurunan mobilitas dan gangguan penglihatan.
- c. Psikologis: Duka cita (kehilangan pasangan) dan kecemasan.

4. Patofisiologi

Proses penuaan menyebabkan penurunan massa otot (sarkopenia) dan peningkatan massa lemak. Terjadi penurunan laju metabolisme basal serta perubahan hormon pencernaan (seperti peningkatan kolesistokinin) yang menyebabkan rasa kenyang lebih cepat (anoreksia penuaan). Kondisi inflamasi kronis pada penyakit degeneratif juga meningkatkan katabolisme protein, yang jika tidak diimbangi asupan yang cukup, akan menyebabkan deplesi cadangan energi tubuh.

5. Klasifikasi

- a. Malnutrisi Akibat Penyakit (Akut): Terjadi karena inflamasi berat (misalnya sepsis atau luka bakar).
- b. Malnutrisi Akibat Penyakit Kronis: Inflamasi derajat rendah yang berlangsung lama (misalnya gagal ginjal atau kanker).

- c. Malnutrisi karena Faktor Sosial/Lingkungan: Tanpa inflamasi (misalnya karena kelaparan atau penelantaran).
- 6. Manifestasi Klinis
 - a. Penurunan berat badan secara drastis dalam waktu singkat.
 - b. Kelemahan otot dan mudah lelah (fatigue).
 - c. Kulit kering, keriput, dan penyembuhan luka yang lambat.
 - d. Rambut rontok dan kuku rapuh.
 - e. Edema (pada kasus defisiensi protein berat).
 - f. Apatis atau mudah bingung.
- 7. Pemeriksaan Penunjang
 - a. Skrining: Mini Nutritional Assessment (MNA).
 - b. Laboratorium: Albumin, Pre-albumin, Hemoglobin, dan profil lipid.
 - c. Antropometri: Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkaran lengan atas (LILA), dan tebal lipatan kulit.
- 8. Komplikasi
 - a. Sistem imun menurun (mudah infeksi seperti pneumonia).
 - b. Peningkatan risiko jatuh dan patah tulang.
 - c. Ulkus dekubitus (luka tekan).
 - d. Kematian mendadak.

Asuhan Keperawatan Malnutrisi Lansia

1. Pengkajian (Data Fokus)
 - a. Subjektif: Keluhan mual, tidak nafsu makan, perubahan rasa pada lidah, kesulitan mengunyah.
 - b. Objektif: Penurunan BB > 5% dalam sebulan, nilai Albumin < 3.5 g/dL, porsi makan tidak dihabiskan.
2. Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan/mencerna makanan atau peningkatan kebutuhan metabolisme.
3. Luaran (SLKI)

Status Nutrisi Membaik, dengan kriteria hasil: porsi makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan atau IMT membaik, dan nafsu makan meningkat.
4. Intervensi (SIKI) - Manajemen Nutrisi
 - a. Identifikasi status nutrisi dan alergi makanan.
 - b. Monitor asupan makanan dan berat badan.
 - c. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai.
 - d. Berikan suplemen makanan jika perlu.

e. Kolaborasi dengan ahli gizi.

5. Implementasi

Melaksanakan rencana tindakan yang telah disusun, seperti menyuapi lansia dengan sabar, memastikan tekstur makanan sesuai (lunak/cair), dan memantau jumlah kalori yang masuk.

6. Evaluasi

Menilai apakah berat badan sudah stabil/meningkat dan apakah tanda-tanda klinis malnutrisi mulai berkurang. Evaluasi dilakukan secara berkala (harian untuk asupan, mingguan untuk BB).

7. Edukasi

- a. Ajarkan lansia/keluarga tentang pentingnya diet tinggi protein dan tinggi kalori.
- b. Anjurkan makan porsi kecil tapi sering (5-6 kali sehari).
- c. Edukasi cara modifikasi tekstur makanan agar mudah ditelan.

8. Dokumentasi

Mencatat hasil skrining (MNA), grafik berat badan, jenis diet yang diberikan, jumlah asupan harian, serta respons pasien terhadap intervensi nutrisi yang diberikan.

B. Masalah Menelan Dispagia pada Lansia

1. Definisi

Disfagia adalah sensasi adanya hambatan pada aliran makanan atau minuman dari mulut menuju lambung. Pada lansia, ini sering disebabkan oleh perubahan fungsi neuromuskular atau struktural akibat proses penuaan (Presbyphagia) atau penyakit penyerta.

2. Etiologi

Penyebab disfagia pada lansia dibagi menjadi dua kategori utama:

- a. Disfagia Orofaringeal (Transfer Dysphagia): Kesulitan memindahkan makanan dari mulut ke faring. Sering disebabkan oleh stroke, penyakit Parkinson, demensia, atau kelemahan otot wajah.
- b. Disfagia Esofageal: Kesulitan setelah makanan melewati faring. Sering disebabkan oleh striktur (penyempitan) esofagus, akalasia, atau GERD kronis.

3. Faktor Risiko

- a. Penuaan Fisiologis: Penurunan produksi air liur (xerostomia) dan berkurangnya kekuatan lidah.
- b. Kesehatan Gigi: Gigi tanggal atau gigi palsu yang tidak pas.
- c. Obat-obatan: Efek samping obat antikolinergik yang membuat mulut kering.
- d. Kondisi Neurologis: Riwayat stroke atau penyakit degeneratif saraf.

4. Patofisiologi

Proses menelan terdiri dari fase oral, faringeal, dan esofageal. Pada lansia, terjadi penurunan koordinasi antara penutupan epiglotis dan pembukaan sfingter esofagus atas. Kelemahan otot-otot pengunyah dan lidah membuat bolus (gumpalan makanan) tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga makanan berisiko tertahan di tenggorokan atau masuk ke saluran pernapasan sebelum katup menutup sempurna.

5. Klasifikasi

- a. Disfagia Mekanik: Akibat sumbatan fisik (tumor, peradangan).
- b. Disfagia Motorik/Neuromuskular: Akibat gangguan saraf atau otot (Stroke, Myasthenia Gravis).
- c. Presbifagia: Perubahan fungsi menelan yang terjadi murni karena proses penuaan alami.

6. Manifestasi Klinis

- a. Batuk atau tersedak saat/setelah makan dan minum.
- b. Suara "basah" atau parau (*wet voice*) setelah menelan.
- c. Makanan terselip di pipi (pocketing).
- d. Membutuhkan waktu lama untuk mengunyah atau menelan.
- e. Nyeri saat menelan (odinofagia).
- f. Regurgitasi (makanan keluar kembali melalui hidung atau mulut).

7. Pemeriksaan Penunjang

- a. Bedside Swallowing Assessment: Tes menelan air putih di tempat tidur.
- b. VFS (Video Fluoroscopic Swallowing study): Standar baku emas (*Gold Standard*) untuk melihat proses menelan melalui sinar-X.
- c. FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing): Menggunakan kamera kecil melalui hidung untuk melihat struktur tenggorokan saat menelan.

8. Komplikasi

- a. Pneumonia Aspirasi: Infeksi paru akibat masuknya makanan/cairan.
- b. Malnutrisi dan Dehidrasi.
- c. Obstruksi Jalan Napas: Tersedak fatal.
- d. Isolasi Sosial: Malu makan di depan orang lain.

Asuhan Keperawatan Disfagia

1. Penatalaksanaan (Medis & Non-Medis)

- a. Modifikasi diet (makanan lunak, cairan kental).
- b. Latihan penguatan otot menelan (logopedik).
- c. Pemasangan selang makan (NGT) jika risiko aspirasi sangat tinggi.

2. Pengkajian (Data Fokus)

- a. Cek reflek muntah (*gag reflex*).
- b. Observasi adanya batuk saat minum air.
- c. Periksa kebersihan mulut dan kondisi gigi.

3. Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Gangguan Menelan berhubungan dengan gangguan neurologis, kelemahan otot, atau penurunan reaksi epiglotis.

4. Luaran (SLKI)

Status Menelan Membaik, dengan kriteria: Mempertahankan makanan di mulut meningkat, refleks menelan meningkat, batuk/tersedak menurun.

5. Intervensi (SIKI) - Dukungan Kepatuhan Program Diet

- a. Posisikan pasien tegak (90 derajat) saat makan dan 30 menit setelahnya.
- b. Gunakan alat bantu makan jika perlu.
- c. Berikan instruksi menelan (misal: "tekuk dagu ke dada saat menelan" / *chin-tuck maneuver*).
- d. Monitor tanda-tanda aspirasi.

6. Implementasi

Melakukan pemantauan ketat saat lansia makan, memastikan tekstur makanan sesuai instruksi ahli gizi (misal: bentuk *puree*), dan melatih pasien melakukan teknik menelan yang aman.

7. Evaluasi

- a. Apakah pasien dapat menelan tanpa batuk?
- b. Apakah saturasi oksigen tetap stabil saat makan?
- c. Apakah berat badan stabil?

8. Edukasi

- a. Ajarkan keluarga cara memotong makanan kecil-kecil.
- b. Informasikan tanda bahaya (tersedak) yang memerlukan tindakan darurat.
- c. Anjurkan lingkungan makan yang tenang (tanpa distraksi TV/bicara saat makan).

9. Dokumentasi

Mencatat jenis tekstur makanan, durasi makan, adanya insiden tersedak, posisi pasien, serta jumlah asupan yang masuk.

C. Dehidrasi pada lansia

1. Definisi

Dehidrasi pada lansia adalah kondisi gangguan keseimbangan cairan tubuh di mana pengeluaran cairan melebihi asupannya, yang menyebabkan penurunan

volume air dalam sel dan jaringan tubuh. Hal ini sering diperburuk oleh penurunan cadangan air tubuh total seiring bertambahnya usia.

2. Etiologi

- a. Penurunan Sensasi Haus: Pusat haus di hipotalamus menjadi kurang sensitif.
- b. Penurunan Fungsi Ginjal: Kemampuan ginjal untuk mengonsentrasikan urine menurun.
- c. Asupan Tidak Adekuat: Ketidakmampuan fisik untuk mengambil air atau ketergantungan pada pengasuh.
- d. Kehilangan Cairan Berlebih: Melalui diare, muntah, demam, atau diuresis berlebihan (akibat obat).

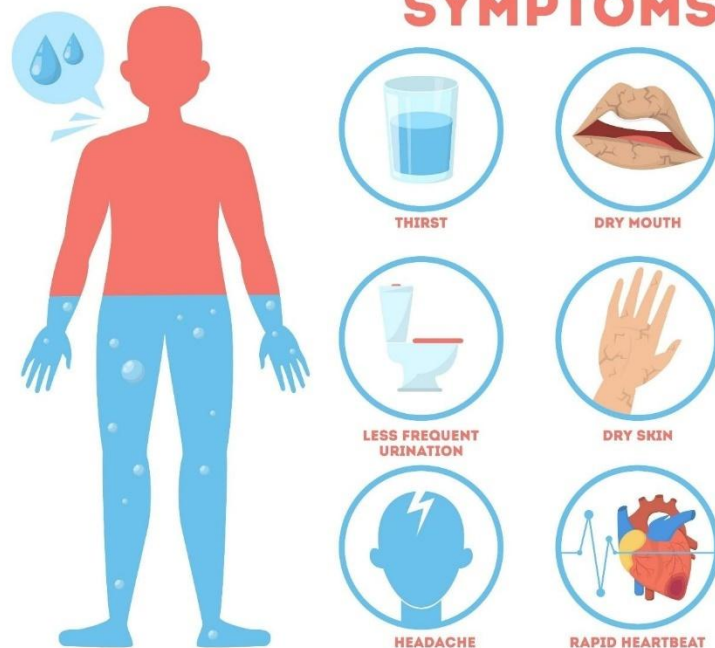
3. Faktor Risiko

- a. Fisik: Imobilitas, gangguan menelan (disfagia), dan inkontinensia urin (lansia sengaja tidak minum agar tidak sering ke toilet).
- b. Kognitif: Demensia atau delirium yang membuat lansia lupa minum.
- c. Farmakologis: Penggunaan diuretik, laksatif, dan obat penenang.
- d. Lingkungan: Cuaca panas atau suhu ruangan yang tinggi.

4. Patofisiologi

Seiring bertambahnya usia, komposisi tubuh berubah: massa otot menurun dan lemak meningkat, yang menyebabkan Total Body Water (TBW) menurun sekitar 10-15%. Ketika terjadi kehilangan cairan, tubuh lansia gagal merespons dengan cepat melalui vasopresin (hormon ADH) karena resistensi ginjal, sehingga urine tetap encer meskipun tubuh kekurangan cairan. Hal ini memicu penurunan volume plasma, gangguan perfusi jaringan, dan ketidakseimbangan elektrolit.

DEHYDRATION SYMPTOMS



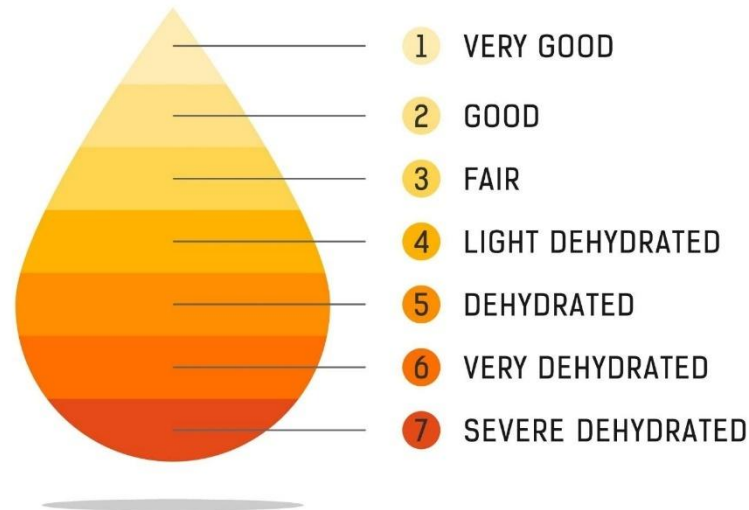
5. Klasifikasi

- Dehidrasi Isotonik: Kehilangan air dan natrium dalam proporsi yang sama (misal: diare).
- Dehidrasi Hipertonik: Kehilangan air lebih banyak daripada natrium (paling umum pada lansia karena kurang minum).
- Dehidrasi Hipotonik: Kehilangan natrium lebih banyak daripada air (misal: penggunaan diuretik berlebihan).

6. Manifestasi Klinis

- Neurologis: Kebingungan mendadak (delirium), mengantuk, dan pusing.
- Fisik: Mukosa mulut kering, lidah beralur (fissured tongue), mata cekung.
- Kardiovaskular: Takikardia, hipotensi ortostatik (pusing saat berdiri).
- Urin: Urine berwarna gelap dan jumlahnya sedikit (oliguria).
- Turgor Kulit: Pada lansia, turgor kulit kurang akurat (karena kehilangan elastisitas alami), sehingga pengecekan dilakukan di area sternum atau klavikula.

URINE COLOR WITH MODERN STYLE



7. Pemeriksaan Penunjang

- Laboratorium: Peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN), kreatinin, dan osmolaritas serum.
- Elektrolit: Natrium serum (sering kali > 145 mEq/L pada dehidrasi hipertonik).
- Berat Jenis Urine: Meningkat (> 1.020).

8. Komplikasi

- Gagal ginjal akut.
- Kejang akibat ketidakseimbangan elektrolit.
- Heat stroke.
- Peningkatan risiko jatuh dan patah tulang.
- Ulkus dekubitus.

9. Pengkajian

- A (Airway): Jalan napas bersih.
- B (Breathing): Frekuensi napas bisa meningkat jika terjadi asidosis.
- C (Circulation): Nadi cepat dan lemah, CRT > 2 detik, akral dingin.
- D (Data Nutrisi/Cairan): Cek berat badan harian dan turgor mukosa.

10. Diagnosis Keperawatan (SDKI)

- Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau kegagalan mekanisme regulasi.

- b. Risiko Ketidakseimbangan Elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan.

11. Luaran Keperawatan (SLKI)

Status Cairan Membaik, dengan kriteria:

- a. Turgor kulit meningkat.
- b. Output urine meningkat.
- c. Membran mukosa lembap.
- d. Frekuensi nadi dan tekanan darah membaik.

12. Intervensi (SIKI) - Manajemen Hipovolemia

- a. Periksa tanda dan gejala hipovolemia.
- b. Monitor intake dan output cairan.
- c. Hitung kebutuhan cairan berdasarkan berat badan (rata-rata 30 ml/kgBB/hari).
- d. Berikan asupan cairan oral sedikit demi sedikit namun sering.
- e. Kolaborasi pemberian cairan IV (misal: NaCl 0,9%) jika dehidrasi berat.

13. Implementasi

Melakukan rehidrasi sesuai instruksi, memotivasi lansia untuk minum meskipun tidak merasa haus, dan memantau tetesan infus serta tanda-tanda kelebihan cairan (*overload*) pada jantung.

14. Evaluasi

Menilai apakah produksi urine sudah mencapai 0,5-1 ml/kgBB/jam, tanda-tanda vital stabil, dan kesadaran (GCS) membaik.

15. Edukasi

- a. Anjurkan minum air putih minimal 8 gelas sehari (kecuali ada kontraindikasi jantung/ginjal).
- b. Edukasi keluarga untuk menyediakan air minum yang mudah dijangkau.
- c. Edukasi tanda awal dehidrasi seperti warna urine yang mulai menggelap.

16. Dokumentasi

Mencatat jumlah cairan masuk (oral + IV), jumlah urine, warna urine, serta respon klinis pasien setelah tindakan rehidrasi.

D. Aktivitas 1 — *Knows How*

1. Seorang Perempuan (78 tahun) tinggal di Panti Werdha. Riwayat stroke 6 bulan lalu mengakibatkan kelemahan sisi kanan tubuh. Perawat mencatat klien sering tersedak saat minum air putih dan menyisakan 3/4 porsi makannya, klien tampak batuk saat mencoba menelan air (tes menelan positif disfagia), nafsu makan menurun karena takut tersedak. Klien mengeluh cepat Lelah, pusing dan mulut terasa kering. Berat badan turun 3 kg dalam satu bulan terakhir dari BB 50 Kg menjadi 44 Kg, Pemeriksaan Albumin serum 2.8 g/dl. Pemeriksaan fisik

menunjukkan mukosa bibir kering, turgor kulit tidak elastis (> 3 detik), mata dan otot temporal tampak cekung. Kesadaran *compos mentis* namun tampak lemah

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

- Berdasarkan data di atas, apa diagnosis keperawatan prioritas untuk Ny. S?
- Lakukan simulasi pengkajian menggunakan instrument kemampuan menelan, apa interpretasi skornya jika dilihat dari data objektif tersebut?
- Identifikasi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi Ny S
- Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

E. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill Manajemen Nutrisi Pemberian Makan

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Manajemen nutrisi pemberian makan

Catatan untuk penulis:

Karena CP Bab = mendemonstrasikan

OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Lakukan tes *water swallow* untuk menilai tingkat disfagia.
- Ubah tekstur makanan menjadi *soft diet* atau saring.
- Berikan cairan menggunakan sendok secara perlahan, hindari penggunaan sedotan (risiko aspirasi tinggi).
- Posisikan duduk tegak 90° saat makan dan tetap tegak selama 30 menit setelah makan.

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Gerontik
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, dan demonstrasi pemberian makan pada lansia.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang Perempuan (78 tahun) tinggal di Panti Werdha. Riwayat stroke 6 bulan lalu mengakibatkan kelemahan sisi kanan tubuh. Perawat mencatat klien sering tersedak saat minum air putih dan menyisakan 3/4 porsi makannya, klien tampak batuk saat mencoba menelan air (tes menelan positif disfagia), nafsu makan menurun karena takut tersedak. Klien mengeluh cepat Lelah, pusing dan mulut terasa kering. Berat badan turun 3 kg dalam satu bulan terakhir dari BB 50 Kg menjadi 44 Kg, Pemeriksaan Albumin serum 2.8 g/dl. Pemeriksaan fisik menunjukkan mukosa bibir kering, turgor kulit tidak elastis (> 3 detik), mata dan otot temporal tampak cekung. Kesadaran compos mentis namun tampak lemah TUGAS: 1. Lakukan pengkajian kemampuan menelan pada klien 2. Tentukan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus.

No.	Komponen	Isi
		3. Lakukan tindakan keperawatan, pemberian makan (diet lunak/saring) dengan teknik pencegahan aspirasi 4. Lakukan edukasi menelan yang aman kepada klien
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang Perempuan (78 tahun) tinggal di Panti Werdha. Riwayat stroke 6 bulan lalu mengakibatkan kelemahan sisi kanan tubuh. Perawat mencatat klien sering tersedak saat minum air putih dan menyisakan 3/4 porsi makannya, klien tampak batuk saat mencoba menelan air (tes menelan positif disfagia), nafsu makan menurun karena takut tersedak. Klien mengeluh cepat Lelah, pusing dan mulut terasa kering. Berat badan turun 3 kg dalam satu bulan terakhir dari BB 50 Kg menjadi 44 Kg, Pemeriksaan Albumin serum 2.8 g/dl. Pemeriksaan fisik menunjukkan mukosa bibir kering, turgor kulit tidak elastis (> 3 detik), mata dan otot temporal tampak cekung. Kesadaran compos mentis namun tampak lemah TUGAS: 1. <i>Ketepatan Diagnosis:</i> Gangguan Menelan berhubungan dengan gangguan neurologis, kelemahan otot, atau penurunan reaksi epiglottis. 2. <i>Prosedur:</i> Posisi duduk 90 derajat, <i>chin-tuck maneuver</i>, porsi kecil, observasi tanda tersedak. 3. <i>Edukasi:</i> Menjelaskan pentingnya duduk tegak 30 menit pasca makan. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, kemampuan menelan 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Defisit Nutrisi berhubungan dengan gangguan menelan 3. Menilai kemampuan peserta dalam kebersihan mulut (oral hygiene) sebelum dan setelah makan 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi <i>Prosedur:</i> Posisi duduk 90 derajat, <i>chin-tuck maneuver</i>, porsi kecil, observasi tanda tersedak. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: Perempuan 78 tahun. KS berperan sebagai pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: Stroke 3. Anda merasa lemas, pusing, dan takut tersedak saat makan. 4. Jika perawat menyuapi dengan posisi berbaring, Anda harus batuk. 5. Jika perawat meminta Anda menunduk sedikit saat menelan, ikuti instruksinya.
10	Setting station	Ruang Rawat Geriatrik - Tempat tidur pasien

No.	Komponen	Isi
		- KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur KS 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Pintu masuk 5. Troli alat 6. Wastafel/handrub 7. Tempat sampah 8. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Makanan dengan tekstur yang sesuai (lunak, saring, atau lumat sesuai instruksi diet). 5. Set oral hygiene 6. Sendok kecil 7. Gelas minum 8. Gelas/cangkir kecil 9. Air minum hangat 10. bengkok Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI
Pemberian Makan pada Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Makanan dengan tekstur yang sesuai (lunak, saring, atau lumat sesuai instruksi diet). 5. Set oral hygiene 6. Sendok kecil 7. Gelas minum 8. Air minum hangat 9. bengkok				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan klien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Pengaturan posisi Dudukkan lansia pada posisi tegak 90 derajat (High Fowler). Jika di tempat tidur, gunakan bantal untuk menyangga punggung dan kepala.				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
14	Tekuk sedikit kepala ke depan (<i>chin-tuck maneuver</i>) untuk menutup jalan napas dan membuka kerongkongan				
15	Pastikan mulut dalam keadaan bersih lakukan oral hygiene				
16	Cek kesadaran pasien; jangan memberi makan jika pasien tampak sangat mengantuk.				
	Proses pemberian makanan				
17	Berikan makanan dalam porsi kecil (sekitar 1/2 - 1 sendok teh) setiap suapan.				
18	Letakkan makanan pada sisi mulut yang tidak mengalami kelemahan (jika pasien mengalami stroke/parese).				
19	Instruksikan pasien untuk mengunyah perlahan dan pastikan makanan benar-benar tertelan sebelum suapan berikutnya.				
20	Amati adanya tanda-tanda tersedak, batuk, atau suara "basah" setelah menelan.				
21	Berikan minum di sela-sela makan jika diperlukan, namun hindari mencampur makanan padat dan cair dalam satu suapan (risiko aspirasi tinggi).				
D	Tahap Terminasi				
22	Pembersihan: Bersihkan sisa makanan di area mulut dan lakukan <i>oral hygiene</i> untuk mencegah pertumbuhan bakteri dari sisa makanan (bolus) yang tertinggal.				
23	Pertahankan Posisi: Wajib menjaga posisi duduk atau setengah duduk (minimal 30-45 derajat) selama 30-60 menit setelah makan untuk mencegah refluks				
24	Rapikan alat dan cuci tangan.				
25	Evaluasi: Catat jumlah porsi yang habis, adanya reaksi batuk, atau kesulitan menelan selama proses berlangsung.				
26	Edukasi Keluarga: Informasikan kepada keluarga mengenai tekstur makanan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	yang aman dan pentingnya posisi duduk saat makan				
E	Tahap Dokumentasi				
27	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian makan, respons klien dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
28	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Cek reflek muntah (gag reflex), Observasi adanya batuk saat minum air, periksa kebersihan mulut dan kondisi gigi					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Gangguan Menelan berhubungan dengan gangguan neurologis, kelemahan otot, atau penurunan reaksi epiglotis.					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian makan	Modifikasi Tekstur: Diet lunak, <i>puree</i> , atau cair kental sesuai derajat disfagia. Postural Adjustment: * High Fowler (90°): Posisi utama saat makan. Chin-Tuck Maneuver: Menundukkan dagu saat menelan untuk menutup jalan napas. Oral Hygiene: Membersihkan mulut sebelum makan untuk merangsang saraf sensorik.					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0= tidak dilakukan
- 1= dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2= dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3= dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DENGAN GANGGUAN
MENALAN (DISFAGIA)

II. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus fisik terkait status hidrasi dan risiko aspirasi (disfagia) pada pasien, Cek reflek muntah (gag reflex), Obeservasi adanya batuk saat minum air, periksa kebersihan mulut dan kondisi gigi Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis Gangguan Menelan berhubungan dengan gangguan neurologis, kelemahan otot, atau penurunan reaksi epiglottis. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Modifikasi Tekstur: Diet lunak, puree, atau cair kental sesuai derajat disfagia. Postural Adjustment: * High Fowler (90°): Posisi utama saat makan. Chin-Tuck Maneuver: Menundukkan dagu saat menelan untuk menutup jalan napas. Oral Hygiene: Membersihkan mulut sebelum makan untuk merangsang saraf sensorik. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik klien, menjaga kenyamanan dan keamanan klien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

III. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus gangguan menelan pada lansia	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, status hidrasi dan risiko aspirasi (disfagia) pada pasien, Cek reflek muntah (gag	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi status hidrasi dan risiko aspirasi (disfagia) pada pasien, Cek reflek muntah (gag reflex), Obeservasi adanya batuk saat

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		tanda hidrasi secara tepat.	reflex), Obeservasi adanya batuk saat minum air, periksa kebersihan mulut dan kondisi gigi, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	minum air, periksa kebersihan mulut dan kondisi gigi
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, Gangguan Menelan berhubungan dengan gangguan neurologis, kelemahan otot, atau penurunan reaksi epiglottis.
3. Implementasi Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi Modifikasi Tekstur: Diet lunak, <i>puree</i> , atau cair kental sesuai derajat disfagia. Postural Adjustment: * High Fowler (90°): Posisi utama saat makan. Chin-Tuck Maneuver: Menundukkan dagu saat menelan untuk menutup jalan napas. Oral Hygiene: Membersihkan mulut sebelum	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum Modifikasi Tekstur: Diet lunak, <i>puree</i> , atau cair kental sesuai derajat disfagia. Postural Adjustment: * High Fowler (90°): Posisi utama saat makan. Chin-Tuck Maneuver: Menundukkan	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi. Modifikasi Tekstur: Diet lunak, <i>puree</i> , atau cair kental sesuai derajat disfagia. Postural Adjustment: * High	Melakukan edukasi dan demonstrasi Modifikasi Tekstur: Diet lunak, <i>puree</i> , atau cair kental sesuai derajat disfagia. Postural Adjustment: * High Fowler (90°): Posisi utama saat makan. Chin-Tuck Maneuver: Menundukkan dagu saat menelan untuk menutup jalan napas. Oral Hygiene: Membersihkan mulut sebelum makan untuk merangsang saraf sensorik.

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	makan untuk merangsang saraf sensorik.	dagu saat menelan untuk menutup jalan napas. Oral Hygiene: Membersihkan mulut sebelum makan untuk merangsang saraf sensorik. tepat.	Fowler (90°): Posisi utama saat makan. Chin-Tuck Maneuver: Menundukkan dagu saat menelan untuk menutup jalan napas. Oral Hygiene: Membersihkan mulut sebelum makan untuk merangsang saraf sensorik.	
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematisa tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan klien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

IV. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

V. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....
Penguji :

F. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Gerontik pada Lansia
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

1. Dari simulasi → praktik nyata
2. Bukti performa sesungguhnya

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Gerontik dengan gangguan menelan

Komponen	Deskripsi	Klien lansia dengan gangguan menelan
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada klien lansia yang mengalami gangguan menelan disfagia di
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik,	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang disfagia, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi kesulitan

Komponen	Deskripsi	Klien lansia dengan gangguan menelan
	komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	menelan, dan menyampaikan rencana asuhan kepada klien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang Perempuan (78 tahun) tinggal di Panti Werdha. Riwayat stroke 6 bulan lalu mengakibatkan kelemahan sisi kanan tubuh. Perawat mencatat klien sering tersedak saat minum air putih dan menyisakan 3/4 porsi makannya, klien tampak batuk saat mencoba menelan air (tes menelan positif disfagia), nafsu makan menurun karena takut tersedak. Klien mengeluh cepat Lelah, pusing dan mulut terasa kering. Berat badan turun 3 kg dalam satu bulan terakhir dari BB 50 Kg menjadi 44 Kg, Pemeriksaan Albumin serum 2.8 g/dl. Pemeriksaan fisik menunjukkan mukosa bibir kering, turgor kulit tidak elastis (> 3 detik), mata dan otot temporal tampak cekung. Kesadaran compos mentis namun tampak lemah
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, fisik terkait status hidrasi dan risiko aspirasi (disfagia) pada pasien, Cek reflek muntah (gag reflex), Observasi adanya batuk saat minum air, periksa kebersihan mulut dan kondisi gigi.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menentukan masalah keperawatan Gangguan Menelan berhubungan dengan gangguan neurologis, kelemahan otot, atau penurunan reaksi epiglotis.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, gangguan menelan disfagia serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada klien
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi kemampuan menelan, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian intake-output dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.

Komponen	Deskripsi	Klien lansia dengan gangguan menelan
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus klien dengan diare, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 4.1

Portofolio pada Asuhan Keperawatan Gerontik pada Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)

Komponen	Deskripsi	Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan gerontik lansia dengan disfagia portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat lansia dengan disfagia, tetapi juga

Komponen	Deskripsi	Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)
	tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi latihan makan, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada lansia dengan disfagia
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus lansia usia 78 tahun dengan Riwayat stroke 6 bulan lalu mengakibatkan kelemahan sisi kanan tubuh. Perawat mencatat klien sering tersedak saat minum air putih dan menyisakan 3/4 porsi makannya, klien tampak batuk saat mencoba menelan air (tes menelan positif disfagia). diagnosis keperawatan prioritas, intervensi hidrasi, edukasi oralit, dan evaluasi respons klien .
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau status hidrasi dan risiko aspirasi (disfagia) pada pasien, Cek reflek muntah (gag reflex), dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan klien, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian hidrasi dan derajat disfagia
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu geriatric tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan klien secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten

Komponen	Deskripsi	Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)
	kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	mampu melakukan pengkajian status hidrasi, resiko aspirasi (disfagia) dan komunikasi terapeutik dengan lansia
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan gerontik dengan klien lansia dengan gangguan menelan disfagia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 4.2
Case Report pada Asuhan Keperawatan Gerontik pada Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)

Komponen	Deskripsi	Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang Perempuan usia 78 tahun tinggal di panti werdha Riwayat stroke 6 bulan lalu mengakibatkan kelemahan sisi kanan tubuh. Perawat mencatat klien sering tersedak saat minum air putih dan menyisakan 3/4 porsi makannya, klien tampak batuk saat mencoba menelan air (tes menelan positif disfagia).
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi klien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus gangguan menelan (Disfagia), Riwayat stroke 6 bulan lalu mengakibatkan kelemahan sisi kanan tubuh. Perawat mencatat klien sering tersedak saat minum air putih dan menyisakan 3/4 porsi makannya, klien tampak batuk saat mencoba menelan air (tes menelan positif disfagia), diagnosis Gangguan Menelan berhubungan dengan gangguan

Komponen	Deskripsi	Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)
		neurologis, kelemahan otot, atau penurunan reaksi epiglotis.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data Klien mengeluh cepat Lelah, pusing dan mulut terasa kering. Berat badan turun 3 kg dalam satu bulan terakhir dari BB 50 Kg menjadi 44 Kg, Pemeriksaan Albumin serum 2.8 g/dl. Pemeriksaan fisik menunjukkan mukosa bibir kering, turgor kulit tidak elastis (> 3 detik), mata dan otot temporal tampak cekung. dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons klien setelah pemberian makan
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus disfagia, mahasiswa belajar bahwa pengkajian kebutuhan nutrisi, tanda dehidrasi dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan geriatric
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep disfagia pada lansia, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 4.3
Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Gerontik pada Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)

Komponen	Deskripsi	Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus klien dengan disfagia, mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan cairan yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau intake-output atau terlambat mengenali

Komponen	Deskripsi	Lansia dengan Gangguan Menelan (Disfagia)
	pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	tanda dehidrasi, dapat berdampak besar pada keselamatan klien .
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah aspirasi pernafasan ketidakseimbangan kelemahan otot sebelah kanan , dan keterlibatan penanganan bila tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain aspirasi, malnutrisi dan dehidrasi, obstruksi jalan nafas terdapat fatal.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda-tanda aspirasi, menjelaskan modifikasi diet, makanan lunak cairan kental, latihan penguatan otot menelan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada klien gangguan menelan disfagia, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan klien secara berkelanjutan.

G. Ringkasan Materi

1. Malnutrisi pada Lansia

- Anoreksia Geriatrik: Penurunan nafsu makan akibat penurunan hormon lapar (ghrelin) dan penurunan indra perasa/penciuman.
- Sarkopenia: Kehilangan massa otot yang memperburuk kondisi fisik dan menurunkan metabolisme basal.

2. Gangguan Menelan (Disfagia)

Disfagia pada lansia sering disebabkan oleh stroke, Parkinson, atau demensia stadium lanjut.

- Fase Oral: Kesulitan mengunyah dan membentuk bolus.
- Fase Faringeal: Keterlambatan refleks menelan yang berisiko menyebabkan makanan masuk ke laring (aspirasi).

3. Dehidrasi

Lansia berisiko tinggi dehidrasi karena:

- Penurunan total cairan tubuh.
- Penurunan sensasi haus (*hypodipsia*).
- Penurunan fungsi konsentrasi urine di ginjal

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Klien dengan Klinis (Disfagia, Malnutrisi, & Dehidrasi)

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Disfagia & Aspirasi	Risiko Tinggi Pneumonia Aspirasi & Obstruksi Jalan Napas. Batuk terus-menerus saat/setelah makan. Suara serak/basah (<i>wet voice</i>) setelah menelan. Penurunan saturasi oksigen (SpO ₂ < 94) saat makan. Sianosis (bibir kebiruan).	Hentikan pemberian makan segera. Lakukan <i>Suctioning</i> jika perlu. Berikan Oksigen. Lapor Dokter untuk pemasangan NGT atau rujukan Terapis Wicara
Hidrasi (Dehidrasi)	Resiko Syok hipovolemik & gagal ginjal akut Penurunan kesadaran (Apatis/Delirium). Produksi urine < 0.5 ml/kgBB/jam (Oliguria). Tekanan darah sistolik turun > 20 mmHg (Hipotensi). Mata sangat cekung dan lidah pecah-pecah.	Posisikan <i>Shock Position</i> (kaki lebih tinggi). Monitor Tanda Vital setiap 15-30 menit. Eskalasi untuk kolaborasi Rehidrasi Intravena (IV). Cek elektrolit (Natrium/Kalium).
Nutrisi (Malnutrisi)	Risiko Gagal Jantung, Sepsis, dan Kematian	Lapor Dokter Spesialis Gizi Klinik.

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
	Penurunan BB drastis (> 5% dalam 1 bulan). Edema anasarka (akibat hipoalbuminemia berat). Luka tekan (<i>pressure injury</i>) yang tidak kunjung sembuh. <i>Refeeding Syndrome</i> (kelemahan otot hebat setelah mulai makan).	Monitor hasil laboratorium (Albumin & Profil Protein). Pertimbangkan pemberian Nutrisi Parenteral. Kaji ulang tekstur dan kalori diet.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Asuhan Keperawatan Klien dengan Klinis (Disfagia, Malnutrisi, & Dehidrasi)

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	"Saya memberikan makan pada Ny. S yang mengalami disfagia. Saat suapan ketiga, pasien tampak batuk kecil dan matanya berair, namun tetap ingin melanjutkan makan."	☐	☐	
2	"Saya merasa panik dan khawatir akan terjadi aspirasi, namun saya berusaha tetap tenang agar pasien tidak ikut merasa cemas."	☐	☐	
3	Hal baiknya, saya langsung menghentikan suapan dan membetulkan posisi duduknya. Hal buruknya, saya menyadari suapan saya di awal mungkin terlalu besar bagi pasien disfagia."	☐	☐	
4	Batuk terjadi karena mekanisme katup epiglottis lansia sudah lambat. Cairan atau makanan yang terlalu cepat masuk dapat melewati pita suara sebelum tertutup sempurna."	☐	☐	
5	Seharusnya saya lebih sabar, memberikan jeda antar suapan, dan memastikan mulut benar-benar kosong (<i>no pocketing</i>) sebelum suapan berikutnya."	☐	☐	
6	"Saya akan selalu menerapkan teknik <i>Chin-Tuck</i> (menunduk) dan menggunakan sendok teh untuk mengontrol volume makanan demi mencegah risiko aspirasi"	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Referensi

- Abdelhamid, A., Bunn, D., Copley, M., Netshidzivhani, V., & Hooper, L. (2020). Effectiveness of interventions to directly support food and drink intake in people with dementia: Systematic review and meta-analysis. *BMC Geriatrics*, 20(1), 1-15.
- Amaraya, S., Singh, K., & Chatfield, M. J. (2023). Nutritional assessment and management of the elderly. *Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics*, 14(2), 45-52.
- Aziz, Q., et al. (2016). *Esophageal motility disorders in the elderly*. World Journal of Gastroenterology.
- Bolivar-Cardona, M. C., & Mota-Castillo, P. J. (2021). Dysphagia in the elderly: Management and nutritional considerations. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, 24(1), 23-29.
- Cederholm, T., et al. (2019). *GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community*. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.
- Chen, X., Zhao, X., & Liu, Y. (2024). *Comprehensive Geriatric Nursing: Theory and Practice*. Elsevier Health Sciences.
- Cruz-Jentoft, A. J., & Sayer, A. A. (2019). *Sarcopenia*. The Lancet, 393(10191), 2636-2646.
- Donini, L. M., et al. (2023). *Definition and Diagnosis of Malnutrition in Older Adults: A Systematic Review*. Nutrients, 15(4).
- Escott-Stump, S. (2022). *Nutrition and Diagnosis-Related Care* (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Fatmah. (2021). *Gizi Usia Lanjut*. Erlangga: Jakarta.
- Hooper, L., et al. (2020). *Water-loss dehydration and aging*. Mechanisms of Ageing and Development.
- Humbert, I. A., & Robbins, J. (2020). *Dysphagia in the Elderly*. Clinics in Geriatric Medicine.
- International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). (2025). *Updated Framework for Texture-Modified Foods and Thickened Fluids in Aged Care*. [Online Resource].
- Journal of Geriatric Nursing. (2026). *Digital Monitoring Systems for Nutritional Intake and Swallowing Safety in Long-term Care Facilities*. (Prediksi publikasi terkini mengenai integrasi teknologi AI dalam pemantauan nutrisi lansia).
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Pedoman Pelayanan Gizi Lanjut Usia*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Lestari, S. P., & Sugesti, R. (2021). *Asuhan Keperawatan pada Pasien Stroke dengan Gangguan Menelan*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan.
- Margetts, B. M., Thompson, R. L., & Elia, M. (2019). Screening for malnutrition in the community: The use of the Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) in elderly people. *British Journal of Nutrition*, 121(3), 341-350.
- National Institute on Aging (2023). *Maintaining Fluid Balance in Older Adults*.
- Nativ-Zeltzer, N., et al. (2021). *The Relationship Between Dysphagia and Sarcopenia in Community-Dwelling Older Adults*. Journal of Nutrition, Health & Aging.
- Picetti, D., et al. (2017). *Hydration health and issues in the elderly*. Nutrition and Healthy Aging.
- Pinto, A., & Roberts, S. (2025). Dehydration in older adults: Identification and management in clinical settings. *Nursing Older People*, 37(2), 18-25.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI
- Reber, E., et al. (2019). *Management of Malnutrition in Geriatric Patients: Current Concepts and Evidence*. Journal of Clinical Medicine, 8(11).
- Sari, N. P., et al. (2022). *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Status Gizi pada Lansia*. Jurnal Keperawatan Silampari, 5(2).
- Sihombing, R. (2020). *Manajemen Disfagia pada Lansia dengan Penyakit Neurodegeneratif*. Jurnal Kedokteran Indonesia
- Sura, L., et al. (2012, updated 2016). *Dysphagia in the elderly: management and nutritional considerations*. Clinical Interventions in Aging.
- Volkert, D., et al. (2019). *ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics*. Clinical Nutrition, 38(1), 10-47.
- Volpi, E., et al. (2022). *Geriatric Nutrition and Dehydration Management*. Journal of Gerontology.
- Wirth, R., Dziewas, R., & Beck, A. M. (2022). Oropharyngeal dysphagia in older persons – from pathophysiology to personalized management. *Nature Reviews Disease Primers*, 8(1), 1-20.
- Wirth, R., et al. (2016). *Oropharyngeal dysphagia in older persons – from pathophysiology to adequate intervention: a review and summary of an international expert meeting*. Clinical Interventions in Aging, 11, 189-208.
- World Gastroenterology Organisation. (2024). *Global Guidelines: Dysphagia – A Global Perspective*.

BAB 5

POLIFARMASI & KESELAMATAN OBAT PADA LANSIA (KOLABORASI INTERPROFESIONAL)

CPMK Utama yaitu:

- CPMK 6: Mengelola dokumentasi, *continuity of care*, serta strategi mutu-keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.

CPMK Penguat:

- CPMK-2; Menerapkan prinsip etika, hak lansia, dan aspek legal dalam pengambilan keputusan serta advokasi pada praktik keperawatan.
- CPMK-3; Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, *frailty*, dan risiko utama.
- CPMK-7: Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan

Sub CPMK

- 14.1 Mengidentifikasi polifarmasi, obat berisiko tinggi, dan potensi interaksi/efek samping melalui *medication review* sederhana.
- 14.2 Merancang strategi keselamatan obat: rekonsiliasi obat, edukasi kepatuhan, dan komunikasi interprofesional untuk *deprescribing* bila perlu

A. Polifarmasi pada lansia

1. Definisi Polifarmasia pada lansia

Polifarmasi adalah kondisi penggunaan banyak obat secara bersamaan pada satu pasien. Umumnya didefinisikan sebagai ≥ 5 jenis obat dalam satu waktu, atau penggunaan obat yang tidak sesuai indikasi. Lansia adalah Usia ≥ 60 tahun mengalami multimorbiditas (penyakit kronis lebih dari satu) sehingga kebutuhan obat meningkat

WHO sendiri menyatakan tidak ada definisi tunggal, tetapi penggunaan ≥ 5 obat adalah yang paling umum digunakan dalam praktik klinis (Jurnal medika dan psikologi Klinis)

2. Penyebab Polifarmasi pada lansia

Polifarmasia terjadi karena kombinasi faktor berikut:

- Faktor Pasien: Multimorbiditas (hipertensi, DM, jantung, dll), Penurunan fungsi organ (ginjal, hati) dan Gangguan kognitif
- Faktor Sistem pelayanan: Banyak dokter (fragmentasi pelayanan). Kurangnya evaluasi obat berkala dan *Self-medication* (obat bebas)
- Faktor Obat: Terapi simptomatik berlapis dan Duplikasi terapi

Lansia sering menerima obat kardiovaskular paling banyak (Taruma Negara Medical Journal tahun 2020 dari penelitian Sinaja, C. A., & Gunawan, S. (2020). Dampak Polifarmasi pada Lansia

- Dampak Klinis: *Adverse Drug Reaction* (ADR) meningkat. Interaksi obat tinggi (hingga 78,9% kasus) (Jurnal Universitas Padjadjaran), Penurunan fungsi organ. Hasil penelitian Sebastian, R. E., & Ikawati, Z. (2023). Repository Universitas Gadjah Mada.
- Dampak Fungsional: Risiko jatuh meningkat, Penurunan kualitas hidup, Gangguan kognitif
- Dampak Terapi: Kepatuhan minum obat menurun, Terapi tidak efektif, menurut penelitian Akmalsah, R. D., Probosuseno, & Nugrahaningsih, D. A. A. (2024). Pengaruh Polifarmasi terhadap Kepatuhan Konsumsi Obat pada Lansia: Systematic Review. Repository Universitas Gadjah Mada
- Dampak Psikologis: Dampak psikologis: Kompleksitas regimen obat akibat polifarmasi pada lansia dapat meningkatkan stres psikologis dan kecemasan karena lansia mengalami kekhawatiran terhadap keamanan obat, kesalahan penggunaan obat, serta kemampuan mengelola banyak obat (Geri & Kuswardhani, 2025) Kecemasan meningkat akibat kompleksitas obat.

3. Perubahan Farmakokinetik dan farmakodinamik pada lansia
 - a. Farmakokinetik: Absorpsi → relatif tetap, Distribusi → ↑ lemak, ↓ air, Metabolisme → ↓ fungsi hati, Ekskresi → ↓ fungsi ginjal
 - b. Farmakodinamik: Sensitivitas obat meningkat dan Respons tubuh tidak stabil
Akibatnya: dosis harus disesuaikan
4. Prinsip Pemberian obat pada lansia
Prinsip utama: "*Start low, go slow*"
 - a. Prinsip Rasional
 - 1) Indikasi jelas
 - 2) Obat sesuai diagnosis
 - 3) Evaluasi berkala
 - b. Prinsip Keamanan
 - 1) Hindari obat tidak perlu
 - 2) Perhatikan interaksi
 - 3) Gunakan dosis minimal efektif
 - c. Prinsip Kepatuhan
 - 1) Sederhanakan regimen obat
 - 2) Edukasi pasien & keluarga
5. Jenis Interaksi obat pada Lansia
 - a. Interaksi Farmakokinetik
 - 1) Absorpsi
 - 2) Distribusi
 - 3) Metabolisme
 - 4) Ekskresi
 - b. Interaksi Farmakodinamik
 - 1) Efek sinergis (memperkuat)
 - 2) Efek antagonis (melemahkan)

Contoh: Antihipertensi + diuretik → hipotensi berat dan Antikoagulan + NSAID → perdarahan
6. Obat yang sering menyebabkan Masalah Pada Lansia
 - a. Obat Kardiovaskular: Digoksin, Diuretik
 - b. Obat Sistem Saraf: Benzodiazepin, Antidepresan
 - c. Analgesik: NSAID
 - d. Antidiabetik: Sulfonilurea (risiko hipoglikemia)
7. Hubungan Polifarmasi dengan Sindrom Geriatri
Polifarmasi berkontribusi terhadap:
 - a. Delirium
 - b. Demensia
 - c. Jatuh (*fall risk*)

- d. Inkontinensia
- e. *Frailty* (kerapuhan)

Ini disebut sebagai *geriatric syndromes* yang saling berhubungan

8. Dampak Ekonomi Polifarmasi:

- a. Biaya pengobatan meningkat
- b. Rawat inap lebih sering
- c. Beban sistem kesehatan meningkat

Studi menunjukkan polifarmasi meningkatkan biaya kesehatan hingga 30 – 50%

9. Strategi Pencegahan Polifarmasi

- a. Untuk tenaga Kesehatan
 - 1) *Review* obat rutin
 - 2) Gunakan *guideline* (*Beers, STOPP/START*)
 - 3) Hindari prescribing cascade
- b. Untuk Pasien
 - 1) Bawa daftar obat saat kontrol
 - 2) Hindari self-medication berlebihan
- c. Sistem pelayanan
 - 1) Integrasi data pasien
 - 2) Kolaborasi multidisiplin

10. Perubahan Fisiologis lansia yang mempengaruhi obat

- a. Farmakokinetik:
 - Absorpsi relatif stabil, tetapi interaksi dengan makanan lebih sering.
 - Distribusi: peningkatan lemak tubuh → obat lipofilik bertahan lebih lama.
 - Metabolisme: penurunan fungsi hati → obat hepatik lebih lama dieliminasi.
 - Ekskresi: penurunan GFR → risiko toksisitas obat *renally-excreted* (misalnya aminoglikosida, digoksin).
- b. Farmakodinamik:
 - Sensitivitas meningkat terhadap obat tertentu (benzodiazepin, antikoagulan).
 - Respons menurun terhadap obat lain (β -adrenergic agonist).

11. Peran edukasi dan Ketelibatan Lansia

- a. Edukasi visual: tabel jadwal minum obat, kartu pengingat, infografis.
- b. Partisipasi keluarga: membantu kepatuhan dan pemantauan efek samping.
- c. Integrasi herbal & tradisional: perlu dicatat karena interaksi dengan obat modern (contoh: ginkgo biloba + antikoagulan → perdarahan).

12. Jenis obat yang tersering terlibat dalam polifarmasi adalah

- a. Kardiovaskular: antihipertensi, diuretik, antikoagulan.
- b. Endokrin: antidiabetes oral, insulin.

- c. Analgesik: NSAID, opioid.
- d. Psikotropika: antidepresan, benzodiazepin, antipsikotik.
- e. Suplementasi: vitamin, herbal, jamu (sering tidak tercatat dalam rekam medis)

B. Keselamatan obat pada lansia

1. Definisi Keselamatan Obat pada Lansia
 - a. Keselamatan obat adalah upaya memastikan penggunaan obat pada lansia tetap aman, efektif, dan rasional, dengan meminimalkan risiko efek samping, interaksi obat, serta kesalahan penggunaan.
 - b. Lansia merupakan kelompok rentan karena perubahan fisiologis, adanya penyakit kronis, dan sering mengalami polifarmasi.
2. Prinsip Utama Keselamatan Obat
 - a. 5 benar dalam pemberian obat: pasien benar, obat benar, dosis benar, cara pemberian benar, waktu benar.
 - b. *Medication review*: evaluasi berkala daftar obat oleh tenaga kesehatan.
 - c. *Deprescribing*: penghentian obat yang tidak lagi bermanfaat atau berisiko.
 - d. Monitoring: pemantauan efek samping, fungsi organ, dan kepatuhan pasien.
3. Faktor Risiko pada Lansia
 - a. Polifarmasi: penggunaan banyak obat sekaligus meningkatkan risiko interaksi.
 - b. Penurunan fungsi tubuh: ginjal, hati, dan sistem metabolisme melemah sehingga obat lebih lama bertahan.
 - c. Kognitif & kepatuhan: lansia sering lupa atau bingung dengan jadwal obat.
4. Tantangan Keselamatan Obat
 - a. Interaksi obat–obat: misalnya warfarin + antibiotik → perdarahan.
 - b. Interaksi obat–penyakit: NSAID memperburuk gagal jantung atau ginjal.
 - c. Kesalahan penggunaan: duplikasi terapi, dosis berlebih, atau penggunaan obat kontraindikasi.
 - d. Kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan: daftar obat tidak terintegrasi.
5. Strategi Peningkatan Keselamatan Obat

Strategi	Implementasi
<i>Medication reconciliation</i>	Menyatukan daftar obat dari semua dokter/apotek.
Deprescribing	Menghentikan obat yang tidak perlu.
Edukasi pasien & keluarga	Penjelasan sederhana, tabel jadwal minum obat.
Penggunaan teknologi	Rekam medis elektronik, aplikasi pengingat obat.
Kolaborasi interprofesional	Dokter, apoteker, perawat bekerja bersama.

Diagram alur keselamatan obat pada lansia yaitu

1. Resep (*Prescription*)

- a. Dokter memastikan prinsip *5 benar*: pasien benar, obat benar, dosis benar, cara pemberian benar, waktu benar.
- b. Tujuan: menghindari kesalahan awal dalam pemilihan obat.

2. Evaluasi (Medication Review & Reconciliation)

- a. Dilakukan secara rutin oleh dokter/apoteker.
- b. Menyatukan daftar obat dari berbagai sumber (dokter berbeda, apotek, obat herbal).
- c. Identifikasi masalah: duplikasi terapi, interaksi obat, obat yang tidak lagi relevan.

3. Monitoring

- a. Pemantauan efek samping, kepatuhan pasien, serta fungsi organ (ginjal, hati, jantung).
- b. Dilakukan berkala melalui pemeriksaan klinis dan laboratorium.
- c. Tujuan: mendeteksi dini reaksi obat yang merugikan (ADR) dan menyesuaikan dosis.

4. Edukasi

- a. Memberikan informasi yang jelas dan sederhana kepada pasien serta keluarga.
- b. Menggunakan media visual: tabel jadwal minum obat, kartu pengingat, infografis.
- c. Edukasi juga mencakup tanda-tanda efek samping yang harus segera dilaporkan.

5. Tindak Lanjut Berkala

- a. Proses ini bersifat siklus: setelah edukasi, pasien kembali dievaluasi secara berkala.
- b. Setiap kunjungan menjadi kesempatan untuk memperbarui daftar obat dan menyesuaikan terapi.

C. Kriteria Obat pada Lansia

Kriteria obat pada lansia sangat penting karena kelompok usia ini mengalami perubahan fisiologis (farmakokinetik & farmakodinamik) yang meningkatkan risiko efek samping, interaksi obat, kriteria obat pada Lansia

Prinsip Umum Pemberian Obat pada Lansia; beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu

- 1. *Start low, go slow* → mulai dosis rendah, tingkatkan perlahan *Go slow, go safe* → evaluasi efek dan keamanan secara berkala, Simplifikasi regimen obat →

hindari obat terlalu banyak (polifarmasi) dan Pertimbangkan fungsi organ → ginjal & hati menurun serta Evaluasi rutin → cek efek samping & interaksi obat

2. Perubahan Fisiologis pada lansia

Perubahan ini memengaruhi kerja obat:

Absorpsi: relatif tetap, tapi bisa terganggu jika ada penyakit

Distribusi: ↑ lemak tubuh, ↓ cairan → obat lipofilik bertahan lebih lama

Metabolisme (hati): menurun → obat lebih lama dimetabolisme

Ekskresi (ginjal): menurun → risiko toksisitas meningkat,

Contoh: obat seperti digoksin atau aminoglikosida bisa menumpuk jika fungsi ginjal menurun.

3. Kriteria Beers

Kriteria Beers (*Beers Criteria*), Digunakan untuk mengidentifikasi obat yang sebaiknya dihindari pada lansia, Kelompok obat yang perlu dihindari yaitu Antikolinergik (misal: diphenhydramine), Benzodiazepin (misal: diazepam), NSAID jangka panjang (misal: ibuprofen), Obat hipoglikemik tertentu (misal: glibenklamid).

Risiko: Delirium, Jatuh, Gangguan kognitif, Hipotensi

4. Kriteria STOPP & START

STOPP *START Criteria*, Digunakan untuk evaluasi terapi obat pada lansia :

a. STOPP (*Screening Tool of Older Person's Prescriptions*), Menilai obat yang tidak tepat / berisiko, Obat tanpa indikasi jelas, Duplikasi terapi Obat dengan efek samping tinggi

b. START (*Screening Tool to Alert to Right Treatment*), Menilai obat yang seharusnya diberikan tapi belum Contoh Lansia dengan gagal jantung → perlu ACE inhibitor dan Lansia osteoporosis → perlu kalsium/vitamin D

5. Kriteria Obat Rasional pada Lansia

Obat dikatakan rasional jika memenuhi Tepat indikasi, Tepat obat, Tepat dosis, Tepat cara pemberian, Tepat pasien, Tepat monitoring

6. Resiko yang harus diwaspadai

Pada lansia, penggunaan obat dapat menyebabkan Polifarmasi (≥5 obat), *Adverse Drug Reaction* (ADR), Interaksi obat, Sindrom geriatri (jatuh, delirium, inkontinensia)

Contoh obat yang perlu hati-hati pada lansia :

Golongan	Contoh	Risiko
Sedatif	Diazepam	Jatuh, sedasi
NSAID	Ibuprofen	Perdarahan lambung
Antidiabetik	Glibenklamid	Hipoglikemia
Antikolinergik	Amitriptilin	Bingung, delirium

D. Klasifikasi Polifarmasi

Berdasarkan Jumlah Obat

1. Non-polifarmasi: <5 obat
2. Polifarmasi: 5–9 obat
3. Polifarmasi berlebihan (excessive): ≥ 10 obat

Berdasarkan Kesesuaian

1. *Appropriate polypharmacy* → obat sesuai indikasi & bermanfaat
2. *Inappropriate polypharmacy* → obat tidak perlu / berisiko tinggi

Tidak semua polifarmasi itu buruk, yang berbahaya adalah yang tidak rasional.

E. Faktor Resiko Polifarmasi pada Lansia

1. Faktor demografi
 - a. Usia lanjut (>75 tahun)
 - b. Perempuan lebih berisiko
2. Faktor Klinis
 - a. Penyakit kronis multipel (DM, hipertensi, gagal jantung)
 - b. Gangguan kognitif (demensia)
 - c. Depresi
3. Faktor sosial
 - a. Tinggal sendiri
 - b. Kurangnya edukasi kesehatan
4. Faktor Sistem
 - a. *Overprescribing* oleh tenaga kesehatan
 - b. Kurangnya *medication review*

F. Alat Skrining Polifarmasia

1. Beers *Criteria* (American Geriatrics Society), Digunakan untuk:
Mengidentifikasi obat berisiko tinggi Contoh:
Benzodiazepin → risiko jatuh

NSAID → risiko perdarahan GI

2. STOPP (*Screening Tool of Older Person's Prescriptions*), Digunakan untuk Menilai obat yang harus dihentikan
3. START (*Screening Tool to Alert to Right Treatment*), Digunakan untuk menilai obat yang seharusnya diberikan tetapi belum
4. Medication Appropriateness Index (MAI), Menilai :
 - a. Indikasi
 - b. Efektivitas
 - c. Dosis
 - d. Interaksi

G. Peran Tenaga Kesehatan

1. Perawat
 - a. Monitoring efek samping
 - b. Edukasi pasien
 - c. Evaluasi kepatuhan
2. Dokter
 - a. Menentukan terapi rasional
 - b. Review obat berkala
3. Apoteker
 - a. Mengidentifikasi interaksi obat
 - b. Konseling obat
 - c. Kolaborasi tim sangat penting untuk keselamatan pasien (Journal of Medula)

H. Evidence Base Polifarmasi pada Lansia

1. *Systematic Review & Meta-analysis* (2024)
 - a. Studi: Wang et al., 2024 (Pharmacoepidemiology and Drug Safety)
 - b. Desain: *Systematic review* + meta-analisis (122 studi, >57 juta lansia)

Hasil utama:

- a. Prevalensi polifarmasi (≥ 5 obat): 39,1%
- b. Hyperpolypharmacy (≥ 10 obat): 13,3%

Lebih tinggi pada:

- a. Usia ≥ 70 tahun
- b. Lansia di panti/nursing home
- c. Wilayah Eropa & Amerika Utara (PubMed)

Makna klinis : Polifarmasi adalah fenomena global yang sangat umum pada lansia.

2. Dampak Polifarmasi Terhadap *Outcome* Kesehatan

a. Systematic Review (2023 – Ageing Research Reviews)

Lansia dengan polifarmasi memiliki: Risiko penurunan fungsi, Risiko *frailty* dan lebih tinggi serta *Outcome* kesehatan lebih buruk (ScienceDirect, 2023)

b. Studi Malaysia (*Community-based*) ;

Polifarmasi berhubungan dengan:

- 1) Peningkatan mortalitas
- 2) Risiko jatuh
- 3) Disabilitas fungsional
- 4) Interaksi obat (DDI) (PMC)

3. Polifarmasi dan kebutuhan minum Obat

a. Systematic Review (UGM, 2024)

Sampel: 9.376 lansia, Hasil: 8 dari 11 studi menunjukkan:

Polifarmasi → menurunkan kepatuhan minum obat

Rentang obat: 5–10 jenis obat (Repository UGM, 2024)

Makna: Semakin banyak obat: Lansia semakin sulit patuh dan Risiko terapi gagal meningkat

b. *Evidence* di Indonesia

1) Studi RS Universitas Airlangga (2023)

Sampel: 1.533 lansia rawat inap

Hasil: 8,67% mengalami *excessive polypharmacy*

Faktor risiko: Penyakit kronis (kanker, ginjal, ulkus)

Lama rawat inap >3 hari

2) Studi Jakarta (2025)

Desain: *Cross-sectional*

Hasil: Polifarmasi sering terjadi karena Multimorbiditas

Dampak: Interaksi obat

Efek samping meningkat (Jurnal Untar)

3) Studi Panti Wreda (Indonesia)

Prevalensi: 51,89% lansia mengalami polifarmasi

Obat terbanyak: Kardiovaskular (Jurnal Untar)

4) Meta-analysis Diabetes (2025)

Prevalensi polifarmasi: 59%

Risiko: Interaksi obat

Efek samping Hospitalisasi meningkat (PMC)

5) Polifarmasi sangat sering terjadi pada lansia ($\pm 30\text{--}60\%$)

Penyebab utama:

Multimorbiditas Perawatan jangka panjang

Dampak utama: Interaksi obat, Efek samping meningkat dan Penurunan kepatuhan, Risiko jatuh & mortalitas

Faktor risiko: Usia lanjut, Penyakit kronis, Lama rawat inap

c. Implikasi *evidence base* Keperawatan

Berdasarkan penelitian, perawat harus:

- 1) Melakukan *medication review* rutin,
- 2) Mengidentifikasi: Obat tidak perlu dan Duplikasi terapi
- 3) Edukasi pasien:
 - Kepatuhan minum obat
 - Kolaborasi dengan dokter:
 - Deprescribing* (mengurangi obat)

I. Latihan Soal

1. Dampak Psikologis polifarmasia pada lansia adalah :

- A. Risiko jatuh meningkat,
- B. Penurunan kualitas hidup,
- C. Gangguan kognitif
- D. Peningkatan kesehatan
- E. Kecemasan meningkat akibat kompleksitas obat

2. Prinsip pemberian obat pada lansia khususnya prinsip keamanan adalah :

- A. Gunakan dosis minimal efektif
- B. Indikasi jelas
- C. Obat sesuai diagnosis
- D. Evaluasi berkala
- E. Sederhanakan regimen obat

3. Jenis interaksi farmakodinamik pada lansia adalah :

- A. Absorpsi
- B. Efek antagonis
- C. Metabolisme
- D. Ekresi
- E. Distribusi

4. Hubungan Polifarmasi dengan Sindrom Geriatri, Polifarmasi berkontribusi terhadap terhadap saluran kemih yaitu:

- A. Delirium
 - B. Demensia
 - C. Jatuh (*fall risk*)
 - D. Inkontinensia
 - E. *Frailty* (kerapuhan)
5. Strategi pencegahan polifarmasi untuk pasien adalah :
- A. Bawa daftar obat saat kontrol
 - B. Review obat rutin
 - C. Gunakan guideline (Beers, STOPP/START)
 - D. Hindari prescribing cascade
 - E. Kolaborasi multidisiplin

Kunci Jawaban

- 1. E
- 2. A
- 3. B
- 4. D
- 5. A

J. Rangkuman Materi

Polifarmasi sangat sering terjadi pada lansia ($\pm 30\text{--}60\%$). Penyebab utama Multimorbiditas, Perawatan jangka panjang dan Dampak utama Interaksi obat serta Efek samping meningkat serta Penurunan kepatuhan. Risiko jatuh & mortalitas: Faktor risiko : Usia lanjut, penyakit kronis, dan Lama rawat inap.

Polifarmasi adalah kondisi kompleks pada lansia, Risiko utama Interaksi obat Efek samping Penurunan kualitas hidup, Penanganan: *Medication review* *Deprescribing* dan Kolaborasi tim. Polifarmasi adalah fenomena umum pada lansia dengan risiko tinggi terhadap keselamatan obat. Pendekatan sistematis meliputi evaluasi obat, *deprescribing*, monitoring, edukasi, dan kolaborasi interprofesional.

Regulasi internasional (Beers, STOPP/START) dan nasional (Kemenkes RI, 2016) menjadi panduan penting. Edukasi pasien dan keluarga adalah kunci keberhasilan manajemen polifarmasi. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

K. Glosarium

Edukasi: Segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Practice (EBP): Penggunaan bukti ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan

Gerontologi: Studi ilmiah tentang proses dan masalah penuaan dari semua aspek—biologis, klinis, psikologis, sosiologis, hukum, ekonomi, dan politik

Geriatrici: Cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan, diagnosis, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang menyerang kalangan lansia.

Holistik: Cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan.

Health Promotion: Segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif.

L. Referensi

Akmalsah RD (2024). Polifarmasi dan kepatuhan obat lansia. UGM.

Annet G.I. (1996), *Gerontologic Nursing*, St. Louise Mosby Book Inc
Chenitz W.C. Stone J.T. and Salisbury S.A. (1991) *Clinical Gerontological Nursing: A Guide to Advanced Practice* Philadelphia : WB Saunders Company

Awali, J. D., Pardilawati, C. Y., Soleha, T. U., & Oktarlina, R. Z. (2024). Kajian Polifarmasi terhadap Keamanan Obat pada Pasien Geriatrici. *Medical Profession Journal of Lampung (MEDULA)*, 14(4)

BMC Geriatrics (2022). Factors associated with polypharmacy

Dasopang, E. S., Harahap, U., & Lindarto, D. (2015). Polifarmasi dan interaksi obat pasien usia lanjut rawat jalan dengan penyakit metabolik. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 4(4), 235–241.
<https://doi.org/10.15416/ijcp.2015.4.4.235>

Eliopoulos, C.E. 2005. *Gerontological nursing*. (6 th ed.), Philadelphia; Lippincott.

Eliopoulos, Chariotte, 2005. *Gerontologic Nursing*, 6th edition, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins

Faisal, S., Zairina, E., Nathishuwan, S., Khotib, J., Kristina, S. A., & Nugraheni, G. (2023). Prevalence and predictors of excessive polypharmacy in geriatric inpatients: A retrospective cross-sectional study in Indonesia. *Journal of Primary Care & Community Health*, 14, 1–9.
<https://doi.org/10.1177/21501319231178595>.

- Geri, S. J., & Kuswardhani, R. A. T. (2025). Polypharmacy and anxiety in elderly: A narrative comprehensive review. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(3). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
- Kozier et al., (1995). Fundamental of nursing. Concepts, process, and practice.
- Nur fadhilah dkk (2024), Buku Ajar keperawatan Gerontik, Nuasa Fajar Cemerlang
- Polakitang, S. T., & Kosasih, R. (2024). Gambaran Polifarmasi pada Lansia di RS Royal Taruma Jakarta Tahun 2020–2022. Jurnal Muara Medika dan Psikologi Klinis, 4(1), 35–40. Universitas Tarumanagara
- Sebastian, R. E., & Ikawati, Z. (2023). Evaluasi Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat Beberapa Rumah Sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta. Repository Universitas Gadjah Mada.
- Sinaja, C. A., & Gunawan, S. (2020). Polifarmasi pada lansia di Panti Wreda: Fokus pada penggunaan obat kardiovaskular. Tarumanagara Medical Journal, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2020, halaman 430–436
- Toh JY et al., (2023). Polypharmacy and health outcomes in frail older adults. Ageing Research Reviews.
- Wang Z et al., (2024). Prevalence of Polypharmacy in Elderly Population. Pharmacoepidemiol Drug Saf.

PROFIL PENULIS



Ns. Dewi Srimauli Simorangkir, M.Kep., lahir di Cianjur pada 17 Desember. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh penulis meliputi Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di STIKes Santo Borromeus Bandung dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Indonesia dengan peminatan Keperawatan Gerontik dan lulus pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai dosen di STIKes Santo Borromeus Bandung hingga tahun 2022. Pada tahun pertama masa kerja,

penulis mengikuti program internship di RS Santo Borromeus, RS Cahya Kawaluyan, dan RS Santo Yusup sebagai bagian dari pengembangan kompetensi klinik. Saat ini penulis bekerja di STIKes Widya Dharma Husada Tangerang mengampu mata kuliah Keperawatan Gerontik, Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif, dan Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, penulis terlibat dalam kegiatan pembelajaran, penyusunan bahan ajar dan perangkat pembelajaran, serta pembimbingan mahasiswa. Dalam bidang penelitian, penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya dalam bidang keperawatan gerontik dengan fokus pada risiko jatuh dan gangguan muskuloskeletal pada lansia. Penulis juga berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program promotif dan preventif bagi lansia dan masyarakat, serta aktif mengikuti seminar, pelatihan, dan kegiatan ilmiah untuk mendukung pengembangan kompetensi profesional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewisrimauli@gmail.com

Motto: "Grow with grace, live with purpose"

PROFIL PENULIS



Friska Br Sembiring, S.Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Batam, 18 September 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Sumatera Utara tahun dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan, Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 bekerja sebagai perawat pelaksana di sebuah Rumah Sakit Swasta di Kota

Medan. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Santa Elisabeth Medan mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah (Keperawatan Dewasa), Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Gawat Darurat Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis Buku kumpulan soal uji kompetensi Ners dan Buku Ajar Gerontik, selain itu penulis juga aktif meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat di bidang Keperawatan Medikal Bedah dan gerontik terkait dengan penyakit stroke, hipertensi dan gagal ginjal kronik dan di publikasi di jurnal bereputasi nasional/terakreditasi SINTA). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: friskakembaren09@gmail.com
Motto: "Hati yang Gembira Adalah Obat, Tetapi Semangat yg Patah Meringkakan Tulang"



Ns. Destria Efliani, S.Kep., MM., M.Kep., Lahir di Concong Luar, 31 Desember. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi di Universitas Respati Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan peminatan Administrasi Rumah Sakit dan lulus pada Tahun 2014, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Peminatan Keperawatan Komunitas dan lulus Tahun 2026. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 sebagai dosen Ilmu Keperawatan. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan dan

Teknologi Al Insyirah Pekanbaru. Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah mengampu mata kuliah Falsafah dan Teori dalam Keperawatan, Komunikasi Terapeutik Keperawatan, Epidemiologi dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: destria.efliani@ikta.ac.id

Motto: "Belajar untuk bertumbuh, mendidik untuk mengubah dunia".

PROFIL PENULIS



Septi Ardianty, S.Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Palembang, 13 September 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan STIK Bina Husada Palembang. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran Palembang program studi magister keperawatan dan lulus pada Tahun 2014. Penulis memiliki pengalaman klinik sebagai staff nurse berkerja di rumah sakit di Saudi Arabia dari tahun 2006 – 2010. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang.

mengampu mata kuliah Promosi dan Pendidikan Kesehatan, Psikososial Budaya dalam Keperawatan, Konsep Keperawatan Komunitas, Keperawatan Agregat Komunitas, Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: septibudi2@gmail.com

Motto: "Syukuri yang kita miliki dan melakukan yang terbaik".



Ns. Deni Metri, S.Kep., M. Kes., Penulis menyelesaikan DIII Keperawatan pada Akper Depkes Tanjungkarang Lampung Pada tahun 1996, dan Pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas tahun 2004, kemudian melanjutkan Pendidikan Program Pasca sarjana S2 di Universitas Mitra Lampung tahun 2016. Riwayat pekerjaan, Dari tahun 1997 s. d 1998, sebagai pengajar di Akper Panca Bhakti Lampung. Pada

tahun 1998 - 2014 di Dinkes Lampung Utara. Tahun 2014 sampai dengan saat ini penulis adalah dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang Program Studi Keperawatan Kotabumi. Mata kuliah yang diampu adalah Keperawatan dasar, Keperawatan gerontik, Keperawatan anak, Etika Keperawatan. Penulis adalah anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) propinsi Lampung. Selain melakukan penelitian, penulis juga aktif dalam penerbitan buku antara lain Buku Ajar keperawatan Gerontik, Buku ajar Keperawatan Gerontik untuk D III Keperawatan, Konsep Dasar Perawatan Lansia, Penyakit Umum pada lansia dan manajemennya, Latihan Soal Etik Edisi Etikolegal, Keperawatan Dasar: Kebutuhan Dasar Manusia menurut Handerson & asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pendekatan SDKI, SLKI dan SIKI PPNI. Buku Ajar Keperawatan Anak, Asuhan Keperawatan Akut pada Anak, Asuhan Keperawatan anak dengan Penyakit Kronis. Semua yang sudah dilakukan penulis, dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail denimetri88@gmail.com.

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Gerontik hadir sebagai sumber pembelajaran yang membantu mahasiswa keperawatan memahami berbagai masalah kesehatan kompleks pada lanjut usia sekaligus mengembangkan kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, holistik, dan berorientasi pada kemandirian lansia.

Buku ini membahas berbagai sindrom dan permasalahan penting dalam keperawatan gerontik, meliputi frailty, sarcopenia, dan risiko disabilitas; delirium; ulkus tekan dan perawatan kulit; malnutrisi, dehidrasi, serta gangguan menelan (*dysphagia*); hingga polifarmasi dan keselamatan obat pada lansia. Setiap pembahasan diarahkan pada proses pengkajian, identifikasi masalah dan risiko, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, evaluasi, edukasi kepada lansia dan keluarga, serta kolaborasi interprofesional.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang mengintegrasikan CPL, CPMK, studi kasus, aktivitas *Knows How* dan *Shows How*, OSCE, SOP keterampilan, DOPS, portofolio, *case report*, refleksi *patient safety*, serta identifikasi *red flags* dan tindakan eskalasi. Pendekatan ini membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan situasi klinis serta membangun kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, komunikasi terapeutik, dan profesionalisme.

Dengan penyajian yang aplikatif dan berorientasi pada keselamatan pasien, buku ini diharapkan menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam meningkatkan kualitas asuhan kepada lanjut usia serta mendukung terwujudnya pelayanan gerontik yang komprehensif, humanis, dan bermutu.

Buku Ajar Keperawatan Gerontik hadir sebagai sumber pembelajaran yang membantu mahasiswa keperawatan memahami berbagai masalah kesehatan kompleks pada lanjut usia sekaligus mengembangkan kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, holistik, dan berorientasi pada kemandirian lansia.

Buku ini membahas berbagai sindrom dan permasalahan penting dalam keperawatan gerontik, meliputi frailty, sarcopenia, dan risiko disabilitas; delirium; ulkus tekan dan perawatan kulit; malnutrisi, dehidrasi, serta gangguan menelan (dysphagia); hingga polifarmasi dan keselamatan obat pada lansia. Setiap pembahasan diarahkan pada proses pengkajian, identifikasi masalah dan risiko, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, evaluasi, edukasi kepada lansia dan keluarga, serta kolaborasi interprofesional.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang mengintegrasikan CPL, CPMK, studi kasus, aktivitas Knows How dan Shows How, OSCE, SOP keterampilan, DOPS, portofolio, case report, refleksi patient safety, serta identifikasi red flags dan tindakan eskalasi. Pendekatan ini membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan situasi klinis serta membangun kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, komunikasi terapeutik, dan profesionalisme.

Dengan penyajian yang aplikatif dan berorientasi pada keselamatan pasien, buku ini diharapkan menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam meningkatkan kualitas asuhan kepada lanjut usia serta mendukung terwujudnya pelayanan gerontik yang komprehensif, humanis, dan bermutu.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-13-2 (PDF)

